Olaf Tannenberg

Adelheidstraße 17 · 24103 Kiel

Telefon 0431 774218 · olaf.tannenberg@privatpost.de

Versichertennummer N123-456-789-Z

Nordsee-BKK

Leistungsabteilung Hilfsmittel

Wall 55

24103 Kiel

Datum: 11. Februar 2026 **Aktenzeichen:** Versichertennummer N123-456-789-Z

Antrag auf Versorgung mit einem Leichtgewicht-Aktivrollstuhl

1. Antrag

Ich beantrage die Versorgung mit einem Leichtgewicht-Aktivrollstuhl Quickie Helium oder einem gleich geeigneten Modell nach der beigefügten ärztlichen Verordnung vom 9. Februar 2026.

2. Alltag

Ich leide seit 1998 an Multipler Sklerose, aktuell mit ausgeprägter Schwäche der linken Hand. Einen Standardrollstuhl kann ich wegen Gewicht und ungleicher Armkraft nicht selbstständig antreiben. Der Weg von meiner Wohnung im zweiten Obergeschoss mit Aufzug bis zum Briefkasten beträgt 47 Meter. Ohne geeigneten Rollstuhl bin ich dabei auf meine Ehefrau oder Nachbarn angewiesen.

3. Erprobung

Im Sanitätshaus konnte ich den beantragten Aktivrollstuhl auf gerader Strecke und beim Wenden selbst bedienen. Mit dem dort vorhandenen Standardmodell brach ich die Erprobung nach weniger als fünf Metern ab. Das Sanitätshaus hat Maße, Greifreifenposition und Sitzbreite aufgenommen.

4. Anlagen

Ärztliche Verordnung Dr. Annette Wallenstein vom 9. Februar 2026; Kostenvoranschlag Reha-Aktiv Nord GmbH vom 10. Februar über 5847,00 EUR; Erprobungsbogen und Wohnungsmaße.

Olaf Tannenberg
Versicherter

Nordsee-BKK

Wall 55 · 24103 Kiel

Telefon 0431 5800-0 · hilfsmittel@nordsee-bkk.de

Leistungsabteilung Hilfsmittel · Team H3

Herrn Olaf Tannenberg

Adelheidstraße 17

24103 Kiel

Datum: 22. März 2026 **Aktenzeichen:** 2026-HM-04421-T / N123-456-789-Z

Ihr Antrag auf einen Aktivrollstuhl: ergänzende Unterlagen

1. Bisheriger Stand

Ihr Antrag vom 11. Februar mit Verordnung und Kostenvoranschlag ist am 15. Februar eingegangen. Wir haben die Unterlagen dem Medizinischen Dienst Nord zur sozialmedizinischen Beratung zugeleitet. Für eine abschließende Entscheidung fehlen noch Angaben zum konkreten Gebrauchsvorteil des beantragten Modells.

2. Benötigte Unterlagen

Bitte reichen Sie eine ärztliche funktionelle Begründung ein, weshalb ein Standardrollstuhl in Ihrer Wohn- und Alltagssituation nicht selbstständig genutzt werden kann. Benötigt werden außerdem Wohnungs- und Wegmaße, Erprobungsprotokoll, Angaben zur Greif- und Armkraft sowie eine Stellungnahme des Sanitätshauses zur Sitz- und Antriebsanpassung.

3. Frist

Bitte übersenden Sie die Unterlagen bis 14. April 2026 unter Angabe unseres Zeichens. Sollten Unterlagen erst später erhältlich sein, teilen Sie uns dies vor Fristablauf mit. Eine Ablehnung ist mit diesem Schreiben nicht verbunden.

Klaudia Mertens
Sachbearbeiterin Hilfsmittelversorgung

Olaf Tannenberg · Praxis Dr. med. Annette Wallenstein

Adelheidstraße 17 · 24103 Kiel

Neurologische Praxis: Holtenauer Straße 312 · 24107 Kiel

Telefon Praxis 0431 88914-0

Nordsee-BKK

Frau Klaudia Mertens

Wall 55

24103 Kiel

Datum: 30. März 2026 **Aktenzeichen:** 2026-HM-04421-T

Ergänzende Unterlagen zum Antrag auf Aktivrollstuhl

1. Erklärung des Versicherten

Mit einem Standardrollstuhl konnte ich mich bei der Erprobung nicht selbstständig fortbewegen. Die linke Hand rutschte am Greifreifen ab, nach weniger als fünf Metern musste ich anhalten. Mit dem angepassten Aktivrollstuhl fuhr ich die Strecke im Sanitätshaus und bis zum Briefkasten selbstständig. Ich bitte um Berücksichtigung der beigefügten Maße und des Erprobungsbogens.

2. Ärztliche Stellungnahme

Herr Tannenberg leidet an progredienter Multipler Sklerose mit einem EDSS von 6,5 und ausgeprägter Hemiparese links. Die gemessene Handkraft links beträgt 7,2 Kilogramm. Ein schwerer Standardrollstuhl kann nicht wirksam und ausdauernd angetrieben werden. Die individuelle Sitz- und Greifreifenposition des Aktivrollstuhls reduziert den erforderlichen Kraftaufwand und ermöglicht eigenständige Nahmobilität.

3. Wohnumfeld

Die Wohnung ist per Aufzug erreichbar. Vom Aufzug bis zur Haustür sind 19 Meter, von dort bis zum Briefkasten weitere 28 Meter zurückzulegen. Die Haustür hat eine lichte Breite von 92 Zentimetern. Das beantragte Modell wurde auf Durchfahrt und Wendung erprobt.

4. Anlagen

Neurologischer Befund vom 25. März 2026; Erprobungsprotokoll Reha-Aktiv Nord; Wohnungs- und Wegemaße; Reha-Bericht Ostseeklinik Damp vom August 2024.

Olaf Tannenberg · Dr. med. Annette Wallenstein
Versicherter · Fachärztin für Neurologie

Olaf Tannenberg · N123-456-789-Z
Nach Untersuchung am 13. August 2026
Kiel, 14. August 2026

Ärztliche Verlaufsmitteilung zur Mobilität

1 Anlass

Herr Tannenberg kam zur Verlaufskontrolle in Begleitung seiner Tochter. Nach seinen Angaben sind seit der letzten Befunderhebung weniger Wege in der Nachbarschaft möglich. Er berichtet über vermehrte Anspannung vor Transfers und kürzere Gehabschnitte innerhalb der Wohnung. Im Arztzimmer war er zeitlich und örtlich orientiert. Die Verständigung war trotz verlangsamter Sprache möglich. Die Aussage zur Häufigkeit der Wege beruht auf den Angaben des Patienten und seiner Tochter.

2 Befund im Vergleich zur Untersuchung im Mai

Beim Aufstehen aus dem Leihrollstuhl brauchte Herr Tannenberg zwei Anläufe und eine erreichbare Armstütze. Die linksbetonte Kraftminderung bestand fort. Nach wenigen Schritten bei persönlicher Sicherung traten deutliches Schwanken und Ermüdung ein. Ein längerer Gehversuch war wegen Sturzgefahr und fehlender ausreichender Sicherungsmöglichkeit nicht angezeigt. Die Beobachtung trägt keine Aussage über eine konkrete maximale Strecke im Straßenverkehr. Für die Hilfsmittelfrage ist vor allem die Kombination aus geringer Gehfunktion und eingeschränkter wiederholter Bewegung der linken Hand relevant.

Die aktuelle Befundlage spricht für eine zeitnahe Hilfsmittelerprobung mit möglichst eigenständig steuerbarer Lösung. Längerer Bewegungsmangel kann die funktionelle Ausgangslage und die Teilhabe weiter beeinträchtigen. Eine konkrete Geschwindigkeit oder ein sicherer Einsatzbereich kann aus der Untersuchung im Arztzimmer nicht abgeleitet werden. Ich befürworte eine beaufsichtigte praktische Erprobung mit bedarfsgerecht angepasstem Sitz, erreichbarer Bremse und Bedienung von rechts. Der sichere Ablauf von Transfer und Fahrt in der tatsächlichen Umgebung ist vor der Abgabe zu dokumentieren.

Dr. med. Annette Wallenstein

Dr. med. Annette Wallenstein · Fachärztin für Neurologie
MS-Schwerpunktpraxis Kiel-Holtenau | Holtenauer Straße 312, 24107 Kiel | Telefon 0431 8711-0

Patient	Olaf Tannenberg, geboren am 17. Februar 1964
Behandlungsnummer	WN-2026-0147
Versichertennummer	N123-456-789-Z
Datum	5. Mai 2026

Nordsee-BKK
Leistungsabteilung Hilfsmittel
Westring 472
24114 Kiel

Fachärztliche Stellungnahme zur Aktivrollstuhlversorgung

Sehr geehrte Damen und Herren, in oben genannter Angelegenheit nehme ich als behandelnde Fachärztin ergänzend Stellung. Ich betreue Herrn Tannenberg seit dem Jahr 2014 in meiner MS-Schwerpunktpraxis. Der aktuelle Ablehnungsbescheid Ihrer Kasse vom 18. April 2026 gibt Anlass zu erheblichem Widerspruch, da er auf einer unzutreffenden Einschätzung der tatsächlichen motorischen Fähigkeiten des Patienten beruht.

Klinischer Befund (Stand 28. April 2026)

Parameter Befund Diagnose Multiple Sklerose (G35), schubförmig-progredient, ED 1998 Aktueller EDSS 6,5 (Gehen mit beidseitiger Hilfe < 20 m möglich) Verlauf seit 2022 Kontinuierliche klinische Verschlechterung, zuletzt Schub August 2024 mit bleibenden Defiziten Motorik rechts Arm: MRC 4/5, Bein: MRC 3/5, Spastik Grad 2 nach Ashworth Motorik links (Hemiparese) Arm: MRC 3/5 (deutlich schwächer), Bein: MRC 2+/5, Spastik Grad 3 nach Ashworth Handkraft links (Jamar) 7,2 kg (re: 18,4 kg) – Normwert Mann 62 J. ca. 38 kg Gangbild Breitbeinig, ataktisch, Rollator erforderlich, max. Gehstrecke 15 m mit Pausen, erhebliches Sturzrisiko (Fall-Score nach Morse: 75 – hohes Risiko)

Rollstuhlnutzung aktuell Überwiegend (>80% der Wachzeit) auf Rollstuhl angewiesen Fatigue CFS-Score 52/63 – schwere MS-Fatigue, jeder körperliche Mehraufwand führt zu Erschöpfung Blasenfunktion Neurogene Blasenentleerungsstörung, Selbstkatheterisierung (SIK) 4x/Tag Kognition Leichte kognitive Verlangsamung (SDMT: 36 Punkte), kein Einfluss auf Geschäftsfähigkeit

Fachärztliche Beurteilung

1. Zur Begründung des Ablehnungsbescheides:

Die Begründung, der Patient könne "alle Räume mit Rollator erreichen", verkennt die klinische Realität. Die maximale Gehstrecke beträgt unter 15 m. Alle Wege außerhalb der Wohnung sind für Herrn Tannenberg ohne Rollstuhl nicht erreichbar. Die Fähigkeit, eine Wohnung mit dem Rollator zu durchqueren, begründet keinen Ausschluss vom Anspruch auf einen bedarfsgerechten Rollstuhl.

2. Zur Ungeeignetheit des Standard-Rollstuhls:

Ein Standard-Kassenmuster-Rollstuhl (typisch 16–18 kg) kann von Herrn Tannenberg aufgrund der ausgeprägten linksseitigen Hemiparese (MRC 3/5 Arm, Handkraft 7,2 kg) nicht selbstständig angetrieben werden. Der Einsatz eines Standard-Rollstuhls würde vollständige Pflegeabhängigkeit beim Fortbewegen bedeuten und ist daher nicht ausreichend im Sinne der Hilfsmittelversorgung. Selbstfahren ist Voraussetzung für die Selbstversorgung (Arztbesuche, Einkauf, Toilettengang in der Nacht).

3. Aktivrollstuhl als medizinische Notwendigkeit:

Der beantragte Aktivrollstuhl Quickie Helium (8,4 kg) ist mit dem linken Arm in Verbindung mit dem stärkeren rechten Arm antreibbar. Klinische Erfahrung aus dem Reha-Bericht der Ostseeklinik Damp

(August 2024) sowie meine Praxisbeobachtungen belegen: Herr Tannenberg kann mit einem Leichtgewicht-Aktivrollstuhl eigenständig kurze Strecken zurücklegen, was mit einem Standard-Rollstuhl nicht möglich ist.

4. Sturzgefahr:

Der Morse-Fall-Score von 75 (hohes Sturzrisiko) belegt, dass jedes Fortbewegen ohne adäquates Hilfsmittel eine erhebliche Gesundheitsgefährdung darstellt. Ohne

Aktivrollstuhl kommt es regelmäßig zu Stürzen beim Gehen.

5. Soziale Teilhabe:

Das Ziel der Hilfsmittelversorgung (Paragraf 33 SGB V i.V.m. Paragraf 33 SGB IX) schließt soziale Teilhabe ausdrücklich ein. Die Selbstbestimmung des Patienten – Apotheke, Briefkasten, Kontakt zu Nachbarn – setzt voraus, dass er sich außerhalb der Wohnung bewegen kann.

Nur der Aktivrollstuhl macht dies möglich.

Zusammenfassung

Die Versorgung mit dem Aktivrollstuhl Quickie Helium ist nach meiner fachärztlichen Einschätzung zwingend medizinisch notwendig. Ein Standard-Rollstuhl ist wegen des Gewichts und der einseitigen Hemiparese links nicht selbstständig nutzbar. Der MDK-Gutachter Dr. Steffens hat diesen zentralen Aspekt in seinem Aktengutachten nicht ausreichend gewürdigt. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass ein Aktengutachten ohne persönliche Untersuchung des Patienten die tatsächliche Kraftminderung nicht erfassen kann.

Ich stehe für Rückfragen oder eine ergänzende Untersuchung im Widerspruchsverfahren selbstverständlich zur Verfügung.

Dr. med. Annette Wallenstein
Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie

Nordsee-BKK · Leistungsabteilung Hilfsmittel
Westring 472, 24114 Kiel | Telefon 0431 5800-0 | Fax 0431 5800-199

Aktenzeichen	2026-HM-04421-T
Versichertennummer	N123-456-789-Z
Datum	18. April 2026
Sachbearbeitung	Klaudia Mertens, Durchwahl 342

Herrn Olaf Tannenberg
Adelheidstraße 17
24103 Kiel

Ablehnung des Antrags auf Versorgung mit einem Aktivrollstuhl

Sehr geehrter Herr Tannenberg, mit Schreiben vom 11. Februar 2026 haben Sie die Versorgung mit dem Aktivrollstuhl Quickie Helium (individuell konfiguriert) gemäß Kostenvoranschlag des Sanitätshauses Reha-Aktiv Nord GmbH vom 10. Februar 2026 in Höhe von 5.847,00 EUR (brutto) beantragt. Grundlage war die vertragsärztliche Verordnung (Muster 16) Ihrer behandelnden Neurologin Dr. med. Annette Wallenstein, MS-Schwerpunktpraxis Kiel-Holtenau, vom 09. Februar 2026.

Wir haben Ihren Antrag geprüft und ein Gutachten des Medizinischen Dienstes (MD Nord) eingeholt. Nach eingehender Prüfung sind wir zu dem Ergebnis gelangt, dass die Voraussetzungen für die Versorgung mit dem beantragten Aktivrollstuhl nicht vorliegen.

Entscheidung

Ihr Antrag auf Versorgung mit dem Aktivrollstuhl Quickie Helium wird abgelehnt.

Begründung

Gemäß Paragraf 33 Abs. 1 SGB V haben Versicherte Anspruch auf Versorgung mit Hilfsmitteln, die im Einzelfall erforderlich sind, um den Erfolg der Krankenbehandlung zu sichern, einer drohenden Behinderung vorzubeugen oder eine Behinderung auszugleichen, soweit die Hilfsmittel nicht als allgemeine Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens anzusehen sind. Der Anspruch umfasst grundsätzlich nur solche Hilfsmittel, die im Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbandes gelistet sind.

Das Gutachten des MD Nord vom 03. April 2026 (Gutachter: Dr. med. Henning Steffens) kommt zu folgendem Ergebnis:

(1) Ihre Wohnung in der Adelheidstraße 17, 2. OG, ist mit einem Aufzug erschlossen und als barrierefrei eingestuft. Alle Wohnräume sind mit dem verfügbaren Rollator erreichbar.

(2) Ein Standard-Rollstuhl aus dem Kassensortiment (Hilfsmittelverzeichnis Pos.

18.50.01.0xxx) steht zur Grundversorgung zur Verfügung und ist für den festgestellten

Versorgungsbedarf ausreichend.

(3) Ein Aktivrollstuhl (Pos. 18.50.04.0xxx) ist nach den Versorgungsrichtlinien des GKV-Spitzenverbandes vorrangig für Versicherte mit erhöhtem Mobilitätsbedarf indiziert, insbesondere für erwerbstätige Versicherte, Rollstuhlsportler oder Versicherte, die den Rollstuhl als einziges Fortbewegungsmittel im Berufsleben einsetzen.

(4) Beim Versicherten liegt eine Erwerbsminderungsrente (EU-Rente) seit 2022 vor. Ein berufsbedingter Bedarf an besonderer Mobilität wurde nicht dargelegt.

(5) Der Kostenvoranschlag überschreitet die vertraglichen Festbeträge erheblich. Der Aufpreis für Carbon-Felgenpolster, Anti-Kipp-Stützen und ROHO-Quadtro-Sitzkissen ist nicht medizinisch begründet.

Vor diesem Hintergrund ist die beantragte Versorgung mit dem Aktivrollstuhl Quickie Helium nach Einschätzung der Nordsee-BKK nicht erforderlich im Sinne von Paragraf 33 Abs. 1 SGB V. Eine

wirtschaftlichere Versorgung mit einem Standard-Rollstuhl ist möglich. Die Mehrkosten für den Aktivrollstuhl sind von uns nicht zu übernehmen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Nordsee-BKK, Westring 472, 24114 Kiel, einzulegen (Paragraf 84 Abs. 1 SGG). Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem Ihnen dieser Bescheid zugestellt wurde. Fällt das Ende der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, endet die Frist mit dem Ablauf des nächstfolgenden Werktags.

Gemäß Paragraf 13 Abs. 3a SGB V hatten Sie die Möglichkeit, nach Ablauf der Bearbeitungsfrist von fünf Wochen die Leistung selbst zu beschaffen. Diese Regelung gilt nur unter den in Paragraf 13 Abs. 3a SGB V genannten besonderen Voraussetzungen.

Klaudia Mertens
Sachbearbeiterin Hilfsmittelversorgung
Thomas Wollbrink · Abteilungsleiter Leistungen

Bildbeschreibung Rollator — handschriftlich beschriftet

Dieses Dokument beschreibt die Originaldatei:

Dateiname (Original): Foto_Rollator_kaputt.jpg

Fotograf: **Stefanie Tannenberg (Tochter, mit Smartphone aufgenommen)**

Datum: ca. 14.05.2026

Beschreibung des Originalfotos:

Foto des Rollators von Olaf Tannenberg, aufgenommen im Flur der Wohnung
Adelheidstraße 17, Kiel.
Rollator-Details (erkennbar im Foto):
Modell: Topro Troja 2G Heavy Duty (stahlverchromt, silber-schwarz)
Zustand: stark abgenutzt, rechte Griffschaumstoffummantelung gerissen,
Bremszug links schwergängig (Befund Sanitätshaus bestätigt),
Sitzpolster verformt und eingesunken
Gewicht: 9,8 kg (lt. Herstellerangabe, aber Mandant empfindet es als
"schwer zum Hochheben")
Handschriftliches Schild am Rollator (Pappe mit Klebeband befestigt,
handgeschrieben von Olaf Tannenberg in unregelmäßigen Buchstaben):
"KANN IHN NICHT HEBEN
FÄLLT DAMIT"
Kontext der Beschriftung laut Erstgespräch:
Herr Tannenberg hat das Schild angebracht, nachdem er mehrfach beim
Versuchen, den Rollator in den Kofferraum zu heben, gestürzt ist.
Er wollte verhindern, dass Besucher oder der Fahrdienst erwarten,
dass er das Gerät selbst trägt. Das Schild dokumentiert die subjektiv
empfundene und objektiv messbare Kraftminderung der Arme.
Relevanz für den Widerspruch:
Das Foto und die handschriftliche Notiz unterstreichen die alltägliche
Beeinträchtigung durch das zu schwere Hilfsmittel. Zusammen mit der
Handkraftmessung (7,2 kg links, Norm ~38 kg) dokumentiert es die
Notwendigkeit eines leichteren Aktivrollstuhls.
Im echten Mandatsverhältnis wäre hier das JPG-Foto eingebettet.
Diese Bildbeschreibung hält die Akte auch ohne eingebettete Bilddatei auswertbar.
Bei Bedarf: Foto im Erstgespräch auf Smartphone anfordern und
nachträglich in die Akte einpflegen.

An das Sozialgericht Kiel
Kronshagener Weg 107a · 24116 Kiel
Per beA · Kiel, 25. August 2026 · Kanzleizeichen H-2026-441-E

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung

In der Sache Olaf Tannenberg, Adelheidstraße 17, 24103 Kiel, gegen die Nordsee-BKK, Westring 472, 24114 Kiel, vertreten durch ihren Vorstand, beantragen wir im Namen des Antragstellers den Erlass einer einstweiligen Anordnung nach Paragraf 86b Absatz 2 Satz 2 SGG.

1 Antrag und Reichweite

Wir beantragen, die Antragsgegnerin vorläufig zu verpflichten, Herrn Tannenberg binnen 14 Tagen ab Zustellung der gerichtlichen Entscheidung eine im Wohnumfeld tatsächlich nutzbare Mobilitätsversorgung mit geeignetem, von rechts zu bedienendem gekoppeltem Einhandantrieb einschließlich erforderlicher Anpassung und Einweisung zur Verfügung zu stellen, vorzugsweise leihweise bis zur Entscheidung in der Hauptsache. Die Antragsgegnerin kann ein gleich geeignetes Gerät oder eine geeignete Anpassung eines vorhandenen Geräts wählen. Sollte eine derartige Versorgung trotz nachgewiesener konkreter Beschaffungsbemühungen innerhalb der Frist nicht verfügbar sein, beantragen wir eine nach Funktionsprüfung gestufte Übergangsregelung mit unverzüglicher Erprobung, einer sicheren zeitlich begrenzten Ersatzversorgung und einer gerichtlichen Wiedervorlage zur Prüfung der weiteren Dauer. Wir beantragen eine Kostenentscheidung nach Paragraf 193 SGG.

Die beantragte Regelung ist auf den notwendigen Funktionsgewinn bis zur Entscheidung in der Hauptsache gerichtet. Der alte Kostenvoranschlag über 5.847 Euro ist abgelaufen. Das aktualisierte Preisangebot über 6.114 Euro gilt laut E-Mail nur bis zum 30. September. Für ein individuell gefertigtes Gerät sind sechs bis acht Wochen ab verbindlicher Bestellung zu erwarten. Deshalb setzen wir einen binnen 14 Tagen verfügbaren fabrikneuen Quickie Helium nicht voraus. Welche konkreten Bestandsgeräte anderer Anbieter beschafft oder angepasst werden können, muss die Kasse aus ihrer Versorgungspraxis mitteilen.

2 Verfahrensstand und Statthaftigkeit

Die Kasse hat die begehrte Versorgung abgelehnt. Die Anordnung der aufschiebenden Wirkung würde dem Antragsteller noch kein Hilfsmittel verschaffen. Das Rechtsschutzziel ist eine vorläufige Erweiterung der bestehenden Versorgung. Mit gesondertem Schriftsatz haben wir heute in der Hauptsache Klage erhoben. Der Widerspruchsbescheid vom 18. August wurde am 21. August zugestellt. Ein Hauptsacheaktenzeichen ist bei Versand des Eilantrags noch nicht bekannt. Wir bitten um Zuordnung der beiden Eingänge, ohne die Eilbearbeitung von der Hauptsacheerfassung abhängig zu machen.

3 Anordnungsanspruch

3.1 Nachweis der Funktionslücke

Die neurologischen Unterlagen belegen eine erhebliche und dauerhafte Mobilitätseinschränkung. Für die konkrete Hilfsmittelentscheidung sind linksseitige Kraftminderung und nachlassende Koordination maßgeblich. Im Versuch am 6. Februar führte der getrennte Greifreifenantrieb am Standardstuhl zur wiederholten Lenkabweichung. Der leichte Rahmen ohne Koppelung war einfacher anzufahren, beseitigte die Lenkabweichung aber nicht. Mit gekoppelter Bedienung von rechts gelangen unter Aufsicht ein kurzer Rundkurs, Wenden und Bremsung. Der Versuch belegt eine unterschiedliche

Bedienbarkeit der getesteten Geräte. Für einen längeren Weg und das tatsächliche Gebäude sind noch Ergänzungen erforderlich.

Die E-Mail vom 12. August bestätigt die jüngere praktische Erfahrung. Der seit Anfang August vorhandene Standard-Leihstuhl ermöglicht Fahrten mit schiebender Begleitung. Der Antragsteller brauchte beim erneuten Versuch im Geschäft nach etwa 15 Metern Hilfe. Einen geeigneten eigenen Einhandantrieb stellte der dortige Leihpool nicht bereit. Die Kasse hat kein anderes konkret angepasstes Leihgerät benannt. Eine Lösung, die im Ergebnis auf eine durchgängig schiebende Begleitperson angewiesen ist, ist nur in dem Umfang wirksam, in dem diese Begleitung tatsächlich verfügbar ist.

3.2 Rechtliche Bewertung des Bedarfs

Nach Paragraf 33 Absatz 1 Satz 1 SGB V besteht ein Anspruch auf die zum Ausgleich der Behinderung erforderliche Hilfsmittelversorgung. Die übliche Versorgung im Nahbereich richtet sich nach den notwendigen Wegen im Alltag und der praktisch möglichen Bedienung. BSG, Urteil vom 18. April 2024, B 3 KR 14/23 R, Randnummern 24 bis 29, arbeitet diese Prüfung für ein motorunterstütztes Zuggerät heraus. Im hiesigen Verfahren geht es um eine funktionsgerechte manuelle Versorgung. Übertragbar sind der Einzelfallmaßstab und die Anknüpfung an erreichbare Versorgungs- und Gesunderhaltungswege. Der Antragsteller beruft sich vor allem auf den Weg zum Briefkasten, zum Laden und zur Hausarztpraxis. Aus dem Umstand, dass er früher berufstätig war, wird keine besondere Leistung abgeleitet.

Für die im Widerspruchsbescheid genannten Alternativen sind Verfügbarkeit, Umfang der notwendigen Hilfe und Gleichwertigkeit zu überprüfen. Ein günstigerer geeigneter Aufbau ist nach Paragraf 12 Absatz 1 SGB V vorzuziehen. Der gerichtliche Antrag beschränkt sich deshalb auf die notwendige Funktion. Ein für den Antragsteller angepasstes Leihgerät kann genügen. Positionen wie Carbon-Felgenpolster sind nur bei eigenständig nachgewiesenem Bedarf einzubeziehen.

3.3 Grenzen der derzeitigen Belege

Das Ladenergebnis darf nicht als fertiger Nachweis einer sicheren Fahrt in jedem Umfeld gewertet werden. Die Einfahrt in die Aufzugkabine und das sichere Bremsen an einem leichten Gefälle sind noch zu erproben. Der Antragsteller akzeptiert für die ersten Fahrten Begleitung durch fachkundiges Personal. Ein zunächst eng definierter Einsatzbereich trägt dem vorläufigen Charakter der Maßnahme Rechnung. Bei der Auswahl ist zugleich sicherzustellen, dass der Antragsteller nicht auf eine bloße Probefahrt ohne konkrete anschließende Nutzung verwiesen wird.

4 Anordnungsgrund

4.1 Gegenwärtige Mobilitätslage

Der Antragsteller erreicht gewöhnliche Versorgungsorte derzeit regelmäßig nur, wenn seine Tochter, ein Nachbar oder ein beauftragter Fahrdienst tatsächlich Zeit hat. Das vorhandene Leihgerät schließt eine Lücke bei begleiteten Fahrten. Es lässt ihn aber weder den kurzen Weg zum Briefkasten noch die übrigen Wege selbst planen. Der alte Rollator ist nach Angaben des Leistungserbringers beschädigt. Eine Reparatur wurde dort nach Prüfung nicht für wirtschaftlich gehalten. Der Antragsteller beschreibt eine erhebliche Unsicherheit bei der Nutzung auch unabhängig vom Schaden.

Für die Dringlichkeit ist die Situation nach dem Widerspruchsbescheid maßgeblich. Die Voraussetzungen ergeben sich aus der fortdauernden Einschränkung im Alltag, der begrenzten Laufzeit der Leihversorgung und der Lieferzeit einer geeigneten dauerhaften Lösung. Der Antragsteller kann notwendige Bewegungsabläufe nicht dadurch aufschieben, dass er nur gelegentlich begleitet wird. Das Schreiben der Ärztin vom 14. August beschreibt aus ihrer Sicht ein Risiko weiterer funktioneller Verschlechterung bei fortdauernd geringer Bewegung. Der konkrete Umfang einer zu erwartenden

Verschlechterung bleibt medizinisch einzuschätzen. Bereits gegenwärtig ist aber belegt, dass mehrere gewöhnliche Wege nicht eigenständig bewältigt werden.

4.2 Ersatzmöglichkeiten und verbleibende Unsicherheiten

Arzneimittel können teilweise gebracht werden. Fahrdienste müssen vorab bestellt werden und dienen einzelnen Terminen. Sie lösen nicht die tägliche Lücke zwischen der Wohnung und den gewöhnlichen Versorgungswegen. Die Angaben zu verfügbaren Fahrten sind bisher nur telefonisch eingeholt. Die Familie hat keine schriftliche Dauerzusage. Ein funktionsfähiges persönliches Hilfsmittel könnte selbst mit anfänglicher Sicherung zu einem anderen Grad an eigener Bewegung führen. Für die Dringlichkeitsentscheidung bitten wir, die Hilfen als konkrete Versorgung und nicht lediglich als theoretische Möglichkeit zu bewerten.

Der Antragsteller bezieht eine Erwerbsminderungsrente und hat laufende Wohn- und Lebenshaltungskosten. Die Anschaffung für 6.114 Euro kann er nach seinen Angaben aus dem vorhandenen Einkommen nicht vorfinanzieren. Er hat keinen Bestellvertrag abgeschlossen. Für eine genaue Leistungsfähigkeitsprüfung werden Rentenbescheid, Wohnkostenbelege und erforderliche Kontounterlagen gesondert und nur im notwendigen Umfang vorgelegt. Auf eine pauschale Berechnung aus Rente und Miete stützen wir den Antrag auf Prozesskostenhilfe nicht.

5 Interessenabwägung und vorläufige Ausgestaltung

Eine zeitlich begrenzte leihweise Lösung erlaubt die Rückgabe oder Anpassung des Hilfsmittels nach dem Ergebnis der Hauptsache. Sie mindert die Folgen einer Fehlentscheidung für beide Seiten. Würde jetzt die endgültige Herstellung des angebotenen Geräts verbindlich angeordnet, entstünden Kosten und gegebenenfalls Lieferverzögerungen, obwohl der Umfang der notwendigen Ausstattung noch geprüft werden muss. Eine befristete Versorgung ist daher der beantragte erste Weg.

Bei Ablehnung bleibt der Antragsteller während der offenen Liefer- und Verfahrenszeit auf Begleitung für alle Wege angewiesen. Verschlechterungen der Mobilität und entfallene eigene Alltagswege lassen sich nachträglich nur eingeschränkt ausgleichen. Soweit eine vollständige Aufklärung im Eilverfahren nicht möglich ist, kommt eine anhand dieser konkreten Folgen bemessene Übergangsregelung in Betracht. Der Antragsteller ist bereit, eine dokumentierte Erprobung mit Terminen zur Kontrolle und zur Rückgabe zu vereinbaren.

Für den ersten Einsatz sollten Transfer und Bremsung, Aufzug, Tür und ein kurzer geeigneter Gehwegabschnitt in dieser Reihenfolge geprüft werden. Ein geeignetes Hilfsmittel muss tatsächlich verfügbar sein. Wenn die Kasse einen Anbieter benennt, sollen dessen Gerät, mögliche Anpassung und Lieferfrist konkret mitgeteilt werden. Der vorübergehend verfügbare Standardrollstuhl kann für begleitete Wege weiter genutzt werden. Er wird in dem Antrag nicht als gänzlich wertlos dargestellt.

6 Glaubhaftmachung und Prozesskostenhilfe

Wir beziehen uns auf die Verordnung vom 9. Februar, das Attest vom 5. Mai, die Wegeaufstellung vom 18. Mai, die Sitzprobe vom 6. Februar, die E-Mail des Sanitätshauses vom 12. August und den Widerspruchsbescheid mit Zustellvermerk. Die schriftliche Erklärung des Antragstellers zu den im August tatsächlich verfügbaren Begleitungen und die ärztliche Verlaufsmitteilung werden als gesonderte Anlagen eingereicht. Den Ausgangsbescheid legen wir zum Verständnis des Verwaltungsablaufs bei. Bei Bedarf kann das Gericht die Beteiligten kurzfristig zu der angebotenen Leihversorgung hören.

Für das Eilverfahren wird Prozesskostenhilfe nach Paragraf 73a SGG in Verbindung mit Paragrafen 114 ff. ZPO unter Beiordnung des Unterzeichners beantragt. Die Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse samt Nachweisen wird mit gesondertem Schriftsatz vorgelegt. Der

Antragsteller nimmt als Versicherter die Kostenregelung des Paragrafen 183 SGG in Anspruch. Aus der Anschaffungssumme leiten wir keinen förmlichen Streitwertantrag ab.

Lasse Holm · Rechtsanwalt

Olaf Tannenberg · Adelheidstraße 17 · 24103 Kiel

Zur Vorlage bei meinem Rechtsanwalt
Kiel, 25. August 2026
Begleitungen nach dem Termin im Sanitätshaus

Aufzeichnungen zu meinen Wegen im August

1 Termine und Hilfe

Meine Tochter hat mich am 6. August zum Sanitätshaus gefahren. Dort habe ich den Stuhl aus dem Leihbestand versucht. Nach einem Stück musste sie schieben. Ich habe den Stuhl mitgenommen, weil sie mich damit sicherer zu einem Termin bringen kann, als wenn ich den alten Rollator benutze. Der Stuhl gehört mir nicht. Der Mitarbeiter sagte, ich könne ihn bis Ende September behalten. Er konnte mir keinen Stuhl mit gekoppelter rechter Bedienung leihen.

Meine Tochter brachte mich am 13. August zur neurologischen Untersuchung. Auf dem Rückweg hat sie Medikamente mitgenommen. Einen anderen Termin musste ich telefonisch verlegen, weil wir keine Fahrt verabreden konnten. Aus dem Laden hat mir mein Nachbar einmal Brot und Milch gebracht. Er hat keinen Schlüssel und schaut nicht jeden Tag vorbei. Wenn ich zum Briefkasten gehen will, frage ich, ob jemand gerade im Haus ist. Manchmal sage ich den Weg dann ab.

2 Was ich bezahlen kann

Ich habe keine Bestellung unterschrieben. Das Sanitätshaus nennt jetzt 6.114 Euro. Ich bekomme monatlich eine Erwerbsminderungsrente. Davon gehen Miete, Lebensmittel und laufende Ausgaben ab. Eine Anschaffung dieser Höhe kann ich aus meinen eigenen Mitteln nicht vorstrecken. Für die genaue Prüfung kann ich meinen Rentenbescheid und die Nachweise zu den laufenden Kosten in der Kanzlei vorlegen.

Ich möchte zunächst ein geeignetes Gerät versuchen, auch wenn es geliehen ist. Mir ist wichtig, den Stuhl selbst anzutreiben und bremsen zu können. Wenn jemand am Anfang bei der Haustür hilft, will ich die weitere Strecke trotzdem selbst fahren. Ich bin mit einem begleiteten Versuch am Wohnort einverstanden.

Olaf Tannenberg

Olaf Tannenberg · Adelheidstraße 17 · 24103 Kiel

Notiz vor dem Kanzleitermin
Kiel, 20. Mai 2026 · 12.10 Uhr
Bescheid 2026-HM-04421-T

Notizen zum Brief der Krankenkasse und zum Alltag

1 Unterlagen, die ich heute mitbringe

Den Brief mit dem Datum 18. April habe ich am Dienstag, dem 21. April, bekommen. Meine Tochter Stefanie hat den Umschlag geöffnet, nachdem ich ihr den Schlüssel für den Briefkasten gegeben hatte. Den Umschlag habe ich auf dem Küchentisch aufgehoben. Ich bringe ihn mit. Im Bescheid steht die Geschäftsstelle Westring. Auf älteren Schreiben zum Beitrag steht Sophienblatt. Ich weiß nicht, ob beide Stellen dieselbe Post bearbeiten.

Außerdem bringe ich die Verordnung von Frau Dr. Wallenstein, den Kostenvoranschlag und meine Wegeaufstellung mit. Meine Tochter hat den Reha-Bericht vom alten Ordner herausgesucht. Ich hatte ihn damals nicht mit dem Hilfsmittelantrag verbunden. Das Attest vom 5. Mai habe ich erst nach dem Brief der Kasse erhalten. Ich habe noch nichts gekauft und keinen Auftrag beim Sanitätshaus unterschrieben.

2 Was ich tagsüber noch allein mache

Morgens komme ich an vielen Tagen vom Schlafzimmer bis zur Küche, wenn ich den Rollator und zwei Haltepunkte im Flur benutze. Manchmal muss ich mich schon im Flur setzen. Das ist anders als beim Arzt, wenn ich ausgeruht und jemand neben mir ist. Seit ein Nachbar mir am Briefkasten wieder aufhelfen musste, gehe ich lieber nur hinunter, wenn jemand im Haus ist. Wenn meine Tochter mich fährt, kann ich meist noch selbst in den Wagen umsetzen. Der fremde Fahrer wartet aber nicht mit mir vor der Apotheke, wenn ich länger brauche.

Mit dem geliehenen Rollstuhl kann mich eine Begleitperson schieben. Selbst komme ich nicht zuverlässig geradeaus. Beim Versuch mit der gekoppelten rechten Bedienung im Sanitätshaus hat es auf dem ebenen Gang besser funktioniert. Auf meinem Gehweg habe ich es noch nicht versucht. Am Hauseingang geht die Tür beim Loslassen schnell zu. Der Aufzug ist zwar vorhanden, aber ich muss erst richtig vor der Tür stehen und dann aus dem Gang in die Kabine drehen.

3 Erreichbarkeit

Ich möchte zuerst zum Hausarzt, zum Laden und zum Briefkasten kommen. Andere Wege, zum Beispiel der Spaziergang am Wasser, wären für mich schön. Das ist nicht der Grund, weshalb ich jetzt um Hilfe bitte. Meine Tochter und der Nachbar helfen manchmal. Ich habe mit ihnen keine festen Tage vereinbart. Am kommenden Donnerstag will meine Tochter nach der Arbeit kommen, falls sie nicht länger bleiben muss.

Olaf Tannenberg

An das Sozialgericht Kiel
Kronshagener Weg 107a · 24116 Kiel
Per beA · Kiel, 25. August 2026 · Kanzleizeichen H-2026-441

Klageschrift

Namens und in Vollmacht von Herrn Olaf Tannenberg, Adelheidstraße 17, 24103 Kiel, erheben wir Klage gegen die Nordsee-BKK, Westring 472, 24114 Kiel, vertreten durch ihren Vorstand.

1 Anträge und Verfahrensgegenstand

Wir beantragen, den Bescheid vom 18. April 2026 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 18. August 2026 aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, den Kläger mit einem alltagstauglichen angepassten Aktivrollstuhl zu versorgen, der mit rechtsseitig gekoppeltem Einhandantrieb selbstständig geführt, gebremst und im Wohnumfeld rangiert werden kann, einschließlich bedarfsgerechter Sitzanpassung, erforderlicher Kippsicherung und Einweisung. Die konkrete Geräteauswahl kann nach Vergleichserprobung erfolgen. Eine geeignete leihweise Versorgung bleibt vom Antrag erfasst. Wir beantragen ferner die Erstattung der notwendigen außergerichtlichen Kosten nach Paragraf 193 SGG.

Die kombinierte Anfechtungs- und Leistungsklage ist nach Paragraf 54 Absatz 1 und Absatz 4 SGG statthaft. Die Klage wird binnen eines Monats nach Zustellung des Widerspruchsbescheids am 21. August erhoben. Der Kläger begehrt eine Sachleistung. Er hat weder den früheren Kostenvoranschlag angenommen noch das nunmehr für 6.114 Euro beschriebene Gerät privat bestellt.

2 Sachverhalt

2.1 Entwicklung der Mobilität

Der Kläger lebt mit einer seit Jahren behandelten Multiplen Sklerose. Für die Auswahl des Rollstuhls sind die linksbetonte Parese, die unsichere Koordination beim Gehen und die Ermüdbarkeit bei Wiederholung wichtig. Die Ärztin hat eine Gehstrecke mit Rollator unter Sicherung beschrieben. Auf geraden kurzen Strecken im vertrauten Wohnungsflur kann der Kläger den Rollator zeitweise benutzen. Bei Richtungswechsel, Türöffnung und Bordsteinkante muss er mehrere Handlungen gleichzeitig ausführen und verliert die erforderliche Stabilität. Die Wegeaufstellung vom Mai beschreibt deswegen eine andere praktische Leistungsfähigkeit als eine kurze Beobachtung in der Praxis.

Vor dem Antrag erprobte der Kläger im Sanitätshaus mehrere Antriebsformen. Ein Standardgerät mit zwei Greifreifen wich nach wenigen Metern zur schwächeren Seite ab. Ein leichterer Rahmen war einfacher anzufahren, änderte die ungleiche Lenkung aber nicht hinreichend. Mit rechtsseitiger Koppelung gelang auf dem Ladenboden eine Fahrt von ungefähr 42 Metern mit Wende und Bremsversuchen. An der provisorischen Kante war einmal Sicherung erforderlich. Die Ergebnisse erlauben eine vorläufige Differenzierung. Sie sind ein Anlass zur Erprobung im tatsächlichen Wohnumfeld und stellen noch keine Freigabe für jede Strecke dar.

2.2 Alltagswege

Der Briefkasten ist nach der Wegeaufstellung etwa 47 Meter vom Ausgangspunkt in der Wohnung entfernt. Der Kläger muss bis dahin die Aufzugtür anfahren, den Hausflur passieren und an der Haustür Halt finden. Der Laden liegt ungefähr 230 Meter und die Praxis rund 320 Meter vom Wohnort entfernt. Die Apotheke liegt nach der längeren Wegangabe rund 610 Meter entfernt. Die Frage, ob eine nähere geeignete Apotheke zur Verfügung steht, bleibt der Sachaufklärung vorbehalten. Der Kläger macht bereits für Briefkasten, Praxis und Lebensmitteleinkauf einen Bedarf geltend. Freizeitziele am Wasser sind für den Leistungsantrag nicht entscheidend.

Die Tochter leistet tatsächlich Begleitung, aber nur in den mit ihr abgestimmten Zeiten. Ein Leih-Faltrollstuhl ermöglicht dann Sitzmobilität. Die Unterstützung erstreckt sich derzeit auf den gesamten Weg. Mit einem geeigneten selbst bedienbaren Gerät wäre die Hilfe allenfalls noch bei bestimmten Hindernissen erforderlich. Der Kläger hat erklärt, dass er bereit ist, den Gebäudezugang mit einem Hilfsmittel zu üben. Er will nachvollziehbar festhalten lassen, welche Hilfe nach der Einweisung noch gebraucht wird.

2.3 Verfahrensverlauf und aktuelle Versorgung

Der Antrag vom 11. Februar, die Nachforderung vom 22. März, die Antwort vom 30. März und die MD-Stellungnahme vom 3. April liegen vor. Der Widerspruch vom 20. Mai führte neue Funktionsbelege ein und schlug eine praktische Vergleichserprobung vor. Eine erneute Begutachtung fand bis zum Widerspruchsbescheid nicht statt. Der Beklagten stand damit eine detailliertere Aktenlage zur Verfügung als dem Medizinischen Dienst im April. Die Beklagte hat den ursprünglichen Hinweis auf Berufstätigkeit im Widerspruchsbescheid relativiert. Sie hat dennoch aus nicht untersuchten Möglichkeiten der Begleitung und aus fehlenden Erprobungsdaten auf die Ablehnung geschlossen.

Am 6. August konnte der Kläger den aus dem Leihpool angebotenen etwa 19 Kilogramm schweren Faltrollstuhl nach Mitteilung des Sanitätshauses vom 12. August nur ungefähr 15 Meter im Gang bewegen. Danach schob ihn die Tochter. Das Gerät ist kostenlos bis Ende September überlassen und wird als Übergang tatsächlich genutzt. Ein angepasster Leih-Aktivrollstuhl ist im dortigen Pool nicht vorhanden. Die Lieferzeit des individuell angepassten Geräts wird mit sechs bis acht Wochen ab verbindlicher Bestellung angegeben. Diese Tatsachen betreffen sowohl die Hauptsache als auch die praktisch mögliche Übergangsversorgung. Sie ersetzen keine Information über andere kurzfristig verfügbare Miet- oder Bestandsgeräte.

3 Begründetheit

3.1 Maßstab für den mittelbaren Behinderungsausgleich

Paragraf 33 Absatz 1 Satz 1 SGB V erfasst den Ausgleich einer Behinderung bei der Erschließung des im Einzelfall maßgeblichen Nahbereichs. BSG, Urteil vom 18. April 2024, B 3 KR 14/23 R, Randnummern 24 bis 29, stellt auf reale Versorgungs- und Gesunderhaltungswege und auf die zumutbare Nutzung der verbliebenen Kraft ab. Der Rechtsstreit betraf ein motorisiertes Rollstuhlzuggerät. Die Bedeutung des tatsächlichen Umfelds lässt sich auf den vorliegenden Fall übertragen. Der Kläger begehrt eine andere Technik, weil die Schwäche der linken Hand nach den dokumentierten Versuchen eine geeignete einseitige Bedienung erfordert.

Ein Aufzug oder ein vorhandener Leihrollstuhl kann ein wichtiges Teilstück des Problems lösen. Die Eignung einer Versorgung setzt gleichwohl voraus, dass Bedienung, erreichbare Wege und die tatsächlich verfügbare Begleitung zusammen beurteilt werden. Die Kasse hat eine für den Kläger verfügbare Grundversorgung anzubieten. Dazu kann eine andere Ausführung als das im Februar angebotene Modell gehören. Eine nur gedanklich verfügbare Hilfe trägt die Ablehnung der beanspruchten geeigneten Versorgung nicht.

3.2 Wirtschaftlichkeit und konkrete technische Leistung

Das Wirtschaftlichkeitsgebot nach Paragraf 12 Absatz 1 SGB V verlangt eine Auswahl unter im Einzelfall geeigneten Leistungen. BSG, Urteil vom 18. April 2024, B 3 KR 13/22 R, zeigt bei unterschiedlichen Antriebskonzepten, dass die Bedienung und deren gesundheitliche Folgen in die Eignungsprüfung eingehen. Dort waren die medizinisch festgestellten Folgen für die Daumensattelgelenke maßgeblich. Hier muss die Beklagte bei der linken Parese ein Gerät wählen, das

der Kläger nach Einstellung sicher kontrollieren kann. Der niedrigere Preis des Standardgeräts gewinnt erst Gewicht, wenn die notwendige Funktion nachgewiesen wird.

Die angebotene Sitzbreite beträgt 42 Zentimeter. Die Koppelung, die Lage des Schwerpunkts und die Bremsbedienung sind vor der Abgabe konkret zu beschreiben. Ein Druckentlastungskissen ist bei nachgewiesenem Bedarf einzubeziehen. Für die Wahl einer besonderen Marke und für die Carbon-Felgenpolster sind konkrete Gebrauchsvorteile zu ermitteln. Der Kläger beschränkt sein Leistungsbegehren auf die erforderliche Ausstattung. Wenn ein wirtschaftlich geeigneter Aufbau bei einem anderen Anbieter verfügbar ist, kann er die beantragte Funktion erfüllen.

3.3 Tatsachenermittlung

Die Aktenstellungnahme ist bei der Frage zu berücksichtigen, was im April bekannt war. Sie erfasst nicht die im Mai beigebrachten Unterlagen. Der Widerspruchsbescheid zieht aus den bislang fehlenden Prüfungen Schlüsse zur Erforderlichkeit, ohne die angebotene praktische Vergleichsmöglichkeit auszuschöpfen. Das Gericht kann die entscheidungserheblichen Tatsachen nach Paragraf 103 SGG selbst ermitteln. Der Kläger regt an, die Funktion des Standardgeräts, eines angepassten manuellen Aktivrollstuhls und eines gleich geeigneten Vergleichsgeräts unter möglichst gleichen Bedingungen zu erheben. Eine bloße Herstellerangabe zum Gewicht ist hierfür nicht ausreichend.

4 Beweisangebote und Anregungen

Beiziehung der vollständigen Verwaltungsakte wird beantragt, insbesondere einschließlich des MD-Auftrags, der übermittelten Unterlagen, der Empfangsvermerke und der geprüften Vertragshilfsmittel. Zum körperlichen Zustand und zur Wiederholbarkeit der Bedienung wird die Beiziehung der Befundberichte von Dr. Annette Wallenstein nach entsprechender Entbindung von der Schweigepflicht angeregt. Hendrik Paulsen kann zum Aufbau der Geräte und zu seinen unmittelbaren Beobachtungen bei der Sitzprobe und beim Leihversuch Auskunft geben. Stefanie Tannenberg kann zur tatsächlich geleisteten Begleitung und zu einzelnen beobachteten Alltagswegen gehört werden.

Für die sachverständige Funktionsprüfung schlagen wir vor, den Bedarf an Koppelantrieb und Kippschutz, die sichere Bremsung bei sinkender Kraft, den Transfer und die Eignung bei Tür und Aufzug getrennt zu dokumentieren. Eine Prüfung auf gefährlichem Untergrund soll nur stattfinden, wenn die vorangegangenen Aufgaben sicher beherrscht werden. Für einzelne Zubehörteile sind medizinische Funktion und mögliche gleich geeignete Alternativen gesondert anzugeben. Die rechtliche Bewertung bleibt dem Gericht überlassen.

5 Anlagen

Beigefügt sind der Ausgangsbescheid, der Widerspruchsbescheid mit Zustellvermerk, die Verordnung, der Kostenvoranschlag, das Protokoll der Sitzprobe, die Wegeaufstellung, der medizinische Ergänzungsbericht und die Mitteilung des Sanitätshauses vom 12. August. Den Antrag auf vorläufige Versorgung reichen wir gesondert ein.

Lasse Holm · Rechtsanwalt

Reha-Aktiv Nord GmbH · Sanitätshaus und Orthopädietechnik
Holstenstraße 88, 24103 Kiel | Telefon 0431 9734-0 | HRB 18724 AG Kiel

Kostenvoranschlag	RAN-2026-0287
Versicherter	Olaf Tannenberg
Krankenkasse	Nordsee-BKK
Datum	10. Februar 2026

Herrn Olaf Tannenberg
Adelheidstraße 17
24103 Kiel

Kostenvoranschlag Aktivrollstuhl Quickie Helium

Sehr geehrter Herr Tannenberg,

auf Grundlage der Verordnung von Dr. Wallenstein und der Sitzprobe am 6. Februar 2026 bieten wir folgende Versorgung an. Sämtliche Beträge verstehen sich einschließlich Umsatzsteuer.

Position	Beschreibung	Bruttobetrag
1	Aktivrollstuhl Quickie Helium, Sitzbreite 42 cm	3903,20 Euro
2	Carbon-Felgenpolster, Paar	371,28 Euro
3	Anti-Kipp-Stützen, klappbar	152,32 Euro
4	ROHO Quadtro Select High Sitzkissen	585,48 Euro
5	Sitzprobe, Anpassung, Einweisung und Lieferung	243,95 Euro
6	Einhandantrieb und individuelle Schwerpunktanpassung	590,77 Euro

Gesamtbetrag: 5847,00 Euro brutto.

Die Position Einhandantrieb und Schwerpunktanpassung umfasst einen asymmetrisch beschichteten Greifreifen, die Versetzung der Antriebsachse, zwei Erprobungstermine und die abschließende Dokumentation. Der genaue Leistungscode wird nach Genehmigung mit der Krankenkasse abgestimmt.

Im Gesamtbetrag enthalten sind Lieferung im Stadtgebiet Kiel, Einweisung des Versicherten und einer Hilfsperson sowie eine Nachkontrolle binnen sechs Wochen. Nicht enthalten sind bauliche Veränderungen der Wohnung und später gewünschte Komfortausstattungen.

Der Kostenvoranschlag ist 90 Tage gültig. Eine Bestellung erfolgt erst nach schriftlicher Kostenübernahme oder gesonderter privater Beauftragung.

Hendrik Paulsen
Orthopädietechniker und Rollstuhl-Fachberater

An die Nordsee-BKK · Leistungsabteilung Hilfsmittel
Olaf Tannenberg · N123-456-789-Z
Kiel, 3. April 2026 · Aktenlage

Sozialmedizinische Stellungnahme zur Rollstuhlversorgung

1 Auftrag

Die Nordsee-BKK fragt, ob auf der vorliegenden Befundgrundlage ein Aktivrollstuhl der angebotenen Ausführung einschließlich Zubehör erforderlich ist. Ich habe Herrn Tannenberg nicht persönlich untersucht. Die Bewertung betrifft die vom Auftraggeber übermittelte Akte. Aussagen zur tatsächlichen Bedienung eines Geräts im Wohnumfeld setzen eine dortige Beobachtung oder eine entsprechend genaue Dokumentation des Leistungserbringers voraus.

2 Vorliegende Unterlagen

Vorliegen der Leistungsantrag vom 11. Februar, die vertragsärztliche Verordnung vom 9. Februar, der Kostenvoranschlag vom 10. Februar, die Anforderung weiterer Unterlagen vom 22. März und die Antwort vom 30. März. In den Leistungsdaten ist Pflegegrad 2 seit Mai 2023 vermerkt. Ein aktueller Reha-Entlassungsbericht und ein getrenntes Protokoll des Leistungserbringers über den Vergleich verschiedener Antriebe sind in der vorliegenden Sendung nicht enthalten. Es wurde kein eigener Hausbesuch beauftragt.

Die Verordnung dokumentiert eine Multiple Sklerose mit sekundär progredientem Verlauf, linksbetonte Hemiparese, eingeschränkte Gangstabilität und eine geringe Gehstrecke unter Verwendung eines Rollators. Im Antwortschreiben vom 30. März wird die Asymmetrie bei der Bedienung eines gewöhnlichen Greifreifens als Problem genannt. Eine beidseitige quantitative Griffkraftmessung findet sich dort nicht. Daraus folgt, dass der Stärkegrad für die Gerätedifferenzierung noch nicht genau belegt ist. Das beschriebene Funktionsproblem ist gleichwohl plausibel.

3 Sozialmedizinische Befundbewertung

Herr Tannenberg erreicht laut Verordnung mit dem Rollator und unter Aufsicht nur etwa 15 bis 20 Meter. Der in älteren Daten genannte Pflegegrad beschreibt die Selbstständigkeit in mehreren Lebensbereichen und ersetzt eine individuelle Beurteilung der Hilfsmittelbedienung nicht. Die vorliegenden Befunde tragen dem Grunde nach eine Rollstuhlversorgung zur sicheren Fortbewegung. Sie lassen noch keine sichere Aussage über die geeignete Antriebsart für regelmäßig wiederholte Wege zu.

Ein Standard-Faltrollstuhl kann passive Sitzmobilität und eine Begleitversorgung leisten. Der Leistungsvergleich setzt voraus, dass geprüft wird, ob der Versicherte ihn nach fachgerechter Einstellung selbst bewegen kann oder ob für den Bedarf eine Begleitung tatsächlich ausreicht. Bei Hemiparese ist die Greifkraft für sich genommen nur ein Teil des Problems. Lenkung, Loslassen des Greifreifens, Halten bei einem Gefälle und die Bedienung der Bremsen müssen zusammen betrachtet werden. Die Angebotsunterlagen enthalten hierzu keine vergleichende Messung. Aus der Schilderung einzelner erfolgreicher Bewegungen mit Rollator lässt sich die Nutzbarkeit eines Standard-Rollstuhls im Nahbereich nicht ableiten.

Nach den Unterlagen befindet sich die Wohnung im zweiten Obergeschoss und ist mit einem Aufzug erreichbar. Maße der Kabine, seitliche Anfahrfläche, Türschließer und die Verbindung zum Gehweg sind nicht dokumentiert. Ein stufenlos erreichbarer Aufzug macht eine Versorgung im Gebäude möglich, beweist aber nicht, dass der Versicherte mit jedem Gerät wenden und anhalten kann. Angaben

zu einem besonderen beruflichen Bedarf fehlen. Die Beurteilung der grundlegenden Mobilität hängt davon nicht ab.

4 Vergleich und Zubehör

Beim vorliegenden Angebot ist die Sitzbreite auf 42 Zentimeter festgelegt. Die Angabe von 8,4 Kilogramm ist im Zusammenhang mit dem Aufbau des angebotenen Rahmens zu lesen. Ob die Zahl das Gerät fahrbereit mit Rädern und Zubehör beschreibt, geht aus den vorliegenden Unterlagen nicht sicher hervor. Der Anbieter soll das Gesamtgewicht und die Achslage im Auslieferungszustand angeben. Für die Ergonomie ist insbesondere relevant, ob sich beide Räder über eine rechtsseitige Koppelung bedienen lassen oder lediglich eine besser greifbare Oberfläche angeboten wird. Beide Systeme haben unterschiedliche Folgen für einen Nutzer mit linksbetonter Parese.

Eine Kippsicherung kommt bei veränderter Achslage und Unsicherheit beim Anfahren in Betracht. Ein Sitzkissen kann bei längerer Sitzdauer und ungünstiger Druckverteilung erforderlich sein. Die Unterlagen enthalten bislang keine differenzierte Feststellung, warum die angebotene Ausführung gegenüber einer günstigeren Alternative notwendig wäre. Die Carbon-Felgenpolster sollten nur berücksichtigt werden, wenn ihre Funktion gegenüber einer einfacheren Versorgung beschrieben und belegt wird. Bei gleich geeigneten Ausführungen ist der günstigere Aufbau vorzuziehen.

5 Ergebnis und weiterer Untersuchungsbedarf

Für eine sofortige Empfehlung des angebotenen Aktivrollstuhls einschließlich sämtlicher Zubehörpositionen fehlen nach der vorliegenden Aktenlage vergleichbare Fahrproben und eine belastbare technische Bezeichnung des Einhandantriebs. Als vorläufige Möglichkeit kommt ein Standardgerät für begleitete Wege in Betracht. Eine abschließende Feststellung zur gleichwertigen selbstständigen Nutzbarkeit ist anhand dieser Unterlagen nicht möglich. Die Entscheidung über die beantragte Leistung trifft die Kasse.

Erbeten wird bei erneuter Begutachtung die Dokumentation einer persönlichen Untersuchung mit Seitenvergleich der Handkraft, Prüfung der Wiederholbarkeit des Greifens und Versuchen in gleichartig eingestellten Geräten. Der Erprobungsbericht sollte geradeaus fahren, abbremsen, wenden, Transfer und eine repräsentative Engstelle enthalten. Auch der Gebrauch im konkreten Wohnumfeld und die tatsächlich zur Verfügung stehende Hilfe sind zu klären. Die Prüfung des Grundbedarfs kann von der Beurteilung des Zubehörs getrennt vorgenommen werden.

Dr. med. Henning Steffens

Nordsee-BKK · Pflegekasse
Westring 472, 24114 Kiel | Telefon 0431 5800-0 | Team Pflegeleistungen

Aktenzeichen	2023-PG-01287-T
Versichertennummer	N123-456-789-Z
Antrag	10. März 2023
Datum	4. Mai 2023

Herrn Olaf Tannenberg
Adelheidstraße 17
24103 Kiel

Bescheid über die Einstufung in Pflegegrad 2

Sehr geehrter Herr Tannenberg,

auf der Grundlage des Gutachtens des Medizinischen Dienstes Nord vom 19. April 2023 stellen wir bei Ihnen ab 4. Mai 2023 Pflegegrad 2 fest.

Feststellungen des Medizinischen Dienstes

Die gewichtete Gesamtpunktzahl beträgt 36,5 Punkte. Berücksichtigt wurden Beeinträchtigungen der Mobilität, der Selbstversorgung, des Umgangs mit krankheitsbedingten Anforderungen und der Gestaltung des Alltagslebens. Den größten Anteil bilden Hilfebedarf beim Duschen, Ankleiden, bei Transfers und bei der selbstständigen Organisation der Medikation.

Modul	Festgestellte Beeinträchtigung	Gewichteter Beitrag
Mobilität	erheblich eingeschränkt	3,0 Punkte
Kognition und Kommunikation	gering eingeschränkt	1,1 Punkte
Verhaltensweisen	keine relevante Einschränkung	0,0 Punkte
Selbstversorgung	erheblich eingeschränkt	19,0 Punkte
Krankheitsbedingte Anforderungen	erheblich eingeschränkt	10,0 Punkte
Alltagsleben und soziale Kontakte	erheblich eingeschränkt	3,4 Punkte

Leistungen ab Mai 2023

Bei häuslicher Pflege kann Pflegegeld von monatlich 316,00 Euro beansprucht werden. Alternativ stehen Pflegesachleistungen bis monatlich 724,00 Euro oder eine Kombination beider Leistungsarten zur Verfügung. Der Entlastungsbetrag beträgt monatlich bis zu 125,00 Euro. Änderungen der gesetzlichen Beträge werden automatisch berücksichtigt.

Für Pflegehilfsmittel zum Verbrauch können bei Vorliegen der Voraussetzungen Aufwendungen bis zum gesetzlichen Höchstbetrag erstattet werden. Ein Beratungseinsatz ist bei ausschließlichem Pflegegeld halbjährlich nachzuweisen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich, in zugelassener elektronischer Form oder zur Niederschrift bei der Nordsee-BKK Pflegekasse einzulegen.

Anlage: vollständiges Gutachten des Medizinischen Dienstes Nord vom 19. April 2023.

Monika Bremer
Sachbearbeiterin Pflegeleistungen

Ostseeklinik Damp GmbH · Neurologische Rehabilitation
Am Seeufer 12, 24351 Damp | Telefon 04352 80-0 | Station Neurologie Süd

Patient	Olaf Tannenberg, geboren am 17. Februar 1964
Aufnahme	5. August 2024
Entlassung	23. August 2024
Berichtsdatum	24. August 2024

Dr. med. Annette Wallenstein
MS-Schwerpunktpraxis Kiel-Holtenau
Holtenauer Straße 312
24107 Kiel

Reha-Entlassungsbericht und ärztliche Epikrise

Diagnosen

G35 – Multiple Sklerose, schubförmig-progredient (SPMS), EDSS 6,0 bei Aufnahme / 6,5 bei Entlassung

G81.9 – Hemiparese links, progredient (Schub Juli 2024)

R26.3 – Koordinationsstörung (Ataxie), beinbetont

N31.9 – Neurogene Blasenfunktionsstörung, SIK etabliert

R53.1 – MS-bedingte Fatigue, schwerwiegend

F06.7 – Leichte organisch bedingte kognitive Störung

Z99.3 – Abhängigkeit von Mobilitätshilfsmitteln

Aufnahmebefund und Verlauf

Herr Tannenberg wurde nach stationärer Akutbehandlung im UKSH Kiel (Aufnahme 18.07.2024, Entlassung 03.08.2024) zur neurologischen Rehabilitation in unsere Klinik verlegt. Anlass war ein akuter MS-Schub mit deutlicher Zunahme der linksseitigen Hemiparese und erheblicher Gangverschlechterung. Bei Aufnahme konnte der Patient mit Rollator noch ca. 25–30 m gehen; im Verlauf der 18-tägigen Rehabilitation stabilisierte sich der Zustand, eine wesentliche Verbesserung der linksseitigen Kraftminderung trat jedoch nicht mehr ein. Bei Entlassung war die maximale Gehstrecke mit Rollator auf unter 20 m reduziert; der EDSS stieg von 6,0 auf 6,5.

Therapeutische Maßnahmen während der Rehabilitation: Physiotherapie (täglich, 2× 30 Min.), Ergotherapie (5× wöchentlich), Logopädie (2× wöchentlich wegen Dysarthrie), Neuropsychologie, Hilfsmittelberatung und -erprobung. Im Rahmen der Hilfsmittelerprobung wurden verschiedene Rollstuhlmodelle getestet (Standard-Rollstuhl und Leichtgewicht-Aktivrollstuhl).

Ergebnis der Hilfsmittelerprobung

Im Rahmen der Ergotherapie (Therapeutin: Mareike Holst, Ergotherapeutin) und in Zusammenarbeit mit dem Sanitätsfachhandel vor Ort wurde eine systematische Rollstuhlerprobung durchgeführt. Ergebnis:

Modell Gewicht Selbstantrieb (links) Bewertung

Standard-Kassenrollstuhl (Muster SB-46) 17,2 kg Nicht möglich (linke Hand zu schwach) Ungeeignet für Selbstfahren

Leichtgewicht-Rollstuhl (KM-Reha Tango) 13,4 kg Sehr eingeschränkt (< 5 m) Bedingt geeignet, nicht befriedigend

Aktivrollstuhl

Quickie Helium 8,4 kg Möglich mit Re-Kompensation (bis 30 m eigenständig) Geeignet – empfohlen

Aktivrollstuhl

Ottobock Motus 9,1 kg Möglich mit Re-Kompensation (bis 25 m) Alternative, zweite Wahl

Empfehlungen bei Entlassung

• Hilfsmittel: Antrag auf Leichtgewicht-Aktivrollstuhl (Quickie Helium oder gleichwertig) bei der Krankenkasse stellen. Empfehlung wurde dem Patienten erläutert. Ein Antrag wurde seinerzeit (August 2024) noch nicht gestellt.

• Physiotherapie: Weiterführung ambulant, 2× wöchentlich, Schwerpunkt Rumpfstabilität und Transfertraining • Ergotherapie: Hilfsmittelberatung und -anpassung ambulant, ADL-Training • Logopädie: 1× wöchentlich bei verordnender Hausärztin, Dysarthrietherapie • Medikation: Tecfidera 240 mg 2x/d weiterführen, Baclofen 25 mg/d (Spastik), Amantadin 200 mg/d (Fatigue) • MS-Ambulanz: Halbjährliche Vorstellung bei Dr. Wallenstein, Kiel-Holtenau • Pflegegrad: Ggf. Antrag auf Höherstufung (Pflegegrad 3) empfohlen, wenn Verschlechterung anhält • Kontrolltermin: MRT Schädel nach 6 Monaten

Prognose

Bei primär-progressiver Verlaufskomponente ist eine weitere Verschlechterung des Gangbildes und der Handkraft links zu erwarten. Die derzeitige Erkrankungsphase (EDSS 6,5) ist als irreversibel einzustufen; eine wesentliche Verbesserung der motorischen Funktion ist nicht zu erwarten. Die Versorgung mit einem adäquaten Hilfsmittel ist dauerhaft erforderlich.

Weitergabe nur mit Einwilligung des Patienten.

Dr. med. Susanne Fincke
Leitende Ärztin Neurologie
Mareike Holst · Ergotherapie

MS-Schwerpunktpraxis Kiel-Holtenau
Dr. med. Annette Wallenstein | Holtenauer Straße 312, 24107 Kiel | BSNR 72438001

Versicherter	Olaf Tannenberg, geboren am 17. Februar 1964
Krankenkasse	Nordsee-BKK
Versichertennummer	N123-456-789-Z
Datum	9. Februar 2026

Vertragsärztliche Verordnung einer Hilfsmittelversorgung

Diagnosen

G35 Multiple Sklerose mit sekundär-progredienter Komponente; G81.9 linksbetonte Hemiparese; Z99.3 Abhängigkeit von Mobilitätshilfsmitteln.

Verordnung

Hilfsmittel	Menge	Besondere Anforderung
Aktivrollstuhl, individuell anpassbar	1	Eigengewicht höchstens 10 kg, Sitzbreite 42 cm, angepasster Greifreifen
druckentlastendes Sitzkissen	1	individuelle Anpassung und Einweisung

Medizinische Begründung

Der Versicherte erreicht mit dem Rollator unter Aufsicht höchstens 15 bis 20 Meter. Wegen der linksseitigen Kraftminderung und der ausgeprägten Fatigue kann er einen Standardrollstuhl mit einem Eigengewicht von mehr als 15 Kilogramm nicht zuverlässig selbst antreiben. In der Rehabilitation wurde ein Aktivrollstuhl mit geringem Eigengewicht erprobt; damit gelangen kurze Wege im Eigenantrieb.

Die Versorgung soll Transfers, selbstständige Wege innerhalb des Wohnumfelds und die sichere Teilnahme an Arztterminen ermöglichen. Sitzbreite, Schwerpunkt, Greifreifen und Kippschutz sind im Rahmen einer gemeinsamen Erprobung durch Leistungserbringer, Arzt und Versicherten anzupassen. Das Sitzkissen dient wegen langer Sitzzeiten und eingeschränkter Gewichtsverlagerung der Druckentlastung.

Die Verordnung ist zusammen mit dem Reha-Entlassungsbericht vom 24. August 2024 und dem aktuellen neurologischen Befund einzureichen.

Dr. med. Annette Wallenstein
Fachärztin für Neurologie · LANR 123456789

Olaf Tannenberg · N123-456-789-Z
Hendrik Paulsen, Orthopädietechniker
6. Februar 2026 · 10.30 bis 11.50 Uhr

Sitzprobe und Erprobung eines Aktivrollstuhls

1 Geräte und Prüfaufbau

Zur Sitzprobe brachte Herr Tannenberg die Maße aus dem Reha-Aufenthalt mit. Die heutige Messung ergab eine passende Sitzbreite von 42 Zentimetern. Der im Angebot vorgesehene Aktivrahmen wird mit einem Gewicht von ungefähr 8,4 Kilogramm ohne Räder beschrieben. Diese Zahl bezeichnet keine fahrfertige Gesamtmasse. Für den Vergleich wurden die Räder, Kippsicherung, Sitzkissen und Fußauflage montiert. Die Testgeräte unterscheiden sich außer im Gewicht in der Achslage, der Breite und dem Antrieb. Aus einem reinen Gewichtsvergleich lässt sich die Funktion daher nicht herleiten.

Auf einem ebenen, trockenen Ladenboden wurden Anfahren, Wenden, gezieltes Bremsen und die Zufahrt zu einer nachgestellten Aufzugtür erprobt. Auf dem Boden waren Start und Ziel markiert. Herr Tannenberg konnte sich zu Beginn selbst umsetzen, nachdem die Fußstütze zur Seite gestellt und das Gerät gegen Wegrollen gesichert war. Bei jedem Versuch blieb eine Person in Eingreifnähe. Es wurde keine Fahrt im Straßenverkehr durchgeführt.

Aufbau	Strecke und Handlung	Beobachtung und Hilfebedarf
Standard Faltstuhl mit zwei Greifreifen	14 Meter geradeaus und Beginn der Wende	Gerät wich wiederholt nach links ab. Rechts musste der Nutzer mehrmals nachgreifen. Zur vollständigen Wende schob die Begleitperson mit.
Aktivrahmen ohne Koppelantrieb	26 Meter geradeaus und einmal anhalten	Der Rahmen war leichter in Gang zu setzen. In der Kurve blieb das Lenken durch die linke Hand unzuverlässig.
Aktivrahmen mit rechtsseitig gekoppeltem Einhandantrieb	42 Meter mit Wende und zwei Stopps	Beide Räder ließen sich auf ebener Fläche von rechts antreiben. Nach Einweisung hielt Herr Tannenberg an beiden Markierungen an.
Einhandantrieb an provisorischer Kante von 18 Millimetern	Anfahren aus dem Stand, zwei Versuche	Ein Durchgang nach erneutem Ansetzen, einmal Sicherung gegen Rückrollen. Keine Freigabe für eine längere Rampe.

2 Erprobte Anpassungen

Die linke Hand hat beim beidhändigen Versuch den Greifreifen wiederholt verlassen. Eine Änderung von Achslage und Greifreifenposition allein beseitigte das Problem nicht. Bei dem hier eingesetzten rechtsseitig gekoppelten Einhandantrieb konnte Herr Tannenberg beide Räder über die rechte Seite beeinflussen. Er brauchte zunächst Zeit, um Geradeausfahrt und Lenkbewegung zu unterscheiden. Die technische Ausführung und die individuelle Bedienung müssen im Serienangebot übereinstimmen. Der Leistungscode im Angebot ist noch abzustimmen. Der Ausdruck Greifreifenbeschichtung in der Leistungsbeschreibung allein beschreibt die Koppeltechnik nicht vollständig.

Die Kippsicherung war bei den Anfahrversuchen montiert. Eine generelle Notwendigkeit der angebotenen Carbon-Felgenpolster lässt sich aus der Sitzprobe nicht ableiten. Für das angebotene

Sitzkissen wurde die Sitzposition beurteilt. Eine eigenständige Druckmessung fand nicht statt. Bei der finalen Anpassung sind Beckenstabilität, Druckverteilung und die Begründung einer gegebenenfalls günstigeren Ausführung festzuhalten.

3 Grenzen des Versuchs

Die Erprobung fand in Räumen des Sanitätshauses statt. Der tatsächliche Aufzug, Türschließer, das Quergefälle am Hauseingang und die Wege zum Arzt oder Supermarkt wurden noch nicht befahren. Eine kurzfristige Lenkbewegung über wenige Meter sagt wenig über Ermüdung nach einem gesamten Hin- und Rückweg aus. Beim nächsten Termin sollten die Wege daher in der realen Abfolge nachgestellt werden, mit Zutritt zum Aufzug und einer beaufsichtigten Strecke im Wohnumfeld. Besonders wichtig ist, ob bei sinkender Kraft die Bremse und der gekoppelte Antrieb von der rechten Seite erreichbar bleiben.

Hendrik Paulsen

Meine Wege im Alltag – wohin ich noch komme und wo ich stürze

Olaf Tannenberg, Adelheidstraße 17, 24103 Kiel – geschrieben am 18.05.2026

Ich schreibe das hier selber auf, damit die Kasse und mein Anwalt verstehen was bei mir los ist. Ich bin Diplom-Ingenieur, nicht blöd, aber das Tippen geht mir schwer von der Hand wegen der Lähmung links. Also bitte entschuldigung wenn da Fehler drin sind.

Meine Wege in der Wohnugn:

- Wohnzimmer → Bad: ca. 8 Meter.

  Das schaffe ich noch mit dem Rollator. Manchmal. Morgens ist es besonders schwer, dann brauche ich länger.

- Schlafzimmer → Küche: ca. 12 Meter.

  In der Regel okay. Einmal habe ich mich am Türrahmen abgestützt und bin trotzdem gefallen. Zum Glück war die Tochter da. Wenn ich alleine bin mache ich das mit dem Rollstuhl (Ausleih-Modell vom Sanitätshaus, aber der ist so schwer den krieg ich kaumm bewegt).

Außen vor der Wohnung:

- Wohnung (2.OG) → Briefkasten (Erdgeschoss, Hauseingang): ca. 47 Meter.

  Mit dem Rollator: NICHT möglich ohne Begleitung. Ich bin zweimal gefallen auf dem Weg dahin. Einmal hat mich Nachbar Herr Kühn aufgeholfen. Das ist mir peinlich aber ich schreibe es hin weil es wichtig ist. Mit dem Leih-Rollstuhl komme ich bis zum Briefkasten WENN jemand den Stuhl schiebt. Alleine schieben kann ich den nicht.

- Wohnung → Hausarzt Dr. Bergmann, Adelheidstraße 44: ca. 320 Meter.

  Überhaupt nicht mehr ohne Fahrdienst oder Tochter. Mit dem Leih-Rollstuhl könnte ich die 320m theoretisch fahren aber ich schaffe es nicht ihn anzutreiben. Der wiegt locker 17 kg, meine linke Hand ist so schwach dass ich den nicht geradeaus bekomme. Ich fahre im Kreis. Kein Witz, das habe ich proiert.

- Wohnung → Apotheke Holstenstraße: ca. 610 Meter.

  Nur mit Tochter oder Fahrdienst. Lieferservice wo möglich. Aber nicht alles kann geliefert werden.

Was ich vermisse:

- Früher bin ich jeden Morgen am Schwimmstadion spazieren gegangen. Das ist ca. 1,2 km von uns, am Wasser. Da war ich Ingenieur, hab Schiffe entworfen, war gesund. Ich weiß das klingt dramatisch aber ich vermisse das sehr. Mit einem Aktivrollstuhl – ich hab das in Damp ausprobiert – könnte ich da mit der Tochter wieder hinfahren. Mit dem Kassenrollstuhl nicht, den kriege ich nicht bewegt.

- Auch: Einkaufen. Edeka ist 230m. Mit Aktivrollstuhl könnte ich da selbst hinfahren. Das wäre für mich Unabhägigkeit. Ich bin 62 und will nicht jeden Handgriff von der Tochter machen lassen.

Sturzprotokoll (soweit ich mich erinnere):

- Oktober 2025: Sturz im Flur (alleine), Prellung re. Schulter, kein Arzt → hab ich verdrängt
- Januar 2026: Sturz beim Weg zum Briefkasten, Herr Kühn hat geholfen

- März 2026: Fast-Sturz beim Einsteigen in Taxis (Fahrer hat aufgefangen)
- April 2026: Sturz beim Aufstehen aus dem Leih-Rollstuhl, Schürfwunde re. Knie

Ich hoffe das hilft. Wenn noch Fragen sind bitte über den Anwalt. Meine Tochter Stefanie hilft mir bei Terminen.

Olaf Tannenberg, Kiel, den 18.05.2026

_____

(Unterschrift Olaf Tannenberg)

Herrn Olaf Tannenberg, vertreten durch Rechtsanwalt Lasse Holm
Holstenstraße 124 · 24103 Kiel
Kiel, 18. August 2026 · 2026-HM-04421-T-W

Widerspruchsbescheid

1 Entscheidung

Der Widerspruch gegen den Bescheid vom 18. April 2026 wird zurückgewiesen. Aufwendungen des Widerspruchsverfahrens werden nicht erstattet.

2 Sachverhalt und Vorbringen

Sie beantragten am 11. Februar 2026 einen angepassten Aktivrollstuhl. Sie stützten den Antrag auf die Verordnung Ihrer behandelnden Neurologin vom 9. Februar und das Angebot des Sanitätshauses vom 10. Februar über 5.847 Euro brutto. Die Nordsee-BKK forderte am 22. März ergänzende Angaben an. Diese gingen am 30. März ein. Der Medizinische Dienst sah in seiner Stellungnahme nach Aktenlage vom 3. April einen Rollstuhlbedarf dem Grunde nach. Die besondere Antriebsausführung und verschiedene Zusatzpositionen hielt er anhand der ihm vorliegenden Unterlagen noch nicht für hinreichend belegt.

Gegen den ablehnenden Bescheid vom 18. April haben Sie durch Ihren Bevollmächtigten am 20. Mai fristgerecht Widerspruch erhoben. Sie berufen sich insbesondere auf Ihre linksbetonte Hemiparese, die mangelnde Kontrolle über einen gewöhnlichen Faltrollstuhl und die geringe Gehstrecke mit Rollator. Sie haben das Attest vom 5. Mai, den Reha-Bericht aus Damp, das Protokoll einer Sitzprobe vom 6. Februar und Ihre Angaben zu Alltagswegen beigefügt. Die praktische Bedeutung einer einhändig bedienbaren Ausführung haben wir anhand dieser Unterlagen geprüft. Den Vorschlag einer weiteren persönlichen Erprobung haben wir in die Entscheidung einbezogen. Eine neue Untersuchung durch den Medizinischen Dienst haben wir bislang nicht veranlasst.

3 Gründe

3.1 Bedarf und gesetzlicher Rahmen

Anspruchsgrundlage für die begehrte Sachleistung ist Paragraf 33 Absatz 1 SGB V. Eine Hilfsmittelversorgung ist nach Paragraf 12 Absatz 1 SGB V auf die im konkreten Fall geeignete und erforderliche Ausführung zu beschränken. Wir nehmen an, dass Sie mit einer Mobilitätshilfe unterstützt werden müssen. Wir stellen auch nicht in Frage, dass der Weg zum Hausarzt, zu einem Laden oder zum Briefkasten der grundlegenden Lebensführung dienen kann. Ein beruflicher Bedarf ist dafür keine Voraussetzung. Der Ausgangsbescheid hat diese Unterscheidung nicht hinreichend deutlich gemacht. Für den Anspruch auf die beantragte Ausführung kommt es darauf an, ob diese im Alltag einen nachweisbaren Nutzen gegenüber den praktisch in Betracht kommenden Möglichkeiten bietet.

3.2 Bedeutung der Seitenunterschiede und des Wohnumfelds

Das Attest vom 5. Mai nennt eine deutlich geringere Kraft der linken Hand. Damit ist die Schwierigkeit beim beidhändigen Greifreifenantrieb plausibel. Die Erprobung vom 6. Februar zeigt auf ebenem Boden einen besseren Lauf mit gekoppeltem Antrieb. Bei der provisorischen Schwelle war in einem Versuch eine Sicherung gegen Rückrollen erforderlich. Ein längerer Hin- und Rückweg im Wohnumfeld wurde nicht erprobt. Offen bleibt auch, ob die im Angebot bezeichnete Greifreifenanpassung mit der erprobten technischen Koppelung übereinstimmt.

Die Wohnung ist mit einem Aufzug erschlossen. Eine selbstständige Bedienung von Haustür und Aufzug ist mit dem angebotenen Rollstuhl noch nicht gezeigt worden. Mit begleitetem Transfer kann

ein geeigneter Faltrollstuhl einzelne notwendige Wege erleichtern. Die Familie kann nach Ihrer Darstellung nur zeitweise helfen. Wir gehen derzeit davon aus, dass für notwendige Fahrten weiterhin Unterstützung organisiert werden kann. Diese Annahme haben wir aus Ihren Angaben und den vorhandenen Versorgungsmöglichkeiten abgeleitet. Ein durchgehender Plan über tatsächlich verfügbare Begleitung liegt uns nicht vor. Sie können bei Bedarf weiterhin eine Prüfung der vorhandenen Übergangsversorgung anfragen.

3.3 Angebot und Zubehör

Der Preis von 5.847 Euro beruhte auf einem befristeten Angebot. Aus der Akte folgt keine aktuelle verbindliche Bestellung. Für Kippschutz und Sitzanpassung bestehen Anhaltspunkte, für die konkrete Ausführung der Carbon-Felgenpolster und des benannten Druckentlastungskissens fehlt noch eine abschließende funktionelle Begründung. Bei einem Gesamtangebot sind die notwendigen Teile und gegebenenfalls wirtschaftlichere Ausführungen abzugrenzen. Die Kasse ist zur Prüfung eines geeigneten Hilfsmittels bereit, hält die beantragte Komplettversorgung nach dem bisherigen Stand aber nicht für hinreichend belegt. Diese Entscheidung beruht auf der Beurteilung des beschriebenen Angebots. Sollten Sie eine differenzierte neue Versorgungsempfehlung und eine tatsächliche Vergleichserprobung vorlegen, können diese erneut geprüft werden.

4 Kosten und Rechtsbehelf

Die Kostenentscheidung folgt aus Paragraf 63 SGB X. Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Sozialgericht Kiel, Kronshagener Weg 107a, 24116 Kiel, erhoben werden. Die Klage ist schriftlich, in der gesetzlich vorgesehenen elektronischen Form oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle zu erheben. Für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte gilt die Pflicht zur elektronischen Übermittlung nach Paragraf 65d SGG.

Für den Widerspruchsausschuss · Meike Jansen

Zustellvermerk der Kanzlei · zugestellt am 21. August 2026.

An die Nordsee-BKK · Leistungsabteilung Hilfsmittel
Westring 472 · 24114 Kiel
Kiel, 20. Mai 2026 · 2026-HM-04421-T · N123-456-789-Z

Widerspruch gegen die Ablehnung der Aktivrollstuhlversorgung

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens und in Vollmacht von Herrn Olaf Tannenberg, Adelheidstraße 17, 24103 Kiel, lege ich gegen Ihren Bescheid vom 18. April 2026 Widerspruch ein. Die schriftliche Vollmacht ist beigefügt. Herr Tannenberg und seine Tochter geben übereinstimmend an, den Bescheid am 21. April erhalten zu haben. Der Umschlag wurde aufbewahrt. Bitte bestätigen Sie Eingang und Zuordnung des Rechtsbehelfs. Wir bitten um Aufhebung des Bescheids und Versorgung mit einem für den Mandanten in Alltag und Nahbereich eigenständig bedienbaren Aktivrollstuhl mit bedarfsgerechter Anpassung. Die im Angebot vom 10. Februar bezeichnete Konfiguration ist die derzeit erprobte Ausgangsvariante. Wir sind zur Erprobung einer gleich geeigneten günstigeren Ausführung bereit.

1 Gegenstand und Stand der Beschaffung

Herr Tannenberg beantragte am 11. Februar 2026 bei Ihnen die Versorgung. Grundlage waren die Verordnung vom 9. Februar und der Kostenvoranschlag RAN-2026-0287 vom 10. Februar über 5.847 Euro brutto. Auf Ihre Nachforderung vom 22. März hat der Mandant gemeinsam mit der Verordnerin am 30. März reagiert. Es folgte die Stellungnahme des Medizinischen Dienstes Nord nach Aktenlage vom 3. April. Den älteren Reha-Bericht hat die Tochter erst für das heutige Gespräch aus dem privaten Ordner herausgesucht. Das ärztliche Attest vom 5. Mai ist nach dem ablehnenden Bescheid entstanden. Wir reichen beides jetzt ein.

Das Angebot war auf 90 Tage befristet. Die damalige Summe beschreibt die beantragte Konfiguration. Sie ist kein verbindlicher aktueller Preis. Der Mandant hat keine Bestellung unterschrieben und keinen Betrag an den Leistungserbringer gezahlt. Gegenstand des Rechtsbehelfs ist die Sachleistung. Eine Kostenerstattung für Selbstbeschaffung ist nicht beantragt. Soweit der Ausgangsbescheid die Selbstbeschaffung nach Paragraf 13 Absatz 3a SGB V anspricht, bitten wir um Mitteilung, welche Fristenregelung die Kasse angesichts des Rehabilitationsbezugs geprüft hat und ob eine Weiterleitung oder Mitteilung über eine Verzögerung dokumentiert ist. Eine eigenständige Prüfung der Zuständigkeit und der Fristen bleibt möglich. Aus einer bloßen Fristüberschreitung leiten wir für diesen Widerspruch keine Bewilligung der begehrten Sachleistung ab.

2 Welche Funktion der Rollstuhl erfüllen soll

2.1 Gehfähigkeit und Schwankungen

Der Mandant lebt mit Multipler Sklerose und einer linksbetonten Parese. Die Verordnerin beschreibt, dass er mit Rollator unter Aufsicht etwa 15 bis 20 Meter erreicht. Der Wert beruht auf einem bestimmten Untersuchungsablauf. Die Angaben zu längeren Wegen innerhalb der Wohnung beziehen sich demgegenüber auf die Summe kurzer Etappen mit Haltepunkten und Pausen. Beide Angaben sind vereinbar. Für eine selbstständige Erledigung sind Angehen, Wenden, kontrolliertes Anhalten und die erneute Bewegung nach einer Unterbrechung wichtig. Wenn er sich am Türrahmen abstützen muss, steht die linke Hand nicht zugleich zur Kontrolle des Rollators zur Verfügung.

Die durch den Arztbericht beschriebene MS-bedingte Ermüdbarkeit zeigt sich besonders nach einem Lagewechsel oder nach wiederholter Betätigung derselben Hand. Eine einmalige Bewegung mit

ausreichender Kraft ist keine Zusicherung, dass sie nach einem längeren Hinweg wiederholt werden kann. Der Mandant hat bei mehreren Wegen zum Briefkasten Hilfe durch den Nachbarn oder seine Tochter gebraucht. Die Aktennotizen berichten verschiedene Stürze und Beinaheereignisse. Die Ereignisse dürfen nicht zusammengezogen werden. Für die derzeitige Prüfung genügen die konkret belegten Schwierigkeiten beim Aufstehen und am Briefkasten. Weitere ärztliche Unterlagen reichen wir nach, sobald sie verfügbar sind.

2.2 Wege und räumliche Hindernisse

Die Wegeaufstellung vom 18. Mai nennt ungefähr 47 Meter von der Wohnung zum Briefkasten, 230 Meter bis zum Laden, 320 Meter bis zur Hausarztpraxis und 610 Meter bis zur vom Mandanten benannten Apotheke. Ein kürzerer oder anderer Weg zur Apotheke ist gesondert zu prüfen. Die Entfernungen sind eigene Schätzungen. Sie bezeichnen die jeweilige Strecke ab Wohnung. Zur Belastung gehören Rückweg, Wartezeiten, Richtungsänderungen und das Tragen kleiner Einkäufe. Der Spazierweg am Wasser ist als persönlicher Wunsch erfasst. Schon die Wege zum Briefkasten, zum Laden und zur Arztpraxis begründen die geltend gemachte Funktionslücke.

Ein Aufzug erschließt die Wohnung im zweiten Obergeschoss. Die Einfahrt in die Kabine setzt voraus, dass der Mandant vor der Aufzugstür richtig ansetzt, die Bewegung in engem Raum abbrechen kann und aus der Kabine wieder herauskommt. Die Haustür fällt nach dem Loslassen zu. Die Gehwegkante und das Gefälle wirken sich auf die Bedienung aus. Die bauliche Erreichbarkeit des Gebäudes und die selbstständige Nutzung des Hilfsmittels sind daher getrennt zu untersuchen. Die Wohnungsskizze hilft, die Engstellen für die Erprobung zu bestimmen. Sie ist keine Bescheinigung vollständiger Barrierefreiheit.

2.3 Unterstützung durch Dritte

Die Tochter begleitet ihren Vater, wenn ihre Arbeit und ihre übrigen Verpflichtungen es erlauben. Sie kann keine festen Fahrten für jeden Werktag übernehmen. Der Nachbar hat dem Mandanten nach einem Sturz geholfen. Daraus folgt keine regelmäßig verfügbare Begleitung. Der Mandant kann Arzneimittel teilweise liefern lassen. Damit lassen sich persönliche Arztbesuche oder die eigenständige Wahrnehmung gewöhnlicher Erledigungen nicht vollständig ersetzen. Eine Schiebehilfe kann als Übergang dienen. Als dauerhafte Alternative müsste sie die im Einzelfall benötigte Funktion in hinreichend verlässlichem Umfang erfüllen.

3 Vergleich der Geräte und Ausstattung

3.1 Standard-Faltrollstuhl

Der Medizinische Dienst stellt auf einen Standardrollstuhl ab. Die Akte nennt noch kein individuell geprüftes Vertragsmodell mit dokumentierten Maßen und Einstellung. Ein Standardstuhl kann eine angemessene Sitz- und Transportversorgung leisten. Im erprobten Gerät driftete der Mandant bei zwei getrennt anzutreibenden Rädern nach links und benötigte beim Wenden einen Eingriff. Die seitengleiche Bedienung ist damit gerade die ungeklärte Frage. Die Kasse müsste benennen, wie die vorhandene linke Handfunktion ausreicht oder welche Anpassung diesen Nachteil ausgleicht. Ein Vertragspreis von 920 Euro sagt nichts über diese Funktion aus.

3.2 Leichtbau und rechtsseitig gekoppelter Einhandantrieb

Die Sitzprobe vom 6. Februar erlaubt eine differenziertere Betrachtung als der Vergleich zweier Prospektgewichte. Für den Aktivrahmen werden ungefähr 8,4 Kilogramm ohne Räder angegeben. Das ist kein fahrfertiges Gewicht. Der leichtere Rahmen ließ sich im Versuch leichter in Bewegung setzen. In der Kurve war die linke Hand bei zwei getrennten Greifreifen weiterhin unzuverlässig. Erst beim

Versuch mit einer rechtsseitig gekoppelten Bedienung konnte der Mandant beide Räder von seiner besser einsetzbaren Seite aus kontrollieren. Damit sind zwei unterschiedliche Funktionen belegt. Die Gewichtsreduzierung kann das Anfahren erleichtern. Die geeignete Koppelung kann das asymmetrische Lenken ausgleichen. Keiner dieser beiden Gesichtspunkte beantwortet allein die Frage der Ausdauer auf einem Rückweg.

Der schriftliche Kostenvoranschlag spricht von einer Beschichtung des Greifreifens und einer Schwerpunktanpassung. Das beschreibt die bei der Sitzprobe eingesetzte Koppelung noch nicht vollständig. Wir bitten darum, vor der endgültigen Festlegung den Leistungserbringer um die technische Spezifikation und die Bestätigung des vorgesehenen Systems zu ersuchen. Ein Gerät, das nur einen besser greifbaren Reifen besitzt, wäre mit dem tatsächlich erprobten Koppelantrieb nicht vergleichbar. Ebenso sollte bei einem späteren Angebot die Antriebsachse in der aus der Sitzprobe bekannten Stellung eingestellt werden, soweit das fahrtechnisch sicher und für den Nutzer geeignet ist.

3.3 Sitz, Kippschutz und Zubehör

Die dokumentierte Sitzbreite beträgt 42 Zentimeter. Das angebotene Kissen und die Position der Fußauflagen sind an Sitzstabilität und Druckverteilung zu messen. Die Sitzprobe enthält keine eigenständige Druckmessung, die gerade die Notwendigkeit der angebotenen Kissenmarke beweist. Eine günstigere funktionell vergleichbare Druckentlastung kommt in Betracht. Der Kippschutz war beim Anfahren an einer provisorischen Kante montiert und kann wegen der veränderten Achslage und der geringen Standsicherheit für die Erprobung notwendig sein. Der Bedarf ist in der endgültigen Konfiguration festzustellen. Für die angebotenen Carbon-Felgenpolster gibt es bisher keine davon unabhängige Funktionsprüfung. Wenn eine einfachere Ausführung dieselbe Handhabung ermöglicht, ist sie in den Vergleich aufzunehmen.

Der Mandant verlangt keine bestimmte Marke, Farbe oder Komfortposition um ihrer selbst willen. Er möchte ein Hilfsmittel, das in seinem Wohnumfeld einhändig angetrieben, gebremst und rangiert werden kann. Eine handhabbare Alternative mit anderer Rahmenkonstruktion oder einem gleichwertigen Einhandantrieb wäre für ihn akzeptabel. Die Bezeichnung Aktivrollstuhl beschreibt in diesem Antrag die benötigte Bedienung und Einstellbarkeit. Sie soll ein individuell passendes Gerät im Vertragssortiment nicht ausschließen.

4 Rechtliche Begründung

4.1 Anspruch auf Behinderungsausgleich

Paragraf 33 Absatz 1 Satz 1 SGB V gewährt Hilfsmittel, soweit sie unter anderem zum Ausgleich einer Behinderung erforderlich sind. Bei der Versorgung zum mittelbaren Behinderungsausgleich kommt es auf die Erschließung des Nahbereichs für allgemeine Versorgungs- und gesundheitsbezogene Wege an. BSG, Urteil vom 18. April 2024, B 3 KR 14/23 R, Randnummern 24 bis 29, knüpft für eine motorunterstützte Mobilitätshilfe an die tatsächlichen Alltagswege und die zumutbare Nutzung der vorhandenen Körperkraft an. Der Streit hier betrifft einen manuellen Aktivrollstuhl. Übertragbar ist die konkrete Prüfung des Grundbedürfnisses und des Lebensumfelds. Die Entscheidung besagt nicht, dass in Kiel dieselbe Technik wie in dem damaligen Rechtsstreit zu bewilligen wäre.

Der Bescheid verlangt einen erhöhten beruflichen oder sportlichen Bedarf. Die hier geltend gemachte Funktion bezieht sich auf persönliche Grundversorgung und Gesunderhaltung. Fehlende Erwerbstätigkeit beseitigt diesen Bedarf nicht. Der Mandant bezieht eine Erwerbsminderungsrente. Sein früherer Beruf erklärt, warum er die Geräteeigenschaften und seine Wege genau beschrieben hat. Der Anspruch wird weder aus dieser früheren Berufstätigkeit noch aus einem Sportwunsch hergeleitet.

Die Aufnahme in das Hilfsmittelverzeichnis kann als Information über geprüfte Produktmerkmale und verfügbare Ausführungen dienen. Eine Kassenentscheidung muss dennoch den Bedarf im Einzelfall prüfen. Wenn der Bescheid einen bestimmten Typencode anführt, sollte die Kasse das konkrete lieferbare Modell und die Zuordnung erläutern. Eine unvollständige Positionsangabe erlaubt noch keinen funktionsbezogenen Vergleich. Die Leistungspflicht ergibt sich aus dem gesetzlichen Anspruch und der tatsächlichen Eignung.

4.2 Wirtschaftlichkeit

Paragraf 12 Absatz 1 SGB V begrenzt die Leistung auf das notwendige Maß. Die günstigere Lösung hat Vorrang, wenn sie im Alltag dieselbe notwendige Funktion erfüllt. BSG, Urteil vom 18. April 2024, B 3 KR 13/22 R, verdeutlicht bei unterschiedlichen Antriebskonzepten die Bedeutung der tatsächlichen Handhabung und der gesundheitlichen Folgen. Dort ging es um ein motorunterstütztes Handkurbelzuggerät und eine andere Form der Kraftunterstützung. Der Vergleich hilft als Maßstab, weil auch hier die Bedienung mit der verbliebenen Körperkraft entscheidend ist. Die für Herrn Tannenberg geeignete Variante muss eigenständig festgestellt werden.

Die Vergleichsbasis sollte das nutzbare Gerät mit notwendiger Anpassung, Einweisung und Wartung umfassen. Der Vertragspreis des Standardstuhls und das abgelaufene Angebot betreffen noch keine gleichwertig spezifizierten Leistungen. Wir bitten um Aufschlüsselung des Vertragsangebots und um eine konkrete Prüfung, ob ein Wiedereinsatzgerät angepasst oder eine leihweise Erprobung veranlasst werden kann. Auf eine spekulative Hochrechnung möglicher Begleitkosten stützen wir den Antrag nicht. Für die Einordnung genügt zunächst, dass der Vergleichsstuhl im dokumentierten Versuch ohne Schiebehilfe unzureichend funktionierte.

4.3 Ermittlungsumfang der Kasse

Nach Paragraf 20 SGB X ermittelt die Kasse den Sachverhalt von Amts wegen und berücksichtigt auch günstige Umstände. Der Medizinische Dienst hat im April nachvollziehbar benannt, welche Befunde ihm fehlen. Die derzeitige neue Aktenlage liefert eine Handkraftmessung, die Beobachtungen der Erprobung und die konkrete Wegeaufstellung. Sie sollte eine erneute Befassung auslösen. Die Griffkraft ist als Seitenvergleich relevant. Ein einzelner Dynamometerwert beweist weder sichere Handhabung noch deren Fehlen. Die Untersuchung sollte Belastbarkeit, Anfahrverhalten, Richtungswechsel, Notbremsung und Weg im tatsächlichen Umfeld zusammen betrachten.

Wir beantragen Akteneinsicht nach Paragraf 25 SGB X in den vollständigen Vorgang. Erbeten sind die an den Medizinischen Dienst übersandte Fassung der Unterlagen, die Rückmeldung auf das Schreiben vom 30. März, das Vergleichsangebot mit Modell und Ausstattung sowie ein etwaiger Versand- und Eingangsnachweis. Bitte bestätigen Sie auch, ob der Reha-Bericht aus Damp oder Teile davon schon vor Abgabe der Stellungnahme vorlagen. Das Schreiben der Kasse zitiert ihn nicht. Die Familie kann die frühere Ablage nicht sicher rekonstruieren.

5 Vorschlag für eine Erprobung

Wir schlagen einen beaufsichtigten Termin am Wohnort mit einer Vertreterin oder einem Vertreter des Vertragssanitätshauses vor. Zuerst sollten Transfer und Bremsung geprüft werden. Es folgen die Aufzugeinfahrt, eine Wendung in der Kabine oder ein sicherer Ablauf für die Rückwärtsfahrt, das Öffnen der Haustür und eine kurze Strecke mit realem Quergefälle. Die Bedingungen und Hilfestellungen sind jeweils festzuhalten. Erst bei beherrschter Kurzstrecke ist eine längere Fahrt mit anschließender Wiederholung sinnvoll. Bei erkennbarer Sturzgefahr, fehlender Bedienbarkeit der Bremse oder deutlichem Kraftverlust soll abgebrochen werden.

Als Geräte sind ein konkret verfügbares Standardmodell, ein geeigneter angepasster Aktivrollstuhl mit Einhandantrieb und gegebenenfalls eine weitere wirtschaftliche Ausführung zu vergleichen. Wenn die Kasse eine Auswahl nicht innerhalb der laufenden Bearbeitung bereitstellen kann, bitten wir um einen vorläufigen Vorschlag für sichere Alltagswege. Der Mandant wird am Termin mitwirken. Eine medizinisch riskante Probe darf durch die behandelnde Praxis begrenzt werden.

6 Entscheidung und Anlagen

Bitte helfen Sie dem Widerspruch ab, sobald die Bedarfsdeckung durch die beantragte oder eine gleich geeignete Versorgung feststeht. Sollte die Sachaufklärung noch Zeit beanspruchen, bitten wir um eine konkrete Mitteilung über die fehlenden Angaben und den nächsten Untersuchungstermin. Die Voraussetzungen gerichtlichen Eilrechtsschutzes richten sich nach der aktuellen Versorgungslage. Eine pauschale Wartefrist für einen Eilantrag besteht nicht.

Wir reichen die Vollmacht, die Verordnung vom 9. Februar, das Attest vom 5. Mai, den Reha-Bericht aus Damp, den Kostenvoranschlag vom 10. Februar, das Erprobungsprotokoll vom 6. Februar, die Wohnungsskizze und die Wegeaufstellung vom 18. Mai ein. Den Originalumschlag halten wir bereit.

Lasse Holm · Rechtsanwalt

Wohnungsskizze Mandant — Beschreibung

Dieses Dokument beschreibt die Originaldatei:

Dateiname (Original): Wohnungsskizze_Mandant.png

Erstellt von: Olaf Tannenberg (handgemalt, dann abfotografiert / eingescannt)

Datum: ca. 18.05.2026

Beschreibung des Originals:

Eine handgezeichnete Grundrissskizze der Wohnung Adelheidstraße 17, 2. OG, 24103 Kiel.
Maßstab: nicht maßstabsgerecht, Maße wurden in Metern handschriftlich eingetragen.
Grundriss-Angaben (rekonstruiert):

+----------+----------+

Schlafzimmer	**Bad**
ca. 14 qm	ca. 6 qm
	[Haltegriffe!]

+--------+---------+----------+

Flur (ca. 12m x 1,2m)

+--+----------+-+

+----------++ +-------------++

Küche		**Wohnzimmer**
ca. 9qm		ca. 22 qm

+----------+ +--------------+

[Wohnungstür → Treppenhaus → Aufzug]
Handschriftliche Maßnotizen (O. Tannenberg):
Flur Gesamt: ca. 12 m (von Schlafzimmer bis Wohnzimmertür)
Wohnzimmer → Küche: ca. 8 m
Bad → Schlafzimmer: ca. 3 m
Wohnungstür → Aufzug: ca. 4 m im Treppenhaus
Aufzug → Hauseingang/EG: ca. 5 m
EG Eingang → Briefkasten: ca. 15 m (im Haus + außen am Briefkastenblock)
Haustür → Straße: ca. 7 m
Straße → Gehweg Adelheidstraße: unbegrenzt (Außenbereich)
Besonderheiten (laut Skizze):

- Rollstuhlgerechte Türbreiten laut Beschriftung: Wohnzimmer 95cm, Flur 88cm,

Bad 78cm (etwas eng für 16-18 kg Standard-RsT), Küche 80cm

- Aufzugskabine: 110cm x 140cm (laut Angabe Hausverwaltung)
- Kein Schwellenbereich in der Wohnung (barrierefrei ausgebaut)

Relevanz für den Widerspruch:
Die Skizze belegt, dass die Wohnungsinnenbereiche mit einem 65-cm-Rollstuhl passierbar sind.
Sie zeigt jedoch NICHT, dass der Standard-Rollstuhl selbstständig angetrieben werden kann –
das ist eine Frage der Handkraft, nicht der Türbreite.
Im echten Mandatsverhältnis würde hier ein Foto oder Scan der handgezeichneten Skizze

eingescannt und als PNG/JPG beigefügt. Diese Beschreibung hält die Akte auch ohne eingebettete Bilddatei auswertbar.

Landeshauptstadt Kiel - Jugendamt

Andreas-Gayk-Straße 31, 24103 Kiel - Sachgebiet Eingliederungshilfe gemäß SGB VIII

Az.: JA-EH-2026-04711 / Sachbearbeiterin Frau Marlies Krempin

An die Eltern - Familie Tannenberg, Adelheidstraße 17, 24103 Kiel

Datum: 12. März 2026

B E S C H E I D

über Ihren Antrag vom 14. Januar 2026 auf Gewährung einer Schulbegleitung (Eingliederungshilfe nach Paragraf 35a SGB VIII) für Ihre Tochter Lena Tannenberg, geboren am 03.09.2009, Schülerin der 10. Klasse des Gelehrtenschule-Gymnasiums Kiel.

Entscheidung

Der Antrag wird abgelehnt.

Begründung

Nach Paragraf 35a Absatz 1 SGB VIII haben Kinder und Jugendliche Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn 1. ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und 2. daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Bei Ihrer Tochter wurde durch das Kinder- und Jugendpsychiatrische Zentrum Kiel-Schreventeich am 18.11.2025 eine Autismus-Spektrum-Störung im Sinne des ICD-10 F84.5 (Asperger-Syndrom) diagnostiziert. Diese Diagnose wird von der Behörde nicht in Frage gestellt.

Die Behörde geht jedoch davon aus, dass die schulische Teilhabe Ihrer Tochter durch die bereits gewährten Nachteilsausgleiche (Zeitverlängerung bei Klassenarbeiten, Rückzugsraum, reduzierte Präsentationen) hinreichend gesichert ist. Eine Schulbegleitung erscheint nicht notwendig im Sinne der Verhältnismäßigkeit. Lena Tannenberg erreicht in den Hauptfächern befriedigende bis gute Leistungen.

Im Übrigen ist nach Auffassung der Behörde nicht primär eine Eingliederungshilfe nach Paragraf 35a SGB VIII angezeigt, sondern eine pädagogische Förderung durch die Schule selbst (Schulgesetz Schleswig-Holstein) im Rahmen der inklusiven Beschulung.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landeshauptstadt Kiel - Jugendamt, Andreas-Gayk-Straße 31, 24103 Kiel, einzulegen.

Im Auftrag - Marlies Krempin, Sachbearbeiterin

Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie Dr. med. Carola Maibaum

Holtenauer Straße 220, 24105 Kiel - Tel. 0431/55512-0 - Facharztpraxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie

An die Familie Tannenberg - Datum 22. Februar 2026

Fachärztliche Stellungnahme zu Lena Tannenberg, geb. 03.09.2009

Lena Tannenberg ist bei mir seit November 2024 in Behandlung. Es liegt eine Autismus-Spektrum-Störung mit den Merkmalen des Asperger-Syndroms vor (ICD-10 F84.5). Diagnostisch gesichert durch ADOS-2 (Modul 4, Cutoff Autismus klar überschritten), ADI-R Elterninterview, sowie eingehende Verhaltensbeobachtung und Intelligenzdiagnostik (HAWIK-V Gesamt-IQ 121, dabei sehr heterogenes Profil).

Krankheitsbild und Auswirkung auf den Schulalltag

Lena ist intellektuell hochbegabt im Bereich logisch-mathematischen Denkens. Daneben bestehen erhebliche Beeinträchtigungen im Bereich sozialer Interaktion, der Reizverarbeitung (sensorische Hypersensitivität vor allem auf Lärm und Lichtreize) sowie der exekutiven Funktionen (Handlungsplanung, Aufgabenwechsel, Strukturierung).

Im schulischen Alltag bedeutet dies konkret: Lena kann den fachlichen Inhalten mühelos folgen. Gleichzeitig ist sie nicht in der Lage, ohne Strukturierungshilfe zwischen Phasen umzuschalten, Pausen sicher zu gestalten oder bei Gruppenarbeiten ihren Anteil einzubringen. In Stresssituationen (unangekündigter Lehrerwechsel, laute Klassenphasen) kommt es zu shutdown-Reaktionen mit Mutismus und teilweise zu Selbstverletzungen (Nägel-Kauen bis zum Bluten, Kratzen der Unterarme). Letztes dokumentiertes Ereignis am 04.02.2026 (Vermerk Schulleitung).

Notwendigkeit einer Schulbegleitung

Aus fachärztlicher Sicht ist eine individuelle, qualifizierte Schulbegleitung dringend erforderlich. Die bisherigen Nachteilsausgleiche reichen nicht aus, weil sie nur die Prüfungssituation, nicht aber den täglichen Unterrichts- und Pausenrahmen abdecken. Die Schulbegleitung muss insbesondere strukturieren, Reize filtern, Pausen begleiten und im Krisenfall einen Rückzug ermöglichen.

Ohne Schulbegleitung ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Verschlechterung der Symptomatik bis hin zu Schulabsentismus zu erwarten, was angesichts der hohen kognitiven Begabung Lenas ein vermeidbarer Bildungsverlust wäre.

Empfehlung

Schulbegleitung im Umfang von 25 Unterrichtswochenstunden, Qualifikationsniveau Heilerziehungspflege oder vergleichbar.

Dr. med. Carola Maibaum - Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie

Brief an Familie Tannenberg - Schulbegleitung für Lena

Kanzlei Holm · Petersen · Sönnichsen Rechtsanwälte mbB

RA Lasse Holm · Fachanwalt für Sozialrecht · Holstenstraße 124 · 24103 Kiel

Datum: 02. April 2026 - Az.: 2026/H-307

Sehr geehrte Frau Tannenberg, sehr geehrter Herr Tannenberg,

ich melde mich zu der Sache mit Lena und der Schulbegleitung. Die Lage ist so:

Was ist passiert?

Sie haben beim Jugendamt Kiel beantragt, dass Lena eine Schulbegleitung bekommt. Das Jugendamt hat das am 12. März 2026 abgelehnt. Der Brief liegt mir vor.

Was sagt das Jugendamt?

Das Jugendamt sagt zwei Sachen:

1. Die Diagnose Asperger-Syndrom wird nicht angezweifelt. Das ist wichtig.
2. Aber: Das Jugendamt meint, Lena komme in der Schule gut zurecht, sie habe ja gute Noten und schon Nachteilsausgleich.

Warum ist das aus meiner Sicht falsch?

- Gute Noten heißt nicht, dass alles in Ordnung ist. Lena verletzt sich selbst in Stresssituationen. Das hat die Schule am 04. Februar 2026 dokumentiert.
- Frau Dr. Maibaum (KJP) sagt klar: Schulbegleitung ist medizinisch notwendig.
- Die Schule selbst (Schulleiter Dr. Bock) unterstützt den Antrag.

Der Bescheid erklärt nicht, wie das Jugendamt den Bericht der Ärztin und den Bericht der Schule ausgewertet hat. Wir fragen nach, welche Unterlagen dort angekommen sind.

Was schlage ich vor?

3. Wir legen Widerspruch ein. Der Bescheid lag nach Ihrer Angabe am 14. März vor. Wir reichen den Widerspruch vorsorglich vor dem 14. April 2026 ein.
4. Wir reichen das KJP-Gutachten und das Schulgutachten nach.
5. Wenn das Jugendamt den Widerspruch zurückweist, kommt eine Klage beim Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht in Schleswig in Betracht.

Kosten

Sie haben eine Rechtsschutzversicherung (Allianz-Police, gemeldet). Ich kläre mit der Versicherung, ob diese Jugendhilfesache vom Vertrag erfasst ist, und frage eine Deckungszusage an.

Falls die Versicherung nicht zahlt: Wir könnten Prozesskostenhilfe beantragen. In dieser Jugendhilfesache fallen nach Paragraf 188 Satz 2 VwGO keine Gerichtskosten an. Anwaltskosten sind gesondert zu klären.

Was müssen Sie tun?

- Bitte führen Sie ab sofort ein kurzes Tagebuch über Krisensituationen Lenas (Datum, Auslöser, Dauer, Folge).
- Bitte sammeln Sie weitere Belege: Arztrechnungen, Therapie-Atteste, Schulberichte.
- Lassen Sie sich nichts vom Jugendamt sagen, was nicht schriftlich kommt.

Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich an. Ich melde mich, sobald die Versicherung geantwortet hat.

Mit freundlichen Grüßen

Lasse Holm - Rechtsanwalt, Fachanwalt für Sozialrecht

Gelehrtenschule des Johanneums - Stadtgymnasium Kiel

Feldstraße 19, 24105 Kiel - Schulleitung OStD Dr. Henning Bock

An die Eltern von Lena Tannenberg, Klasse 10b - Datum 08.02.2026

Schulische Stellungnahme zur Inklusionssituation

Lena Tannenberg ist eine außerordentlich begabte Schülerin mit Notendurchschnitt 1,8 (Naturwissenschaften: jeweils 1, Mathematik 1, Geschichte 2, Sport 4, Musik 3). Ihre fachliche Leistung ist hervorragend.

Die Klassenleitung (Frau Studienrätin Edelgard Hahn) berichtet wiederkehrend von Schwierigkeiten in der sozialen Integration. Lena verbringt Pausen meist allein im Bibliotheksraum, hat keine engeren Kontakte zu Mitschülerinnen und kann auf unerwartete Änderungen im Stundenplan nicht angemessen reagieren.

Am 04.02.2026 kam es nach einem unvorhergesehenen Vertretungsunterricht (sehr unruhige Klasse 9c im Nachbarraum, dadurch erhöhter Geräuschpegel) zu einer Krisensituation, in der Lena für ca. 90 Minuten nicht ansprechbar war und sich Kratzwunden an beiden Unterarmen zufügte. Schulpsychologin Frau Lentz wurde hinzugezogen.

Die Schule unterstützt den Antrag der Eltern auf Schulbegleitung. Aus pädagogischer Sicht ist insbesondere eine Pausenbegleitung und eine Begleitung in Fächern mit hohem Wechselanteil (Sport, Musik, Kunst) sinnvoll. Eine schulinterne Lösung über das vorhandene I-Helfer-Programm ist mangels Kapazität nicht möglich.

OStD Dr. Henning Bock - Schulleiter

Mit-Unterzeichnung: StRn Edelgard Hahn - Klassenleitung 10b

Vollmacht

Hiermit bevollmächtigen wir, **Bertha Tannenberg, geb. 14.06.1972, und Olaf Tannenberg, geb. 17.02.1964,** beide wohnhaft Adelheidstraße 17, 24103 Kiel, als gesetzliche Vertreter unserer minderjährigen Tochter **Lena Tannenberg, geb. 03.09.2009,** den **Rechtsanwalt Lasse Holm, Kanzlei Holm · Petersen · Sönnichsen Rechtsanwälte mbB, Holstenstraße 124, 24103 Kiel,** zur Vertretung in der sozialrechtlichen Angelegenheit "Eingliederungshilfe / Schulbegleitung" gegenüber dem Jugendamt Kiel und gegebenenfalls dem Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht.

Die Vollmacht erstreckt sich auch auf:

- **Akteneinsicht und Einsichtnahme in Verwaltungsvorgänge**
- **Einlegung von Widersprüchen und Rechtsmitteln**
- **Stellung von Eilanträgen**
- **Empfangnahme von Bescheiden und Zustellungen**
- **Vertretung gegenüber Versicherungen (Rechtsschutz)**

Kiel, 02.04.2026

_____ _____

Bertha Tannenberg Olaf Tannenberg

Holm Petersen Sönnichsen Rechtsanwälte mbB · Rechtsanwalt Lasse Holm
Holstenstraße 124 · 24103 Kiel
An die Landeshauptstadt Kiel · Jugendamt · Sachgebiet Eingliederungshilfe
Andreas-Gayk-Straße 31 · 24103 Kiel
5. April 2026 · Unser Zeichen 2026/H-307 · Ihr Zeichen JA-EH-2026-04711

Widerspruch wegen Schulbegleitung für Lena Tannenberg

Sehr geehrte Frau Krempin,

namens und in Vollmacht von Lena Tannenberg, geboren am 3. September 2009, Adelheidstraße 17, 24103 Kiel, gesetzlich vertreten durch Bertha und Olaf Tannenberg, lege ich gegen den Bescheid vom 12. März 2026 Widerspruch ein. Der Bescheid lag nach der dokumentierten Angabe der Eltern am 14. März 2026 vor. Der Widerspruch wird innerhalb der Monatsfrist des Paragrafen 70 Absatz 1 VwGO erhoben. Die Vollmacht der Sorgeberechtigten vom 2. April ist beigefügt.

1 Begehren und Umfang der Hilfe

Ich beantrage, den ablehnenden Bescheid aufzuheben und Lena ab Beginn des Schuljahres 2026/2027 ambulante Eingliederungshilfe in Form einer qualifizierten Schulbegleitung zu gewähren. Die fachärztliche Empfehlung von 25 Unterrichtswochenstunden bildet den Ausgangspunkt. Der Bescheid soll ausweisen, in welchem Umfang die Hilfe in den besonders belastenden Unterrichtsphasen, bei Wechseln und in den zugehörigen Pausen zur Verfügung steht. Dabei sind Unterrichtseinheiten und Zeitstunden in einer überprüfbaren Wochenplanung zu unterscheiden. Hilfsweise bitte ich um erneute Entscheidung nach vollständiger Erhebung des individuellen Bedarfs und um frühzeitige Hilfeplanung mit Lena, den Sorgeberechtigten, Schule und Fachpraxis. Die Akteneinsicht nach Paragraf 25 SGB X beantrage ich unabhängig davon zur weiteren Begründung.

Eine Entscheidung vor Beginn des neuen Schuljahres ist erforderlich, damit ein geeigneter Dienst für die tatsächlich benötigten Zeitfenster beauftragt werden kann. Sollte eine frühere Unterstützung wegen konkreter neuer Vorfälle erforderlich werden, werde ich den Bedarf mit den Eltern auf Grundlage aktueller Nachweise gesondert anzeigen. Eine private Beauftragung oder ein Kostenerstattungsbegehren ist bisher nicht Gegenstand dieses Schreibens.

2 Dokumentierte Ausgangslage

Lena besucht die Klasse 10b der Gelehrtenschule in Kiel. Die Schule bescheinigt einen Notendurchschnitt von 1,8 und sehr gute Leistungen in Mathematik und den Naturwissenschaften. Dieser Befund spricht für vorhandene fachliche Fähigkeiten und für den weiteren Besuch einer allgemeinen Schule. Er gibt keine Auskunft darüber, wie lange Lena ohne Begleitung im Klassenverband bleiben, einen Raumwechsel bewältigen oder in den Pausen mit anderen Schülerinnen zusammen sein kann. Gerade weil sie Lerninhalte auch unter erheblichen Schwierigkeiten noch bewältigt, ist der schulische Alltag getrennt von der Leistungsbewertung zu betrachten.

Die Klassenleitung berichtet, dass Lena die Pausen meist allein in einem Bibliotheksraum verbringt und bei unerwarteten Stundenplanänderungen Schwierigkeiten hat. Der Rückzugsraum entlastet sie in einer reizarmen Umgebung. Er gewährleistet für sich weder die rechtzeitige Orientierung auf dem Weg dorthin noch die Wiederaufnahme des Unterrichts. Die Schulstellungnahme nennt Sport, Musik und Kunst als Fächer mit erhöhtem Wechselanteil. In diesen Fächern sind beispielsweise der Übergang in einen anderen Raum, der Beginn von Gruppenphasen und der Wechsel zurück in den Klassenraum planungsrelevant. Für jede Phase ist zu klären, welche Unterstützung bereits tatsächlich geleistet wird.

Am 4. Februar 2026 traf ein unvorhergesehener Vertretungsunterricht mit zusätzlichem Lärm aus einem Nachbarraum zusammen. Die Schulstellungnahme vom 8. Februar beschreibt eine etwa 90 Minuten dauernde Krise und Kratzverletzungen an beiden Unterarmen. Die Schulpsychologin wurde hinzugezogen. Bitte ziehen Sie den zeitnahen Vermerk über diesen Vorfall und die Angaben der Klassenleitung bei. Für die Hilfeplanung sind insbesondere die ersten erkennbaren Anzeichen, der Zeitpunkt der Unterstützung, die Möglichkeit eines begleiteten Rückzugs und die Bedingungen der Rückkehr zu erfassen. Der einmalige Vorfall begründet für sich keine bestimmte wöchentliche Stundenzahl. Er belegt aber zusammen mit den wiederholt beobachteten Übergangsproblemen, dass die bisherigen Vorkehrungen eine wesentliche Lücke lassen.

3 Anspruchsvoraussetzungen

3.1 Fachärztlich festzustellende Abweichung

Paragraf 35a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB VIII verlangt eine mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate andauernde Abweichung der seelischen Gesundheit vom alterstypischen Zustand. Maßgeblich sind Beginn und Prognose der funktionell erheblichen Abweichung. Die Diagnose muss nicht bereits seit sechs Monaten formell feststehen. Im Bescheid wird der diagnostische Befund aus dem Kinder- und Jugendpsychiatrischen Zentrum vom 18. November 2025 nicht in Frage gestellt. Die Stellungnahme der Fachärztin Dr. Maibaum vom 22. Februar 2026 beschreibt eine Behandlung seit November 2024, eine Autismus-Spektrum-Störung nach ICD-10 F84.5 und konkrete Beeinträchtigungen der Reizverarbeitung und Handlungsplanung. Diese Dauer und die fachärztlich beschriebene Entwicklung stützen die notwendige Prognose.

Die Stellungnahme nach Paragraf 35a Absatz 1a SGB VIII dient der medizinischen Klärung. Soweit das Jugendamt Angaben zum Krankheitswert, zur Prognose oder zur fachlich erforderlichen Unterstützung als nicht hinreichend präzise ansehen, bitte ich um eine konkrete Rückfrage an die Fachpraxis nach entsprechend begrenzter Einwilligung. Die Bewertung der Teilhabebeeinträchtigung und die Hilfeentscheidung trifft das Jugendamt unter angemessener Berücksichtigung der ärztlichen Angaben. Die fachärztliche Empfehlung darf sowohl beim Umfang als auch beim erforderlichen Qualifikationsniveau überprüft werden.

3.2 Beeinträchtigung der Teilhabe im Schulalltag

Nach Paragraf 35a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB VIII muss aus der Abweichung eine bestehende oder zu erwartende Teilhabebeeinträchtigung folgen. Die ärztlich beschriebene erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Lärm und Veränderungen findet ihre konkreten Entsprechungen in den Schulbeobachtungen. Lena kann sich bei einem ungeplanten Wechsel mitunter nicht mehr orientieren, Anweisungen in der akuten Situation nicht umsetzen und den Klassenverband nicht ohne passende Unterstützung wieder erreichen. Die wiederkehrende Isolation in den Pausen betrifft zudem einen eigenständigen Teil der Schulteilhabe. Für die Hilfeentscheidung ist auch festzustellen, ob Lena bestimmte Kontaktformen selbst wünscht und welche davon ihr in reizärmeren Situationen gelingen. Ein selbst gewählter Rückzug in einer einzelnen Pause ist für sich noch kein Defizit.

Die bewilligte Zeitverlängerung hilft bei Leistungsnachweisen. Eine Reduzierung von Präsentationen kann Belastungen in bestimmten Stunden vermindern. Die fortbestehenden Schwierigkeiten bei Übergängen, Gruppenphasen und der Nutzung des Rückzugsraums werden damit nur teilweise erfasst. Bitte vergleichen Sie vorhandene schulische Unterstützungsmaßnahmen einzeln mit den tatsächlich belegten Bedarfssituationen.

4 Aufgaben der Begleitung und Verhältnis zur Schule

Die beantragte Hilfe richtet sich nach Paragraf 35a Absätze 2 und 3 SGB VIII in Verbindung mit Paragraf 112 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und Satz 3 SGB IX. Die Begleitperson soll angekündigte Änderungen mit Lena vorbereiten, Absprachen bei einem Raumwechsel überschaubar machen, in einer belastenden Pause beim Auffinden eines vereinbarten Rückzugsorts helfen und mit der Lehrkraft den Wiedereinstieg abstimmen. In Gruppenphasen kann sie Lena unterstützen, die bereits von der Lehrkraft erteilte Aufgabe und die vereinbarten Rollen für sich zu ordnen. Unterrichtsplanung, Vermittlung der Lerninhalte, Aufgabenstellung, Leistungsbewertung und schulische Aufsicht bleiben bei den dafür zuständigen Schulpersonen.

Der gemeinsame Unterricht nach Paragraf 5 Absatz 2 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes und die Pflichten der Schule bleiben nach Paragraf 10 Absatz 1 SGB VIII bestehen. Ein Verweis auf schulische Hilfe trägt die Ablehnung nur, wenn eine gleich geeignete Unterstützung im maßgeblichen Zeitraum tatsächlich bereitsteht oder rechtzeitig durchgesetzt werden kann. Vgl. BVerwG, Urteil vom 18. Oktober 2012, 5 C 21.11, ECLI:DE:BVerwG:2012:181012U5C21.11.0, Randnummern 19 und 38 bis 40. Das Urteil betrifft eine ältere Rechtslage und eine selbst beschaffte Hilfe. Sein Maßstab zur tatsächlichen Verfügbarkeit schulischer Hilfe ist für den hier erhobenen Einwand einschlägig. Die Schule hat erklärt, dass das schulinterne Hilfsprogramm keine Kapazität hat. Bitte ermitteln Sie, welche benannte Person bei den entscheidenden Übergängen und bei Ausfällen verlässlich zur Verfügung stünde. Die Beteiligten sind bereit, ein gleich wirksames Modell mit geteilten Unterstützungszeiten zu prüfen, sofern ein verlässlicher Rückzug und die erforderliche individuelle Krisenbegleitung gesichert sind.

5 Hilfeplanung und Ermittlung

Ich bitte um einen Termin nach Paragrafen 8 und 36 SGB VIII. Lena soll ihre Wünsche in einer für sie geeigneten Gesprächsform selbst vortragen können. Die Schule soll Stundenplan, vorhandene Ausgleiche, konkrete Zuständigkeiten und Lücken beisteuern. Dr. Maibaum kann nach Einwilligung zur erforderlichen Qualifikation und zur fachlichen Abgrenzung besonders belastender Zeitfenster Stellung nehmen. Auf dieser Grundlage können Umfang, Ansprechpartner, Vertretung und ein Überprüfungstermin nach den ersten Schulwochen festgelegt werden. Die Zahl der Krisen ist dabei nur ein Anhaltspunkt. Ebenso ist zu beobachten, ob Wege, Pausen und Gruppenphasen mit Hilfe tatsächlich wieder zugänglich werden.

Der Bescheid lässt nicht erkennen, wie Schulbericht und fachärztliche Stellungnahme ausgewertet wurden. Bitte teilen Sie mit, welche Fassungen wann eingingen und welche bei der Entscheidung vorlagen. Soweit Unterlagen fehlen, reiche ich sie mit diesem Schreiben erneut ein. Ich bitte um eine nachvollziehbare neue Sachentscheidung auf der Grundlage von Paragrafen 20 und 35 SGB X. Für die beantragte Hilfe des Jugendamts wäre im Fall einer ausbleibenden Abhilfe der Verwaltungsrechtsweg nach Paragraf 40 Absatz 1 VwGO eröffnet. Ich bitte um schriftliche Eingangsbestätigung und Mitteilung des geplanten Zeitpunkts der Hilfeplanung.

Mit freundlichen Grüßen
Lasse Holm
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Sozialrecht

6 Anlagen

Beigefügt sind die fachärztliche Stellungnahme vom 22. Februar 2026, die Schulstellungnahme vom 8. Februar 2026 und die Vollmacht der Sorgeberechtigten vom 2. April 2026. Den Vorfallvermerk vom 4. Februar und den genauen Umfang des schulischen Nachteilsausgleichs bitten wir im Verfahren gezielt beizuziehen.

Beobachtungszeitraum 2. bis 16. März 2026

Aufgeschrieben am jeweiligen Abend oder am Folgemorgen

Kiel, 17. März 2026

Beobachtungen in der Abendversorgung

1 Wie die Aufzeichnungen entstanden

Ich habe die Zeiten aus meinem Telefonkalender und aus den Notizzetteln neben dem Medikamentenfach übertragen. Wenn ich nachts nur aus dem Nebenraum zugerufen habe, ist das als Zuruf vermerkt. Wenn ich Margarete gestützt, ihre Kleidung gewechselt oder ihr die Tablette in die Hand gelegt habe, habe ich die Handlung aufgeschrieben. Das Blatt enthält nur die Dienste, bei denen ich selbst in der Wohnung war. An den übrigen Tagen lässt sich aus meiner Liste nicht schließen, dass sie allein zurechtkam.

Datum und ungefähre Zeit	Beobachtung	Welche Hilfe ich geleistet habe
2. März, 22.10 Uhr	Aufstehen zum Bad, zweimal auf die Armlehne zurückgesunken	Hände an Stuhl und Rahmen geführt, beim Aufstehen am Unterarm stabilisiert
4. März, 19.45 Uhr	Jacke zum Schlafen über Nachthemd angezogen	Jacke gereicht und zu Schlafanzughose angeleitet, Knöpfe der Jacke selbst geöffnet
7. März, 1.20 Uhr	Tür zum Flur auf, wollte mit Tasche zum Einkauf	Im Flur angesprochen, Tageszeit erklärt und zurück zum Bett begleitet
10. März, 20.15 Uhr	Abendtablette lag noch im Fach	Fach gezeigt, Tablette in die Hand gelegt und Einnahme mit Wasser beobachtet
13. März, 23.50 Uhr	Bettwäsche nass, Bett selbst verlassen	Wechselwäsche bereitgelegt und beim Ausziehen und Säubern geholfen
16. März, 18.30 Uhr	Wollte den Herd bedienen, obwohl das Essen bereitstand	Herd abgeschaltet, Tellerrand gezeigt, Essen danach selbst aufgenommen

2 Angaben zum Besuch des Medizinischen Dienstes

Am 18. März sollte die Gutachterin vormittags kommen. Margarete hat an manchen Vormittagen bessere Orientierung als am Abend. An diesem Morgen hatte ich das Frühstück, die Kleidung und die Medikamente vorher bereitgelegt. Ich möchte ergänzen, was ohne die Vorbereitung passiert. Die Liste zeigt einzelne beobachtete Situationen. Sie ist keine lückenlose Übersicht über Nächte und enthält keine Angaben zu den Zeiten des ambulanten Pflegediensts.

Bertha Tannenberg

AOK Nord-West - Pflegekasse

Kassenstraße 5, 24103 Kiel - Pflegeversicherung gemäß SGB XI

Az.: PV-2026-LB-88231 / Sachbearbeiterin Frau Reinhilde Storch

An Frau Margarete Tannenberg, vertr. durch Bevollmächtigte Bertha Tannenberg, Adelheidstraße 17, 24103 Kiel

Datum: 05. April 2026

B E S C H E I D über die Höherstufung des Pflegegrades

Sehr geehrte Frau Tannenberg, auf Ihren Antrag vom 02. Februar 2026 auf Höherstufung des Pflegegrades von Pflegegrad 3 auf Pflegegrad 4 ergeht folgender

Bescheid

Der Antrag wird abgelehnt. Es bleibt bei Pflegegrad 3.

Begründung

Grundlage der Entscheidung ist das Gutachten des Medizinischen Dienstes (MD) Nord vom 18.03.2026, erstellt durch Pflegegutachter Herrn Knut Wendelaar. Das Gutachten kommt zu einer Gesamtpunktzahl von 65,5 Punkten. Damit liegt die Versicherte im oberen Bereich von Pflegegrad 3 (47,5 bis unter 70 Punkte), erreicht jedoch nicht den für Pflegegrad 4 erforderlichen Schwellenwert von 70 Punkten.

Die Modulbewertung ergab im Einzelnen folgendes Bild (gewichtete Punkte):

Modul	Bezeichnung	Gewichtung	Punkte
1	Mobilität	10 Prozent	5,0
2	Kognitive Fähigkeiten	15 Prozent	11,25
3	Verhaltensweisen	15 Prozent	7,50
4	Selbstversorgung	40 Prozent	30,00
5	Krankheitsbewältigung	20 Prozent	5,75
6	Gestaltung des Alltags	15 Prozent	6,00
	Summe (Module 2 und 3 nur höherer Wert)		65,50

Die in Modul 2 und 3 nach SGB XI vorgesehene Saldierung wurde berücksichtigt; nur das höhere der beiden Module fließt in die Gesamtbewertung ein.

Eine darüber hinausgehende Verschlechterung der Pflegesituation im Vergleich zur Vorbegutachtung vom 11.07.2024 (damals 51,5 Punkte) konnte zwar festgestellt werden, reicht aber nicht aus, um Pflegegrad 4 zu erreichen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch zulässig. Der Widerspruch ist bei der AOK Nord-West, Kassenstraße 5, 24103 Kiel, einzulegen.

Im Auftrag - Reinhilde Storch

Hausärztliche Gemeinschaftspraxis Dr. Tjark Petersen / Dr. Sieglinde Petersen

Adelheidstraße 92, 24103 Kiel - Allgemeinmedizin, Geriatrie

An die Familie Tannenberg / Pflegekasse AOK Nord-West - Datum 25.03.2026

Ärztliche Stellungnahme zur Pflegesituation von Frau Margarete Tannenberg, geb. 04.07.1941

Frau Tannenberg ist seit 1978 in meiner / unserer Praxis durchgängig in hausärztlicher Betreuung. Ich kenne die Patientin somit über knapp 50 Jahre und kann die Entwicklung gut beurteilen.

Diagnosen

Diagnosen ICD-10: I63.5 Hirninfarkt (Mediainfarkt links 09/2024) / F03.0 Demenz nicht näher bezeichnet, leichtgradig bis mittelschwer / R47.0 Aphasie / S72.0 Z.n. Schenkelhalsfraktur links 01/2026 / I10.90 essenzielle Hypertonie / E11.9 Diabetes mellitus Typ 2.

Pflegerelevante Befunde

Seit dem Sturz mit Schenkelhalsfraktur im Januar 2026 hat sich der pflegerische Bedarf erheblich gesteigert. Die Patientin kann sich seither nicht mehr selbst die Beine anziehen, ist im Bad vollständig auf Hilfe angewiesen und kann nur noch wenige Schritte mit Rollator gehen.

Die Aphasie nach Hirninfarkt 09/2024 hat sich weder unter Logopädie noch durch Spontanverlauf wesentlich gebessert. Die Patientin spricht nur einzelne Worte. Die kognitive Verschlechterung ist klar progredient (MMSE 12/2025 = 18 Punkte; im Vergleich 09/2024 noch 23 Punkte vor dem Schlaganfall).

Ärztliche Einschätzung zur Pflegegradbewertung

Aus meiner langjährigen Kenntnis der Patientin und der aktuellen Befundlage halte ich die Einstufung in Pflegegrad 3 für nicht angemessen. Die Selbstversorgung (Modul 4) ist meiner Einschätzung nach in mindestens drei zentralen Bereichen (Körperpflege, An-/Auskleiden, Inkontinenzversorgung nachts) als vollständig unselbstständig zu bewerten. Bereits 2024 bestand Pflegegrad 3 mit 51,5 Punkten. Der Hirninfarkt 09/2024 und der Sturz mit Hüftfraktur 01/2026 haben die Pflegebedürftigkeit so deutlich erhöht, dass aus meiner Sicht eine Bewertung im Bereich Pflegegrad 4 (70 bis unter 90 Punkte) angemessen wäre.

Die Auswertung des Pflegetagebuchs der Schwiegertochter belegt, dass an mindestens 12 von 28 Tagen nächtliche Pflege im Umfang von 25 bis 50 Minuten erforderlich ist. Hinzu kommt die durchschnittliche tägliche Pflegezeit von 6 bis 7 Stunden, was Pflegegrad 4 entspricht.

Dr. med. Tjark Petersen - Facharzt für Allgemeinmedizin, ZB Geriatrie

Medizinischer Dienst Nord - Gutachten Pflegeversicherung

Pflegegutachter: Knut Wendelaar (examinierter Krankenpfleger) - Begutachtungsdatum: 18.03.2026, Hausbesuch

Versicherte: Margarete Tannenberg, geb. 04.07.1941, AOK NW Vers.-Nr. AN777-321-098-X, wohnhaft Adelheidstraße 17, 24103 Kiel, gemeinsam mit Sohn Olaf und Schwiegertochter Bertha Tannenberg

Anwesend: Schwiegertochter Bertha Tannenberg. Versicherte selbst orientiert, aber stark verlangsamt; lange Pausen vor Antworten. Gesprächsdauer ca. 55 Minuten.

Befund

Frau Tannenberg erlitt am 23.09.2024 einen Hirninfarkt (Mediainfarkt links) mit nachfolgender brachiofazialer Hemiparese rechts und expressiver Aphasie. Daneben besteht seit etwa zwei Jahren eine zunehmende kognitive Einschränkung im Sinne einer leichten bis mittelschweren Demenz (klinischer Verdacht; MMSE bei der hausärztlichen Untersuchung 12/2025 = 18 Punkte).

Die Versicherte ist auf einen Rollator angewiesen, kann jedoch im eigenen Wohnbereich mit Hilfe wenige Meter zurücklegen. Im Bad besteht erhebliche Sturzgefahr; ein Sturz mit Oberschenkelhalsbruch links Anfang Januar 2026 hat zu vorübergehender Bettlägerigkeit geführt; aktuell beginnender Wiederaufbau.

Modulbewertung

Modul 1 Mobilität: 5,0 gewichtete Punkte. Selbstständiger Positionswechsel im Bett möglich, Halten einer sitzenden Position selbstständig, Aufstehen mit Hilfe überwiegend selbstständig, Treppensteigen unmöglich.

Modul 2 Kognitive Fähigkeiten: 11,25 gewichtete Punkte. Erkennen vertrauter Personen überwiegend selbstständig, Erkennen von Risiken selten selbstständig, Treffen von Entscheidungen im Alltagsleben überwiegend unselbstständig.

Modul 3 Verhaltensweisen: 7,5 gewichtete Punkte. Nächtliche Unruhe ein- bis dreimal pro Woche, eingeschränkte Selbststeuerung; nach Schlaganfall depressive Verstimmung.

Modul 4 Selbstversorgung: 30,0 gewichtete Punkte. Waschen Oberkörper nur mit Hilfe, Duschen vollständig unselbstständig, An-/Auskleiden Oberkörper überwiegend unselbstständig, Untenherum vollständig unselbstständig, Toilettenbenutzung nachts vollständig unselbstständig.

Modul 5 Krankheitsbewältigung: 5,75 gewichtete Punkte. Medikamente werden vorbereitet, Injektionen nicht erforderlich.

Modul 6 Gestaltung des Alltagslebens: 6,0 gewichtete Punkte. Tagesgestaltung weitgehend angewiesen auf Angehörige.

Gesamtergebnis

Gesamtpunktzahl: 65,5 Punkte. Empfehlung: Pflegegrad 3.

Hinweise

Eine Begutachtung der Module 4 und 5 erfolgte ausschließlich anhand der Auskünfte der Angehörigen; die Versicherte konnte aufgrund der Aphasie keine eigenständigen Angaben machen. Ein geführtes Pflegetagebuch lag dem Gutachter vor, wurde im Zeitrahmen der Begutachtung jedoch nur kursorisch zur Kenntnis genommen.

Sturzereignisse seit Januar 2026 wurden besprochen, jedoch nicht im Detail in die einzelnen Modulwerte übertragen.

Wendelaar - Medizinischer Dienst Nord

Vorschau: Pflegetagebuch_Margarete_Februar_2026

Markdown-Vorschau der gleichnamigen XLSX-Datei. Berechnungen, Formeln und Formatierung nur im Original.

Sheet: Pflegetagebuch

Pflegetagebuch Margarete Tannenberg (geb. 04.07.1941)

Geführt von Schwiegertochter Bertha Tannenberg - Zeitraum 01.02.2026 bis 28.02.2026

Datum	Modul	Tätigkeit	Dauer (Min)	Häufigkeit /Tag	Selbständigkeit	Anmerkung	Hilfsperson
01.02.2026	Modul 4 Selbstversorgung	Duschen am Morgen	35	1	vollständig unselbständig	Sturz vermieden, Bertha hat geführt	Bertha
01.02.2026	Modul 4	An- und Auskleiden gesamt	25	2	überwiegend unselbständig	Knöpfe nicht möglich, Reißverschluss nicht möglich	Bertha
01.02.2026	Modul 1	Aufstehen aus Bett mit Rollator	8	4	überwiegend selbständig		Bertha (Hilfestellung beim ersten Aufstehen)
01.02.2026	Modul 4	Toilettengang nachts	15	3	vollständig unselbständig	Inkontinenzeinlage gewechselt 2x	Bertha
02.02.2026	Modul 4	Mahlzeitenzubereitung Frühstück	20	1	vollständig unselbständig	Mandantin nimmt zu sich, schmiert nicht selbst	Bertha
02.02.2026	Modul 3	Nächtliche Unruhe und Rufen	45	1	eingeschränkt	Bertha musste 02:30-03:15 Uhr aufstehen	Bertha
03.02.2026	Modul 2	Orientierungshilfe (Wo bin ich)	10	3	überwiegend unselbständig	Margarete fragt mehrfach nach dem Ehemann (verstorben 2019)	Bertha
04.02.2026	Modul 4	Waschung Unterkörper	20	1	vollständig unselbständig		Bertha
05.02.2026	Modul 1	Treppe (Hauseingang)	10	1	unmöglich ohne Hilfe zweier Personen	Termin Hausarzt; Olaf hat zusätzlich gestützt	Bertha + Olaf
06.02.2026	Modul 5	Medikamente stellen	10	1	unselbständig	Wochendispenser gefüllt durch	Bertha

						Bertha, Mandantin nimmt aus Dispenser	
07.02.2026	Modul 4	Toilettengang tagsüber	12	5	vollständig unselbständig	Hose öffnen, hinsetzen, reinigen alle nicht selbständig	Bertha
08.02.2026	Modul 3	Wahnhafte Äußerungen	15	1	eingeschränkt	Margarete sagt, jemand habe ihren Schmuck genommen	Bertha
09.02.2026	Modul 4	Duschen	35	1	vollständig unselbständig		Bertha
10.02.2026	Modul 4	An- und Auskleiden	25	2	überwiegend unselbständig		Bertha
11.02.2026	Modul 1	Aufstehen	8	4	überwiegend selbständig		Bertha
12.02.2026	Modul 4	Mahlzeiten	60	3	vollständig unselbständig	Sehr langsames Essen, oft muss Bertha füttern	Bertha
13.02.2026	Modul 3	Schreien nachts	30	1	eingeschränkt	01:00 Uhr nachts, Bertha 25 Minuten beruhigt	Bertha
14.02.2026	Modul 2	Erkennen der Schwiegertochter	5	2	überwiegend unselbständig	"Wer sind Sie?" 2x	Bertha
15.02.2026	Modul 4	Waschung Oberkörper	18	1	überwiegend unselbständig		Bertha
16.02.2026	Modul 1	Lagewechsel Bett	5	6	überwiegend selbständig		-
17.02.2026	Modul 4	Inkontinenzversorgung tagsüber	20	4	vollständig unselbständig	Bertha wechselt Einlage	Bertha
18.02.2026	Modul 6	Tagesgestaltung Aktivierung	60	1	vollständig unselbständig	Bertha liest vor, Margarete blickt apathisch	Bertha
19.02.2026	Modul 3	Nächtliche Unruhe	50	1	eingeschränkt		Bertha
20.02.2026	Modul 5	Wundversorgung kleine Hautläsion	10	1	unselbständig	Pflaster gewechselt	Bertha

		li Knöchel					
21.02.2026	Modul 4	Duschen	40	1	vollständig unselbständig	Sturzbeinahe in der Dusche, Bertha hat aufgefangen	Bertha
22.02.2026	Modul 1	Aufstehen	10	4	überwiegend unselbständig	Heute schwerer als sonst	Bertha
23.02.2026	Modul 4	Toilette nachts	15	3	vollständig unselbständig		Bertha
24.02.2026	Modul 2	Erkennen von Risiken	5	1	unselbständig	Wollte Herd anstellen ohne Pfanne	Bertha
25.02.2026	Modul 4	Mahlzeiten	55	3	vollständig unselbständig		Bertha
26.02.2026	Modul 4	An- und Auskleiden	30	2	überwiegend unselbständig		Bertha
27.02.2026	Modul 3	Nächtliche Unruhe	40	1	eingeschränkt		Bertha
28.02.2026	Modul 4	Duschen	35	1	vollständig unselbständig		Bertha
Auswertung							
Pflegeperson Bertha Tannenberg leistet derzeit ca. 6 bis 7 Stunden direkte Pflege pro Tag.							
Nächtliche Unruhe in ca. 12 von 28 Tagen mit Dauer 25-50 Minuten.							
Beinahe-Sturz in der Dusche am 21.02.2026 belegt erhöhte Selbstgefährdung.							

Pflegetagebuch Margarete Tannenberg (geb. 04.07.1941)

Geführt von Schwiegertochter Bertha Tannenberg - Zeitraum 01.02.2026 bis 28.02.2026

Datum	Modul	Tätigkeit	Dauer (Min)	Häufigkeit/ Tag	Selbstständigkeit	Anmerkung	Hilfsperson
01.02.2026	Modul 4 Selbstversorgung	Duschen am Morgen	35	1	vollständig unselbstständig	Sturz vermieden, Bertha hat geführt	Bertha
01.02.2026	Modul 4	An- und Auskleiden gesamt	25	2	überwiegend unselbstständig	Knöpfe nicht möglich, Reißverschluss nicht möglich	Bertha
01.02.2026	Modul 1	Aufstehen aus Bett mit Rollator	8	4	überwiegend selbstständig		Bertha (Hilfestellung beim ersten Aufstehen)
01.02.2026	Modul 4	Toilettengang nachts	15	3	vollständig unselbstständig	Inkontinenzeinlage gewechselt 2x	Bertha
02.02.2026	Modul 4	Mahlzeitenzubereitung Frühstück	20	1	vollständig unselbstständig	Mandantin nimmt zu sich, schmiert nicht selbst	Bertha
02.02.2026	Modul 3	Nächtliche Unruhe und Rufen	45	1	eingeschränkt	Bertha musste 02:30-03:15 Uhr aufstehen	Bertha
03.02.2026	Modul 2	Orientierungshilfe (Wo bin ich)	10	3	überwiegend unselbstständig	Margarete fragt mehrfach nach dem Ehemann (verstorben 2019)	Bertha
04.02.2026	Modul 4	Waschung Unterkörper	20	1	vollständig unselbstständig		Bertha
05.02.2026	Modul 1	Treppe (Hauseingang)	10	1	unmöglich ohne Hilfe zweier Personen	Termin Hausarzt; Olaf hat zusätzlich gestützt	Bertha + Olaf
06.02.2026	Modul 5	Medikamente stellen	10	1	unselbstständig	Wochendispenser gefüllt durch Bertha, Mandantin nimmt aus Dispenser	Bertha
07.02.2026	Modul 4	Toilettengang tagsüber	12	5	vollständig unselbstständig	Hose öffnen, hinsetzen, reinigen alle nicht selbstständig	Bertha
08.02.2026	Modul 3	Wahnhafte Äußerungen	15	1	eingeschränkt	Margarete sagt, jemand habe ihren Schmuck genommen	Bertha
09.02.2026	Modul 4	Duschen	35	1	vollständig unselbstständig		Bertha
10.02.2026	Modul 4	An- und Auskleiden	25	2	überwiegend unselbstständig		Bertha
11.02.2026	Modul 1	Aufstehen	8	4	überwiegend selbstständig		Bertha
12.02.2026	Modul 4	Mahlzeiten	60	3	vollständig unselbstständig	Sehr langsames Essen, oft muss Bertha füttern	Bertha
13.02.2026	Modul 3	Schreien nachts	30	1	eingeschränkt	01:00 Uhr nachts, Bertha 25 Minuten beruhigt	Bertha
14.02.2026	Modul 2	Erkennen der Schwiegertochter	5	2	überwiegend unselbstständig	"Wer sind Sie?" 2x	Bertha
15.02.2026	Modul 4	Waschung Oberkörper	18	1	überwiegend unselbstständig		Bertha
16.02.2026	Modul 1	Lagewechsel Bett	5	6	überwiegend selbstständig		-

17.02.2026	Modul 4	Inkontinenzversorgung tagsüber	20	4	vollständig unselbstständig	Bertha wechselt Einlage	Bertha
18.02.2026	Modul 6	Tagesgestaltung Aktivierung	60	1	vollständig unselbstständig	Bertha liest vor, Margarete blickt apathisch	Bertha
19.02.2026	Modul 3	Nächtliche Unruhe	50	1	eingeschränkt		Bertha
20.02.2026	Modul 5	Wundversorgung kleine Hautläsion li Knöchel	10	1	unselbstständig	Pflaster gewechselt	Bertha
21.02.2026	Modul 4	Duschen	40	1	vollständig unselbstständig	Sturzbeinahe in der Dusche, Bertha hat aufgefangen	Bertha
22.02.2026	Modul 1	Aufstehen	10	4	überwiegend unselbstständig	Heute schwerer als sonst	Bertha
23.02.2026	Modul 4	Toilette nachts	15	3	vollständig unselbstständig		Bertha
24.02.2026	Modul 2	Erkennen von Risiken	5	1	unselbstständig	Wollte Herd anstellen ohne Pfanne	Bertha
25.02.2026	Modul 4	Mahlzeiten	55	3	vollständig unselbstständig		Bertha
26.02.2026	Modul 4	An- und Auskleiden	30	2	überwiegend unselbstständig		Bertha
27.02.2026	Modul 3	Nächtliche Unruhe	40	1	eingeschränkt		Bertha
28.02.2026	Modul 4	Duschen	35	1	vollständig unselbstständig		Bertha

Auswertung

Pflegeperson Bertha Tannenberg leistet derzeit ca. 6 bis 7 Stunden direkte Pflege pro Tag.

Nächtliche Unruhe in ca. 12 von 28 Tagen mit Dauer 25-50 Minuten.

Beinahe-Sturz in der Dusche am 21.02.2026 belegt erhöhte Selbstgefährdung.

An die AOK Nord-West · Pflegekasse
Kassenstraße 5 · 24103 Kiel
Kiel, 28. April 2026 · PV-2026-LB-88231 · Entwurf zur Mandatsfreigabe

Widerspruch gegen die Ablehnung eines höheren Pflegegrades

Sehr geehrte Frau Storch,

namens und in Vollmacht von Frau Margarete Tannenberg, vertreten durch ihre Bevollmächtigte Bertha Tannenberg, lege ich gegen den Bescheid vom 5. April 2026 Widerspruch ein. Der Widerspruch richtet sich gegen die Ablehnung der beantragten Höherstufung. Wir bitten um Bewilligung von Pflegegrad 4 ab dem rechtlich maßgeblichen Zeitpunkt und um Nachzahlung der sich daraus ergebenden Leistungen. Die genaue Einordnung des Leistungsbeginns bleibt bis zur vollständigen Sachaufklärung und Prüfung des Leistungsbezugs vorbehalten.

Wir beantragen Akteneinsicht in den vollständigen Verwaltungsvorgang einschließlich der Einzelbewertungen, des Erfassungsbogens, der übermittelten Unterlagen und der Rechenfassung, aus der die Gewichtung abgeleitet wurde. Wir bitten ferner um eine erneute pflegefachliche Begutachtung, sofern die bisherige Bewertung anhand der Originaldaten und einer ergänzenden Erhebung nicht nachvollziehbar berichtigt werden kann.

1 Verfahrensgegenstand und zeitlicher Verlauf

Die Versicherte war bereits vor dem Ereignis im Januar 2026 in Pflegegrad 3 eingestuft. Für die frühere Begutachtung im Juli 2024 werden 51,5 Punkte angegeben. Der Schlaganfall vom September 2024, die nachfolgende Aphasie und die zunehmenden kognitiven Beeinträchtigungen betrafen bereits die Verständigung und die Ausführung mehrschrittiger Alltagshandlungen. Nach der Oberschenkelhalsfraktur im Januar 2026 kamen ein erhöhter Hilfebedarf beim Umsetzen und bei der Selbstversorgung hinzu. Die Familie stellte den Antrag auf Höherstufung am 2. Februar. Der Medizinische Dienst führte am 18. März vormittags einen Hausbesuch durch. Die hausärztliche Stellungnahme vom 25. März liegt zeitlich nach diesem Besuch. Aus der Verwaltungsakte ist zu klären, welche Befunde bei der Kassenentscheidung am 5. April ausgewertet worden sind.

Der Bescheid nennt einen Gesamtwert von 65,5 Punkten. Er gibt die Bewertung des Medizinischen Dienstes in zusammengefasster Form wieder. Weder die Einzelpunkte noch die Berechnungsschritte sind beigefügt. Eine sachgerechte Überprüfung setzt voraus, dass die bisher erfassten einzelnen Fähigkeiten und Unterstützungsleistungen identifiziert werden können. Die Versicherte verlangt keine Addition von Pflegeminuten. Entscheidend sind die im maßgeblichen Zeitraum voraussichtlich dauerhaft bestehenden Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit und der Fähigkeiten.

2 Rechenfehler und fehlende Einzelwerte

2.1 Nachrechnung der angegebenen Summen

Der Bescheid nennt für Mobilität 5,00 Punkte, für kognitive Fähigkeiten 11,25, für Verhaltensweisen 7,50, für Selbstversorgung 30,00, für krankheitsbedingte Anforderungen 5,75 und für Alltagsgestaltung 6,00. Werden alle sechs Angaben addiert, ergeben sich 65,50 Punkte. Der Bescheid erklärt zugleich, er habe für die Module 2 und 3 nur den höheren Wert berücksichtigt. Wäre dies mit den abgedruckten Werten geschehen, ergäben sich rechnerisch 58,00 Punkte. Beide Aussagen können nicht zugleich zutreffen.

Nach Paragraf 15 Absatz 3 SGB XI geht von den gewichteten Werten der Module 2 und 3 ausschließlich der höhere in die Summe ein. Das ist keine Minderung eines ansonsten feststehenden Gesamtwerts, sondern Teil des gesetzlich vorgeschriebenen Berechnungsschritts. Für die Module 5 und 6 sieht Anlage 2 außerdem keine gewichteten Zwischenwerte von 5,75 und 6,00 vor. Das kann auf einen Übertragungs-, Erfassungs- oder Berechnungsfehler hindeuten. Ohne den Originalbogen lässt sich aus den ausgewiesenen Zahlen keine zuverlässige korrigierte Gesamtbewertung ableiten. Eine bloße rechnerische Korrektur auf 58 Punkte würde die fehlerhaften Ausgangswerte übernehmen.

2.2 Kontrolle der Umrechnung

Die Einzelpunkte sind innerhalb jedes Moduls anhand der einschlägigen Kriterien der Anlage 1 zu ermitteln. Anschließend wird die Summe nach Anlage 2 in einen gewichteten Punktwert übertragen. Die Gewichtung ist kein freies Prozentrechnen mit frei festgelegten Zwischenwerten. Besonders bei Modul 4 können einige zusätzlich oder anders bewertete Einzelkriterien zu einem Wechsel in einen anderen Punktbereich führen. Ob eine solche Änderung eintritt, hängt von der vollständigen Rohpunktsumme ab. Diese ist hier nicht ersichtlich.

Zur Einordnung bitte ich um Mitteilung, welche Einzelpunkte im Modul 4 den gewichteten 30 Punkten zugrunde liegen. Wenn die Summe knapp unter 37 liegt, können eine unvollständig bewertete Toilettenbenutzung oder ein zusätzlicher Bedarf bei der Inkontinenzversorgung die Gewichtung verändern. Wenn die bisherige Rohpunktsumme wesentlich niedriger ist, reichen dieselben Änderungen dafür möglicherweise nicht. Der Widerspruch stützt sich auf konkrete Beobachtungen und verlangt ihre erneute Einordnung. Er setzt den Wechsel der Gewichtungsstufe nicht voraus.

3 Pflegefachliche Einwendungen

3.1 Umsetzen und Fortbewegung in der Wohnung

Der Medizinische Dienst hat beim Aufstehen eine teilweise Selbstständigkeit angenommen. Der Beobachtungsbogen vom März beschreibt, wie die Versicherte beim Aufstehen zum nächtlichen Toilettengang zweimal auf die Armlehne zurücksank. Bertha Tannenberg führte die Hände an Stuhl und Rahmen und stabilisierte die Versicherte am Unterarm. Es ist zu ermitteln, in welcher Häufigkeit dieser körperliche Einsatz erforderlich ist und welche Teile der Bewegung die Versicherte selbst vollzieht. Die Aussage, dass sie einzelne Schritte gehen kann, beantwortet nicht die Bewertung des Umsetzens oder das Fortbewegen in der Wohnung.

Der Hausbesuch fand vormittags statt. Die Schwiegertochter hatte Frühstück, Kleidung und Medikamente bereits vorbereitet. Das ist als Tatsachenangabe zur Untersuchungssituation relevant. Ein einzelner gelungener Ablauf unter günstigen Voraussetzungen darf nicht mit der regelmäßig gegebenen Selbstständigkeit gleichgesetzt werden. Umgekehrt genügt ein einzelner besonders schwieriger Abend nicht für die Annahme ständiger vollständiger Abhängigkeit. Zu ermitteln sind gewöhnliche und wiederkehrende Unterstützungen, auch in der zweiten Tageshälfte.

3.2 Selbstversorgung

Die hausärztliche Stellungnahme beschreibt Hilfe beim Unterkörperanziehen und vollständige Hilfe im Bad. Im Gutachten ist unter anderem festgehalten, dass das Duschen vollständig unselbstständig erfolgt und beim An- und Ausziehen deutliche Hilfe notwendig ist. Die verwendeten Formulierungen lassen nicht erkennen, ob Waschen des Oberkörpers, Intimpflege, Toilettenbenutzung und Umgang mit Inkontinenzmaterial einzeln erfasst wurden. Diese Handlungen betreffen verschiedene Kriterien. Der Hilfebedarf darf weder pauschal zusammengezogen noch für denselben Vorgang unbesehen doppelt angesetzt werden.

Der März-Bogen beschreibt in der Nacht zum 13. März nasse Bettwäsche. Die Versicherte hatte das Bett verlassen. Bertha legte Wechselwäsche bereit und half beim Ausziehen und Säubern. Für die Bewertung ist zu klären, ob und wie die Versicherte die Reinigung, den Wechsel von Kleidung und Hilfsmitteln sowie den nächsten Toilettengang selbst vorbereitet und ausführt. Die Fähigkeit, vom Bett aufzustehen, beantwortet diese Fragen nicht. Die Einordnung soll für wiederkehrende Abläufe erfolgen. Anhand der Pflegedokumentation kann geklärt werden, ob die Unterstützung ausschließlich vereinzelt nach außergewöhnlichen Ereignissen oder regelmäßig benötigt wird.

Am 4. März war die Versicherte in der Lage, die Knöpfe ihrer Jacke selbst zu öffnen. Sie hatte die Jacke zum Schlafen über das Nachthemd gezogen und brauchte Anleitung zur passenden Kleidung. Diese Beobachtung spricht für erhaltene Teilfähigkeiten, zeigt aber auch, dass die Reihenfolge und Auswahl der Kleidung nicht ohne Hilfe gelangen. Die unterschiedliche Art der Unterstützung sollte ausdrücklich berücksichtigt werden. Die kognitive Ursache einer erforderlichen Anleitung schließt eine Auswirkung auf die Selbstversorgung nicht aus. Bewertet werden die jeweils einschlägigen Kriterien, deren Inhalt und tatsächlicher Bedarf.

3.3 Kognitive Beeinträchtigung und nächtliche Unruhe

Der MD-Bericht nennt eine expressive Aphasie und eine verlangsamte Verständigung. Der MMSE-Wert von 18 Punkten ist ein medizinischer Anhaltspunkt und lässt sich nicht in Pflegepunkte umrechnen. Es ist festzustellen, ob die Versicherte Risiken erkennt, sich zeitlich zurechtfindet, Bedürfnisse mitteilt und Handlungen in mehreren Schritten steuern kann. Dazu sind konkrete Beobachtungen hilfreich. Am 7. März wollte sie nachts mit einer Einkaufstasche das Haus verlassen. Die Schwiegertochter musste sie ansprechen, die Uhrzeit erklären und zurück zum Bett begleiten. Dieser Vorgang betrifft andere Fragen als ein nächtlicher Toilettengang mit körperlicher Hilfe. Für eine Bewertung der Häufigkeit nächtlicher Unruhe muss erhoben werden, an welchen Tagen und mit welchem Anlass personelle Unterstützung erforderlich war.

Die Beobachtungsdaten decken nur die Anwesenheitszeiten der Schwiegertochter ab. Nicht protokollierte Nächte dürfen daher nicht automatisch als beschwerdefrei behandelt werden. Ebenso darf die Häufigkeit einer bestimmten Verhaltensweise nicht mit sämtlichen dokumentierten Nachtleistungen gleichgesetzt werden. Der Februar- und der März-Bogen sollten zeilenweise mit dem ambulanten Pflegedienst und der Familie abgeglichen werden. Der höhere gewichtete Wert aus Modul 2 oder 3 ist erst nach dieser Sachermittlung in die Gesamtwertung aufzunehmen.

3.4 Umgang mit Medikamenten und Alltag

Der Bericht des Medizinischen Dienstes erwähnt, dass Medikamente vorbereitet werden. Am 10. März lag die Abendtablette noch im Fach. Bertha zeigte das Fach, legte der Versicherten die Tablette in die Hand und beobachtete die Einnahme. Die Vorbereitung einer Wochenbox und die tatsächlich erforderliche Begleitung der einzelnen Einnahme sind sachlich verschieden. Zur Bewertung sind die ärztlich angeordnete Regelmäßigkeit, die selbstständige Einnahme und die gegebenenfalls erforderliche personelle Unterstützung zu erfassen. Eine einzelne Beobachtung begründet noch keinen täglichen Ansatz. Bitte ziehen Sie den aktuellen Medikationsplan und die Leistungsdokumentation bei.

Für die Alltagsgestaltung ist zu prüfen, welche Tätigkeiten die Versicherte aus eigener Initiative plant, beginnt und abschließt. Im Protokoll vom 16. März wollte sie den Herd bedienen, obwohl das Essen bereitstand. Nach Anleitung nahm sie das Essen selbst auf. Die Beobachtung spricht für eine erhaltene Fähigkeit bei der Aufnahme von Speisen und gleichzeitig für einen Unterstützungsbedarf bei der Organisation. Solche Befunde sind differenziert einzuordnen. Die Frage, ob der Kontakt zu anderen Personen eigenständig aufgenommen und gepflegt werden kann, wurde im Bescheid nicht aufgeschlüsselt.

4 Antrag auf weitere Sachaufklärung

Wir bitten um Übermittlung der vollständigen Einzelwerte, die Aufklärung der nicht erklärten gewichteten Punkte und eine pflegefachliche Neubewertung auf Grundlage der zeitlich zugeordneten Unterlagen. Bei einem neuen Termin sollten Bertha Tannenberg und möglichst eine mit der Versorgung vertraute Fachkraft teilnehmen. Vorab können Beobachtungen aus dem Alltag sowie die hausärztlichen Unterlagen ausgewertet werden. Die Untersuchung sollte neben einer Gesprächssituation konkrete Tätigkeiten und den bei ihnen tatsächlich erforderlichen Einsatz einer anderen Person erfassen. Die Belastung der Versicherten bei der Demonstration soll angemessen begrenzt werden.

Die Frakturversorgung und die Entwicklung seit Februar sind in der Prognose zu berücksichtigen. Eine vorübergehende akute Verschlechterung ist von längerfristigen Beeinträchtigungen zu trennen. Zu ermitteln ist, ab wann die Gesamtsituation nach den Unterlagen einen höheren Pflegegrad trägt. Das Leistungsbegehren darf weder allein wegen des jüngsten Untersuchungsdatums noch aus der historischen Einstufung im Juli 2024 beurteilt werden. Die beigefügten Aufzeichnungen und der hausärztliche Befund ergänzen sich dabei in Reichweite und Herkunft. Wir bitten um Abhilfe, wenn die nachvollziehbare Neubewertung die Schwelle für Pflegegrad 4 erreicht.

5 Anlagen

Vorgelegt werden der Bescheid vom 5. April, der MD-Bericht vom 18. März, die hausärztliche Stellungnahme vom 25. März, das Pflegetagebuch für Februar und der Beobachtungsbogen für März. Die geltend gemachte Vertretungsbefugnis und erforderliche Schweigepflichtentbindungen werden auf Anforderung belegt.

Lasse Holm · Rechtsanwalt

Deutsche Rentenversicherung Nord

Ziegelstraße 150, 23556 Lübeck - Rentenversicherungs-Nummer 47 110564 P 023

Az.: 47 110564 P 023 - EM-2026

An Herrn Bodo Petersen, Knooper Weg 184, 24118 Kiel

Datum: 15. April 2026

B E S C H E I D über Antrag auf Rente wegen Erwerbsminderung

Sehr geehrter Herr Petersen, über Ihren Antrag vom 14. November 2025 auf Gewährung einer Rente wegen voller Erwerbsminderung ergeht folgender Bescheid.

Entscheidung

Der Antrag auf Rente wegen voller Erwerbsminderung wird abgelehnt. Zugleich wird Ihnen Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung ab dem 01.06.2026 bewilligt. Höhe der Rente: monatlich brutto 743,28 Euro.

Begründung

Nach Paragraf 43 Absatz 2 SGB VI haben Anspruch auf Rente wegen voller Erwerbsminderung Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit außerstande sind, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein.

Bei Ihnen liegt nach sozialmedizinischer Begutachtung durch Herrn Dr. Wolf-Dieter Brunsbüttel (Internist, DRV-Gutachter) vom 27.02.2026 ein noch positives Leistungsvermögen von 3 bis unter 6 Stunden täglich vor. Sie sind somit teilweise erwerbsgemindert (Paragraf 43 Absatz 1 SGB VI), nicht jedoch voll erwerbsgemindert.

Berücksichtigt wurden die folgenden Befunde: chronisches Lumbalsyndrom mit Bandscheibenprotrusion L4/L5 und L5/S1, Z.n. Bandscheiben-OP L5/S1 im März 2023, mittelgradige depressive Episode (ICD-10 F32.1) in fachpsychiatrischer Behandlung seit 11/2024 sowie die Reha-Maßnahme in der Rehaklinik Bad Bramstedt 04/2024.

Trotz der gesundheitlichen Einschränkungen können Sie nach sozialmedizinischer Beurteilung in einer angepassten Tätigkeit ohne schweres Heben und Tragen, in wechselnder Körperhaltung und ohne hohen Zeitdruck noch 3 bis unter 6 Stunden täglich arbeiten.

Die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen (Paragraf 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 SGB VI) sind erfüllt: drei Jahre Pflichtbeiträge in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung und allgemeine Wartezeit erfüllt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Deutschen Rentenversicherung Nord, Ziegelstraße 150, 23556 Lübeck, einzulegen.

Im Auftrag - Dietlinde Hagenbeck, Sachbearbeiterin

KANZLEI HOLM - GESPRÄCHSNOTIZ
Datum: 21. April 2026, 14:00 - 15:10 Uhr
Mandant: Bodo Petersen, geb. 11.05.1964, Knooper Weg 184, 24118 Kiel
Vermittelt durch: Olaf Tannenberg (Schwager - Mandant in anderer Sache)
Anwesend: RA Holm, Bodo Petersen, Lebenspartnerin Karin Lorenzen

WORTPROTOKOLL Auszug:

Mandant: "Ich kann einfach nicht mehr. Seit der Bandscheibe geht nichts mehr richtig. Und dann kam diese Depression dazu. Ich liege manchmal Tage im Bett."

Karin Lorenzen: "Er hat es 2024 noch versucht mit Reha. Es ging eine Weile besser, dann kam wieder der Absturz. Wir leben jetzt von meinem Lohn und seinem Bett-ALG."

RA Holm: "ALG I oder Bürgergeld?"

Mandant: "Aufstockendes Bürgergeld."

Diagnosen vorgelegt:
- Bandscheibenvorfall L5/S1, OP 03/2023
- Mittelgradige bis schwere depressive Episode F33.2 rez.
- Chronisches LWS-Syndrom
- Z.n. Reha Bad Bramstedt 03-04/2024

Unterlagen zur Akte:
- DRV-Bescheid 15.04.2026 (volle EM abgelehnt, teilweise bewilligt 743,28 EUR)
- Sozialmedizinisches Gutachten DRV (Dr. Brunsbüttel 27.02.2026)
- Reha-Entlassungsbericht Bad Bramstedt (Dr. Holzwehr-Sieben 24.04.2024)
- Attest Dr. Lornsen-Joost 06.04.2026 (psychiatrisch)

Strategie:
- Widerspruch gegen Ablehnung der vollen EM
- Hauptargument: Wechselwirkung Schmerz + Depression vom DRV-Gutachter nicht hinreichend gewürdigt
- Behandelnde Ärztin im Gegensatz zum Einmal-Gutachter
- Hilfsweise: Arbeitsmarktrente (BSG B 13 RJ 79/97 R)
- Im Falle der Klage: PKH (SG ist gerichtskostenfrei nach Paragraf 183 SGG, aber Anwaltskosten nicht)
- Frist: bis 18.05.2026
- Versicherung: keine Rechtsschutz (geprüf.)

Mandantin Karin verständigt sich mit Mandant, dass sie ihn zu Terminen begleitet.

Mandat angenommen 21.04.2026, Vollmacht unterzeichnet.

H. Holm

Praxis Dr. med. Edda Lornsen-Joost

Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie - Holstenstraße 78, 24103 Kiel

Datum: 06.04.2026

Attest Herr Bodo Petersen, geb. 11.05.1964

Herr Petersen ist seit November 2024 in meiner ambulanten Behandlung. Wegen mittelgradiger bis zeitweise schwerer depressiver Episode (ICD-10 F33.2 rezidivierend) bei chronischem Schmerzsyndrom besteht eine eingeschränkte Belastbarkeit.

Trotz konsequenter antidepressiver Behandlung (Citalopram 20 mg, zuletzt erhöht auf 30 mg, geplante Umstellung auf Venlafaxin) und Psychotherapie (kognitive Verhaltenstherapie, 1x pro Woche) zeigt sich seit Aufnahme der Behandlung keine wesentliche Besserung. Insbesondere Konzentrationsstörungen, Antriebsmangel und chronische Erschöpfung bestehen unverändert.

Aus psychiatrischer Sicht ist Herr Petersen unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes derzeit nicht in der Lage, einer Erwerbstätigkeit von mehr als drei Stunden täglich nachzugehen. Insbesondere die Notwendigkeit zur regelmäßigen Anwesenheit, zur kognitiven Konzentration und zur sozialen Interaktion (kollegiale Einbindung, Kundenkontakt) ist krankheitsbedingt aktuell nicht realisierbar.

Das sozialmedizinische Gutachten der DRV vom 27.02.2026 (Dr. Brunsbüttel) beruht auf einer einzigen Untersuchung von 100 Minuten Dauer und berücksichtigt aus meiner Sicht das Wechselspiel zwischen Schmerz und depressivem Syndrom nicht hinreichend.

Dr. med. Edda Lornsen-Joost - Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie

Klinik Bad Bramstedt - Orthopädie und Psychosomatik

Oskar-Alexander-Straße 26, 24576 Bad Bramstedt

Entlassungsbericht - Rehamassnahme 25.03.2024 bis 22.04.2024

Versicherter: Bodo Petersen, geb. 11.05.1964

Behandlungsverlauf

Aufnahme mit der Hauptdiagnose lumbales Bandscheibensyndrom nach NPP-OP L5/S1 sowie reaktiv-depressiver Verstimmung. Multimodale Therapie: physiotherapeutisch, medizinische Trainingstherapie, Schmerzbewältigungsgruppe, psychotherapeutische Einzelgespräche.

Im Verlauf zunehmend depressive Symptomatik mit ausgeprägter Erschöpfung und Hoffnungslosigkeit. Aufnahme einer antidepressiven Medikation (Citalopram).

Sozialmedizinische Epikrise

Der Patient ist für die letzte berufliche Tätigkeit als Maurer auf Dauer nicht mehr leistungsfähig. Auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sehen wir den Patienten bei Entlassung nur in qualitativ stark eingeschränkten Tätigkeiten 3 bis unter 6 Stunden täglich leistungsfähig. Eine deutliche Besserung des Leistungsbildes ist bei chronifizierter Schmerz- und Depressionssymptomatik nicht zu erwarten.

Wir empfehlen die Prüfung einer Rente wegen Erwerbsminderung.

Dr. Astrid Holzwehr-Sieben - Chefärztin Psychosomatik

Deutsche Rentenversicherung Nord - Sozialmedizinisches Gutachten

Gutachter: Dr. med. Wolf-Dieter Brunsbüttel, FA für Innere Medizin und Sozialmedizin

Untersuchung: 27.02.2026, 09:30 bis 11:10 Uhr (100 Minuten)

Versicherter: Bodo Petersen, geb. 11.05.1964, Beruf bis 2023: Maurer

Anamnese

Der Versicherte berichtet über seit 2018 zunehmende Rückenschmerzen, insbesondere LWS-Bereich. 2020 erstmals Lumbago, 2023 Bandscheibenvorfall L5/S1, OP im März 2023 (Kiel-Wellingdorf). Nach OP zunächst Besserung, ab Sommer 2024 erneut Beschwerden, jetzt belastungsabhängig, mit Ausstrahlung in beide Beine.

Daneben besteht laut Versichertem seit Ende 2024 eine depressive Erkrankung mit Erschöpfung, Schlafstörung, Antriebsmangel; Behandlung bei Dr. Edda Lornsen-Joost (Fachärztin Psychiatrie und Psychotherapie) seit November 2024. Aktuelle Medikation Citalopram 20 mg.

Untersuchungsbefund

Schlanker Versicherter in altersentsprechendem Allgemeinzustand. LWS-Klopfschmerz, eingeschränkte Beweglichkeit der LWS (Finger-Boden-Abstand 35 cm). Lasègue-Zeichen links bei 60 Grad positiv, rechts negativ. Periphere DMS unauffällig. Kein motorisches Defizit. Psychischer Befund: niedergeschlagen, jedoch im Gespräch zugewandt, Konzentration durchgehend ausreichend, keine Suizidalität.

Diagnosen

M54.5 Kreuzschmerz - M51.1 Lumbale Bandscheibenschäden mit Radikulopathie - F32.1 Mittelgradige depressive Episode - Z.n. NPP-OP L5/S1 (03/2023)

Sozialmedizinische Beurteilung

Die Erwerbstätigkeit als Maurer ist dem Versicherten dauerhaft nicht mehr möglich (schweres Heben, Zwangshaltungen).

Auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sehe ich den Versicherten in einer angepassten Tätigkeit (leichte Arbeiten, überwiegend sitzend, wechselnde Körperhaltung, ohne häufiges Bück- und Hebearbeit, ohne erheblichen Zeitdruck) noch in der Lage, 3 bis unter 6 Stunden täglich zu arbeiten.

Die depressive Episode wird unter laufender Behandlung als grundsätzlich besserungsfähig eingestuft. Eine vollständige Aufhebung des Leistungsvermögens für leichte Tätigkeiten ist aus internistisch-sozialmedizinischer Sicht nicht begründbar.

Empfehlung: Bewilligung Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung auf Zeit (zwei Jahre).

Dr. Brunsbüttel

Kanzlei Holm · Petersen · Sönnichsen Rechtsanwälte mbB
Holstenstraße 124 · 24103 Kiel

Deutsche Rentenversicherung Nord
Ziegelstraße 150
23556 Lübeck

Kiel, 2. Mai 2026

Widerspruch gegen die Ablehnung der vollen Erwerbsminderungsrente

Bodo Petersen, geboren am 11. Mai 1964
RV-Nummer 47 110564 P 023 · Bescheid vom 15. April 2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

1 Anträge und Umfang des Widerspruchs

Namens und in Vollmacht von Herrn Bodo Petersen lege ich gegen Ihren Bescheid vom 15. April 2026 Widerspruch ein, soweit Sie den Antrag vom 14. November 2025 auf Rente wegen voller Erwerbsminderung abgelehnt haben. Ich beantrage, den Bescheid insoweit zu ändern und Rente wegen voller Erwerbsminderung ab dem frühestmöglichen gesetzlichen Rentenbeginn zu bewilligen. Vorrangig stütze ich den Antrag auf das gesundheitlich bedingte Leistungsvermögen. Sollte sich ein verlässlich nutzbares Leistungsvermögen von drei bis unter sechs Stunden ergeben, beantrage ich hilfsweise, den Anspruch bei Verschlossenheit des Teilzeitarbeitsmarkts zu prüfen. Die Bewilligung der Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung ab 1. Juni 2026 in Höhe von 743,28 Euro brutto monatlich wird mit diesem Widerspruch nicht angegriffen.

Der Bescheid ging Herrn Petersen nach seinen Angaben am 18. April 2026 zu. Bei diesem Zugang endet die Monatsfrist nach Paragraf 84 Absatz 1 und Paragraf 64 SGG am 18. Mai 2026. Bitte bestätigen Sie den Eingang dieses Schreibens. Meine Vollmacht liegt bei.

2 Gesundheitlicher Verlauf und Befunde

2.1 Körperliche Einschränkungen

Herr Petersen hat bis 2023 als Maurer gearbeitet. Im März 2023 wurde der Bandscheibenvorfall L5/S1 operiert. Dr. Brunsbüttel dokumentiert eine anfängliche Besserung und seit Sommer 2024 erneut belastungsabhängige Schmerzen mit Ausstrahlung in beide Beine. Bei der Untersuchung am 27. Februar 2026 fanden sich ein Klopfschmerz der Lendenwirbelsäule, eine eingeschränkte Beweglichkeit mit einem Finger-Boden-Abstand von 35 cm und ein links bei 60 Grad positives Lasègue-Zeichen. Die periphere Durchblutung, Motorik und Sensibilität waren unauffällig. Ein motorischer Ausfall war nicht feststellbar. Das trägt die Annahme, dass einzelne leichte Verrichtungen möglich sein können. Für die Dauer des Sitzens, die Häufigkeit notwendiger Haltungswechsel und die Wiederholbarkeit der Belastung über die Woche fehlen konkrete Angaben.

2.2 Verlauf seit der Rehabilitation

Der Bericht der Klinik Bad Bramstedt vom 24. April 2024 betrifft die Rehabilitation vom 25. März bis zum 22. April 2024. Er hält die Arbeit als Maurer auf Dauer für ausgeschlossen. Für den allgemeinen Arbeitsmarkt bewertet die Klinik die Leistungsdauer bei Entlassung mit drei bis unter sechs Stunden täglich und erheblichen qualitativen Einschränkungen. Während der Maßnahme nahmen Erschöpfung,

Hoffnungslosigkeit und depressive Beschwerden zu. Die Klinik begann eine antidepressive Behandlung, hielt eine deutliche Besserung bei Chronifizierung für wenig wahrscheinlich und empfahl die Prüfung einer Erwerbsminderungsrente. Dieser Bericht liefert einen früheren Vergleichsbefund. Er ist mit der ab November 2024 dokumentierten fachpsychiatrischen Behandlung und den Befunden im Frühjahr 2026 abzugleichen.

2.3 Psychiatrische Behandlung und Alltag

Dr. Edda Lornsen-Joost behandelt Herrn Petersen seit November 2024. Ihr Attest vom 6. April 2026 berichtet von mittelgradiger bis zeitweise schwerer depressiver Symptomatik mit Konzentrationsstörungen, Antriebsmangel und Erschöpfung. Trotz wöchentlicher kognitiver Verhaltenstherapie und Erhöhung der Citalopram-Dosis von 20 auf 30 mg habe sich keine wesentliche Besserung gezeigt. Die Ärztin erwägt eine Umstellung auf Venlafaxin. Zum Zeitpunkt der Bescheiderteilung lag noch kein dokumentierter Behandlungserfolg dieser Umstellung vor. Dr. Lornsen-Joost hält regelmäßige Anwesenheit, Konzentration und soziale Einbindung am Arbeitsplatz aktuell für nicht verlässlich umsetzbar und begrenzt die Dauer auf höchstens drei Stunden täglich. Diese Formulierung lässt exakt drei Stunden rechnerisch offen. Für die gesetzliche Schwelle kommt es darauf an, ob der Versicherte diese Dauer regelmäßig und unter üblichen Bedingungen tatsächlich erreicht.

Herr Petersen berichtet, an schlechten Tagen bleibe er längere Zeit im Bett. Seine Lebenspartnerin Karin Lorenzen hat am 21. April 2026 geschildert, dass die anfängliche Stabilisierung nach der Rehabilitation nicht anhielt. Seit 2023 hat er keine Erwerbstätigkeit wieder aufgenommen. Die Beobachtungen im Haushalt können Verlauf, Regelmäßigkeit und den Bedarf an Unterstützung erhellen. Die Zahl und Dauer schlechter Tage und die Wegefähigkeit sind bisher nicht konkret erhoben. Der in der Besprechung angesprochene Bezug aufstockender Grundsicherungsleistungen sagt für sich genommen nichts über das medizinische Leistungsvermögen aus.

3 Prüfung der vollen Erwerbsminderung

3.1 Einsatzdauer unter üblichen Arbeitsbedingungen

Nach Paragraf 43 Absatz 2 SGB VI setzt volle Erwerbsminderung aus gesundheitlichen Gründen voraus, dass eine Person wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes weniger als drei Stunden täglich arbeiten kann. Bei drei bis unter sechs Stunden ist die teilweise Erwerbsminderung nach Absatz 1 zu prüfen. Maßgeblich ist der allgemeine Arbeitsmarkt. Die feststehende Unfähigkeit zur Maurertätigkeit erklärt deshalb den beruflichen Einschnitt, lässt die Dauer anderer Tätigkeiten aber offen.

Der Bescheid leitet die Spanne von drei bis unter sechs Stunden aus dem Gutachten vom 27. Februar ab. Die darin beobachtete ausreichende Konzentration, das zugewandte Gespräch und der neurologische Befund sind zu berücksichtigen. Die Untersuchung dauerte von 9.30 bis 11.10 Uhr. In dieser Situation musste Herr Petersen weder über drei Stunden Arbeitsaufgaben erledigen noch an aufeinanderfolgenden Tagen eine Arbeitsleistung wiederholen. Das Gutachten führt nicht aus, welche Belastung bei einer sitzenden Tätigkeit mit wechselnder Haltung zu erwarten ist, nach welcher Zeit ein schmerzbedingter Wechsel nötig wird und ob sich die Konzentration nach einem solchen Wechsel wiederherstellen lässt. Die gesundheitliche Reichweite der Annahme „grundsätzlich besserungsfähig“ bleibt ohne benannten Zeitraum und ohne Bezug zum bisherigen Behandlungsverlauf offen.

3.2 Zusammenwirken der Beschwerden

Die orthopädischen und psychiatrischen Einschränkungen müssen bei ein und derselben Tätigkeit betrachtet werden. Ein Sitz-Steh-Wechsel kann die Wirbelsäule entlasten. Wenn Schmerzen wiederholt einen Wechsel oder eine Unterbrechung erzwingen, kann dies bei gleichzeitig verlangsamtem Antrieb

die Wiederaufnahme einer Aufgabe erschweren. Umgekehrt kann eine Arbeit ohne hohen Zeitdruck die Anforderungen an die Geschwindigkeit senken, setzt aber noch immer voraus, dass der Versicherte erscheint, Anweisungen aufnimmt und sich auf eine Folge von Aufgaben konzentriert. Zu untersuchen ist deshalb, ob etwa leichte Kontroll- oder Sortierarbeiten über mindestens drei Stunden mit vorhersehbaren Unterbrechungen durchgeführt werden können. Auch eine Tätigkeit mit geringer Kundenexposition erfordert eine Mindestfähigkeit zur Zusammenarbeit und Anpassung an Anweisungen.

Die Dauerbeobachtung der Fachärztin und die Untersuchung des Gutachters beleuchten verschiedene Belastungssituationen. Ihr Aussagewert ergibt sich aus Befundgrundlage, zeitlicher Nähe und Begründung. Ich bitte darum, den Konflikt zwischen der im Gespräch erhaltenen Konzentration und der von der Fachärztin beschriebenen mangelnden Ausdauer anhand des tatsächlichen Verlaufs zu klären. Soweit auch nach der Klärung zeitlich ausreichende Leistung angenommen wird, sind erhebliche qualitative Einschränkungen danach zu beurteilen, welche üblichen leichten Verrichtungen sie in ihrer konkreten Kombination noch zulassen. Das entspricht dem Prüfungsmaßstab des Bundessozialgerichts im Urteil vom 11. Dezember 2019, B 13 R 7/18 R, Randnummern 29 bis 38. Die Entscheidung behandelt die Grenzen der Verwertbarkeit auch bei einem zeitlich ausreichenden Leistungsvermögen. Sie ersetzt hier die Feststellung der individuellen Leistungsdauer nicht.

3.3 Hilfsweise Prüfung des Teilzeitarbeitsmarkts

Bleibt es bei der Einschätzung von drei bis unter sechs Stunden, ist zu prüfen, ob Herr Petersen unter den ermittelten Einschränkungen einen geeigneten Teilzeitarbeitsplatz tatsächlich innehat oder ihm ein solcher Arbeitsplatz zugänglich ist. Die Verwaltungspraxis der Deutschen Rentenversicherung stellt hierfür auf die erreichbaren Beschäftigungsmöglichkeiten ab und berücksichtigt eine konkrete, gesundheitlich zumutbare Vermittlungsmöglichkeit. Die Beurteilung kann daher nicht allein aus dem Lebensalter, der bisherigen Arbeit als Maurer oder dem Wohnort Kiel abgeleitet werden. Derzeit ist kein Arbeitsverhältnis mit verwertbarer Teilzeitbeschäftigung bekannt. Ich bitte um Ermittlung des Beschäftigungs- und Vermittlungsstands sowie darum, etwaige konkrete Einsatzmöglichkeiten anhand von Arbeitszeit, notwendigem Haltungswechsel, Pausen, Konzentrationsanforderungen und Erreichbarkeit zu prüfen.

4 Weitere Ermittlungen und Akteneinsicht

Ich bitte nach Paragraf 20 SGB X um aktuelle Befundberichte der psychiatrischen Praxis und der behandelnden orthopädischen Stellen. Zu klären sind die Häufigkeit und Dauer schlechter Tage, die Folgen der Schmerzen für Konzentration und Anwesenheit, die zumutbare Dauer einzelner Sitz- und Stehphasen sowie der Bedarf an zusätzlichen oder ungeplanten Pausen. Die Befunde sollen sich zur Entwicklung seit der Entlassung 2024, zum Behandlungsverlauf und zur voraussichtlichen Dauer der funktionellen Einschränkungen äußern. Bitte klären Sie ferner, welche Strecke Herr Petersen zu Fuß regelmäßig bewältigen kann, wie sich die Beschwerden bei Wartezeiten entwickeln und welche Verkehrsmittel er für Arbeitswege nutzen könnte. Soweit die Berichte keine schlüssige Gesamtschau ermöglichen, rege ich eine ergänzende psychiatrische Begutachtung unter Einbeziehung der orthopädischen Befunde an. Ein etwaiges anderes Ergebnis ist anhand der tatsächlichen Arbeitsanforderungen zu begründen.

Nach Paragraf 25 SGB X beantrage ich Einsicht in die für die Interessenwahrnehmung erforderlichen Unterlagen. Das umfasst insbesondere die vollständige sozialmedizinische Stellungnahme nebst Auftrag und Vorbefunden, gegebenenfalls ergänzende Leistungsbewertungen sowie die Unterlagen zur Prüfung der Vermittlung. Bitte stellen Sie die Akte in zulässiger elektronischer Form zur Verfügung und gewähren Sie nach der Einsicht Gelegenheit zur ergänzenden Stellungnahme.

Die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen wurden im angefochtenen Bescheid für die teilweise Erwerbsminderung bejaht. Für den im Widerspruch gegebenenfalls festzustellenden Leistungsfall bitte ich um Abgleich mit dem Versicherungsverlauf. Der Zeitpunkt der Antragstellung und der bewilligte Teilrentenbeginn beantworten den Beginn der vollen Rente nicht allein. Bitte stellen Sie den Eintritt der jeweiligen Minderung anhand des Verlaufs fest und bestimmen Sie den Rentenbeginn nach Paragrafen 99 und 101 SGB VI. Über eine Befristung ist anhand von Paragraf 102 SGB VI und der konkret festgestellten Prognose zu entscheiden.

Mit freundlichen Grüßen

Lasse Holm
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Sozialrecht

Anlagen

1. Attest von Dr. Edda Lornsen-Joost vom 6. April 2026
2. Reha-Entlassungsbericht der Klinik Bad Bramstedt vom 24. April 2024
3. Vollmacht

Kanzleiinterne Notiz zur Prozesskostenhilfe

Bei einer späteren Klage die Erfolgsaussicht und die persönlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen für Prozesskostenhilfe nach Paragraf 73a SGG in Verbindung mit Paragraf 114 ZPO prüfen. Für die gesonderte Erklärung aktuelle Leistungsbescheide, Miet- und Wohnkostenbelege, Kontoauszüge und Angaben zu Vermögen einholen. Die Angaben aus dem Erstgespräch reichen für eine abschließende Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nicht aus.

Datei: Email_Sanitaetshaus_Olaf_Rollstuhl_12-08-2026.eml

Von	Hendrik Paulsen <h.paulsen@reha-aktiv-nord.de>
An	RA Lasse Holm <holm@hps-kanzlei-kiel.de>
Kopie	Stefanie Tannenberg <stef.tannenberg@gmail.com>
Datum	Wed, 12 Aug 2026 09:26:53 +0200
Betreff	Herr Olaf Tannenberg - Kostenvoranschlag Quickie Helium abgelaufen, Leihversorgung, Lieferzeit

Sehr geehrter Herr Holm,

Frau Tannenberg hat uns gebeten, Ihnen für das laufende Verfahren den aktuellen Stand direkt zu schicken. Ich fasse zusammen:

1. Unser Kostenvoranschlag vom Februar über 5847,00 Euro brutto war 90 Tage gültig und ist seit Mitte Mai abgelaufen. Der Hersteller hat zum 1. Juli die Listenpreise angehoben, nach aktueller Kalkulation liegt die Versorgung jetzt bei 6114,00 Euro brutto. Die Maße aus der Sitzprobe vom 6. Februar sind weiterhin verwendbar, eine neue Sitzprobe wäre nur bei deutlicher Gewichtsveränderung nötig. Ich kann den neuen Preis bis zum 30.09. festhalten, danach müsste ich neu kalkulieren.

2. Zur Lieferzeit: Der Quickie Helium mit Einhandantrieb ist eine Sonderanfertigung, aktuell rechnet das Werk mit sechs bis acht Wochen ab Bestelleingang. Bestellen können wir wie gehabt erst nach schriftlicher Kostenübernahme oder privater Beauftragung.

3. Zur Zwischenversorgung: Herr Tannenberg hat bei uns am 04.08. nach einem Leihrollstuhl gefragt. Wir haben derzeit nur Standard-Faltrollstühle im Leihpool (Modell B-Ware, ca. 19 kg, beidhändiger Greifreifenantrieb). Bei der Erprobung im Laden am 06.08. konnte Herr Tannenberg das Gerät mit der linken Hand nicht kontrolliert antreiben, nach etwa 15 Metern im Gang musste die Tochter schieben. Wir haben ihm das Gerät trotzdem kostenlos bis Ende September überlassen, damit überhaupt etwas da ist. Ein Leih-Aktivrollstuhl mit Einhandantrieb ist im Pool nicht vorhanden und nach Auskunft unserer beiden Kieler Mitbewerber dort auch nicht.

4. Der alte Rollator wurde uns am 06.08. gezeigt: Holm gebrochen, Bremszug rechts gerissen, das Gerät ist von 2019 und eine Reparatur lohnt wirtschaftlich nicht mehr. Ich habe das mit Fotos für unsere Unterlagen dokumentiert und kann die Bilder bei Bedarf zusenden.

Wenn Sie für das Gerichtsverfahren eine förmliche Bestätigung zu einzelnen Punkten brauchen, sagen Sie mir bitte, in welcher Form.

Mit freundlichen Grüßen
Hendrik Paulsen
Orthopädietechniker und Rollstuhl-Fachberater
Sanitätshaus Reha-Aktiv-Nord GmbH, Holtenauer Straße 212, 24105 Kiel
Telefon 0431 88 07 44-12

Fallkonferenz Tannenberg — Workflow und Prüfmatrix

Aktenstand: 25.08.2026

Beteiligte Verfahren: Olaf Tannenberg, Lena Tannenberg, Margarete Tannenberg, Bodo Petersen

Zweck: interne Strukturierung für Fristenkontrolle, Widersprüche und mögliche Eilverfahren

1. Gesamtbild

Die Familie Tannenberg hat parallel mehrere sozialrechtliche Vorgänge in der Kanzlei. Die Verfahren liegen in verschiedenen Büchern des Sozialgesetzbuchs und betreffen unterschiedliche Behörden. Deshalb ist die erste Aufgabe nicht die Formulierung eines Schriftsatzes, sondern eine saubere Zuordnung nach Mandant, Leistungsträger, Anspruchsgrundlage, Frist und Beweisbedarf.

Mandant	Verfahren	SGB-Bereich	Primäre Aufgabe
Olaf Tannenberg	Aktivrollstuhl-Versorgung	SGB V	Hilfsmittelanspruch, Eilbedürftigkeit, ärztliche Begründung
Lena Tannenberg	Schulbegleitung	SGB VIII / IX	Teilhabe, Eingliederungshilfe, schulische Stellungnahmen
Margarete Tannenberg	Pflegegrad 3 auf 4	SGB XI	Pflegebegutachtung, Modulbewertung, Tagebuch
Bodo Petersen	volle Erwerbsminderungsrente	SGB VI	Leistungsvermögen, Reha-Berichte, Arbeitsmarktlage

2. Sofort-Triage

1. Für jeden Bescheid Bekanntgabeart, Zugang und Nachweis erfassen.
2. Für Olaf, Margarete und Bodo gilt beim Widerspruch Paragraf 84 SGG. Bei Lena gilt Paragraf 70 VwGO. Die Bekanntgabe des jeweiligen Sozialleistungsbescheids ist anhand von Paragraf 37 SGB X und des Zugangsbelegs zu prüfen.
3. Fristst atus rot/gelb/grün dokumentieren.
4. Fehlt eine Begründung: fristwahrenden Widerspruch sofort sichern.
5. Bei Olaf Klage und Eilrechtsschutz getrennt führen. Beide Schriftsätze wurden am 25.08.2026 eingereicht.

3. Prüfaufträge je Verfahren

Olaf Tannenberg — Hilfsmittel

- Attest Dr. Wallenstein gegen die Begründung der Krankenkasse legen.
- Die Eigenbedienung des beantragten Aktivrollstuhls mit der des angebotenen Standard-Faltrollstuhls vergleichen.
- Sturzrisiko, MS-Schübe und Wohnumfeld als Tatsachengrundlage herausarbeiten.
- Widerspruchsbescheid vom 18.08.2026, zugestellt am 21.08.2026. Hauptsache und Antrag auf vorläufige Versorgung nach Paragraf 86b Absatz 2 SGG gesondert erfassen.

Lena Tannenberg — Schulbegleitung

- Diagnose, KJP-Stellungnahme und Schulgutachten nebeneinander auswerten.
- Argument "gute Noten" vom Teilhabebedarf trennen.
- Selbstgefährdungs- und Belastungslage behutsam, aber konkret belegen.
- Anspruch gegen das Jugendamt nach Paragraf 35a SGB VIII einordnen. Nach einem ablehnenden Widerspruchsbescheid kommt die Verpflichtungsklage nach Paragraf 74 Absatz 1 und 2 VwGO beim Verwaltungsgericht Schleswig in Betracht.

Margarete Tannenberg — Pflegegrad

- Pflegetagebuch mit MD-Gutachten abgleichen.
- Modul 1 nach Schenkelhalsfraktur und Mobilität besonders prüfen.
- Aphasie und fehlende Eigenangaben als Beweiswürdigungsproblem markieren.
- Höherstufungsbegründung möglichst zahlen- und zeitnah fassen.

Bodo Petersen — Erwerbsminderungsrente

- DRV-Gutachten mit Reha-Bericht Bad Bramstedt 2024 vergleichen.
- Schmerz, Depression und körperliche Belastbarkeit zusammen bewerten.
- Arbeitsmarktrente und Berufsschutzfragen gesondert prüfen.
- PKH-Unterlagen parallel vorbereiten.

4. Kanzleiablauf

Schritt	Ergebnis
Fristenliste aktualisieren	eine Frist pro Bescheid plus Wiedervorlage Begründung
Anlagen sortieren	Bescheid, Gutachten, Attest, Mandantennotiz, Belege
Erstentwürfe erstellen	Widerspruch, Eilantrag Olaf, Mandantenbrief
Mandantensprache glätten	kurze Erklärung je Verfahren in einfacher Sprache
Strategie bündeln	eine Familienübersicht ohne Vermischung der Verfahren

5. Offene Entscheidungen

- Olaf: Erreichbares Leihgerät und Beschaffungszeit für das Eilverfahren belegen. Gerichtliche Aktenzeichen und Rückmeldung zur Übergangsversorgung nachhalten.
- Lena: Zusätzliche Schulstellungnahme oder kinder- und jugendpsychiatrische Ergänzung?
- Margarete: Pflegeberatung einschalten und Tagebuch nachführen lassen?
- Bodo: Fachärztliches Zusatzattest vor Widerspruchsbegründung einholen?

6. Schlussnotiz

Die Verfahren dürfen nicht in einer Sammelklage vermischt werden. Effizient ist aber eine gemeinsame Kanzleimatrix: gleicher Fristenstandard, gleiche Anlagenlogik, gleiche Verständlichkeitsstufe in Mandantenbriefen und eine klare Trennung der Leistungsträger.

Familien-Stammbaum Tannenberg / Petersen

Übersicht

Heinz Tannenberg ⚭ Margarete Tannenberg geb. Stoltenberg

1939 +2019 **04.07.1941, PG 3**

Verfahren Pflegekasse AOK NW

+----------+

Olaf Tannenberg **Jörn Tannenberg**

17.02.1964 **1961 +2014**

Schiffbau-Ing. a.D. war verheiratet mit

MS seit 1998, PG 2 Karin Petersen *1959

Verfahren Rollstuhl BKK |

	(Schwester von)
⚭ seit 1998	
Bodo Petersen	

Bertha Tannenberg *11.05.1964

geb. Wienholz Ex-Maurer, BS-Vorfall + Depression

*14.06.1972 Verfahren EM-Rente DRV

Heilerziehungspflegerin TZ Lebenspartnerin: Karin Lorenzen *1967

pflegt Schwiegermutter Mutter: Inge Petersen geb. Olausen *1942

Lena Tannenberg

*03.09.2009

Asperger-Syndrom F84.5

Verfahren Schulbegleitung Jugendamt

Lebensverhältnisse

Haushalt 1 - Adelheidstraße 17, 24103 Kiel

- Olaf Tannenberg (62) + Bertha Tannenberg (53) + Tochter Lena (16) + Mutter Margarete (84)
- Vier-Personen-Haushalt
- Olaf bekommt Erwerbsminderungsrente seit 2022
- Bertha arbeitet 15 Stunden/Woche als Heilerziehungspflegerin, sonst pflegt sie Margarete
- Lena ist Schülerin Klasse 10 Gelehrtenschule Kiel
- Margarete wohnt seit 09/2024 nach Schlaganfall im Haushalt, davor selbständig

Haushalt 2 - Knooper Weg 184, 24118 Kiel

- Bodo Petersen (62) + Lebenspartnerin Karin Lorenzen (59)
- Zwei-Personen-Haushalt
- Karin Lorenzen arbeitet als Pflegekraft Vollzeit Diakoniezentrum
- Bodo bezieht aufstockendes Bürgergeld, ggf. ab 06/2026 anteilige EM-Rente

Verbindungen zwischen den Verfahren

- Bodo Petersen wird in der Familie als Olafs **Schwager** bezeichnet. Genau genommen läuft die Verbindung über eine andere Linie: Olafs verstorbener Bruder Jörn war mit Bodos Schwester Karin Petersen verheiratet.

- Zwei Frauen namens Karin: **Karin Petersen** (Bodos Schwester, Witwe von Jörn) und **Karin Lorenzen** (Bodos Lebenspartnerin). In Telefonnotizen der Kanzlei wird deshalb stets der Nachname mitgeführt.
- Für die Fallbearbeitung genügt: Bodo gehört familiär dazu und kam über Olaf in dieselbe Kanzlei.

Mandatsverhältnis Kanzlei Holm

- **Rechtsanwalt Lasse Holm**, Fachanwalt für Sozialrecht, Kanzlei Holm · Petersen · Sönnichsen Rechtsanwälte mbB, Holstenstraße 124, 24103 Kiel
- Der Namenspartner Petersen der Kanzlei ist mit dem Mandanten Bodo Petersen weder verwandt noch verschwägert; der gleiche Nachname ist Zufall und wird in der Akte bewusst vermerkt, um Verwechslungen zu vermeiden.
- Kontakt zur Familie über Olaf Tannenberg (Mandant seit 2022)
- Mandat für Lena erteilt durch beide Eltern (Bertha + Olaf)
- Mandat für Margarete erteilt durch Bertha als Bevollmächtigte (Vorsorgevollmacht 2023)
- Mandat für Bodo erteilt durch Bodo selbst (Vermittlung durch Olaf)

Vier verschiedene Versicherungsstände

Mandant	Krankenkasse	Pflegekasse	Rentenversicherer
Olaf	Nordsee-BKK	BKK Pflege	DRV Nord
Bertha	AOK NW (Familienvers.)	-	DRV Nord
Lena	AOK NW (Familienvers.)	-	-
Margarete	AOK NW	AOK NW Pflegekasse	DRV Nord (Witwenrente)
Bodo	AOK NW (Bürgergeld)	-	DRV Nord

Vermögens- und Einkommenssituation (für PKH-Prüfung)

Mandant	Monatseinkommen netto	Verfügbar für PKH	PKH-Indikation
Olaf (Familie)	EM-Rente 1.420 + Bertha 850 = 2.270 EUR + KG Lena 250	Familieneinkommen relativ hoch	wahrscheinlich keine PKH
Lena (Eltern)	s. Olaf	s. Olaf	wahrscheinlich Rechtsschutz - PKH nur hilfsweise
Margarete	Witwenrente 980 + Pflegegeld 545 PG 3	knapp	grenzwertig
Bodo (Haushalt)	Karin Lorenzen 1.650 + ALG-Aufstockung Bodo 200	sehr eng	PKH klar indiziert

Vorschau: Fristen_Familie_Tannenberg

Markdown-Vorschau der gleichnamigen XLSX-Datei. Berechnungen, Formeln und Formatierung nur im Original.

Sheet: Fristen-Familie-Tannenberg

Fristenübersicht Familie Tannenberg - alle 4 Verfahren

Kanzlei Holm · Petersen · Sönnichsen Rechtsanwälte mbB, RA Lasse Holm, Holstenstraße 124, 24103 Kiel - Stand 25. August 2026

Mandant	Sache	Behörde / Gericht	Bescheid vom	Zugang	Fristende	Fristart	Status
Olaf Tannenberg	Aktivrollstuhlversorgung SGB V	Nordsee-BKK	18.04.2026	21.04.2026	21.05.2026	Widerspruch Paragraf 84 SGG	Widerspruch eingelegt 20.05.2026
Olaf Tannenberg	Klage auf Aktivrollstuhlversorgung	SG Kiel	18.08.2026	21.08.2026	21.09.2026	Klage Paragraf 87 Absatz 2 SGG	Klage eingereicht 25.08.2026
Olaf Tannenberg	Eilantrag wegen Versorgungslücke	SG Kiel	-	-	Keine feste Antragsfrist	einstweilige Anordnung Paragraf 86b SGG	Antrag eingereicht 25.08.2026
Lena Tannenberg (Eltern)	Schulbegleitung Eingliederungshilfe SGB VIII	Jugendamt Kiel	12.03.2026	14.03.2026	14.04.2026	Widerspruch Paragraf 70 VwGO	Widerspruchsentwurf 05.04.2026, eingereicht 06.04.2026
Lena Tannenberg (Eltern)	Verpflichtungsklage wegen Schulbegleitung	Verwaltungsgericht Schleswig	-	-	Ein Monat nach Zustellung des Widerspruchsbescheids	Klage Paragraf 74 Absatz 1 und 2 VwGO	Widerspruchsbescheid steht aus
Margarete Tannenberg	Pflegegrad-Höherstufung 3 auf 4 SGB XI	AOK Nord-West Pflegekasse	05.04.2026	08.04.2026	08.05.2026	Widerspruch Paragraf 84 SGG	Widerspruchsentwurf 28.04.2026
Bodo Petersen	Volle EM-Rente SGB VI	DRV Nord Lübeck	15.04.2026	18.04.2026	18.05.2026	Widerspruch Paragraf 84 SGG	Widerspruchsentwurf 02.05.2026
Bodo Petersen	PKH ggf SG-Klage	SG Kiel	-	-	mit Klageerhebung	PKH Paragraf 73a SGG	vorbereitet, Einkommensbeleg noch ausstehend

Sheet: Verfahrensverlauf

Verfahrensverlauf - chronologische Sicht über alle vier Verfahren

Datum	Verfahren	Akteur	Ereignis	Konsequenz / nächster Schritt
08.02.2026	Lena Schulbegleitung	Gelehrtenschule	Schulgutachten erstellt	Anlage zu späterem Widerspruch

22.02.2026	Lena Schulbegleitung	Dr. Maibaum KJP	Fachärztliche Stellungnahme	Hauptbegründung
27.02.2026	Bodo EM-Rente	Dr. Brunsbüttel DRV	Sozialmed. Gutachten Untersuchung	später Grundlage für Ablehnung
12.03.2026	Lena Schulbegleitung	Jugendamt Kiel	Bescheid - Antrag abgelehnt	Widerspruchsfrist 14.04.2026
18.03.2026	Margarete Pflegegrad	MD Nord (Wendelaar)	Pflegegutachten Hausbesuch	Grundlage Ablehnung
25.03.2026	Margarete Pflegegrad	Dr. Petersen Hausarzt	Hausärztl. Stellungnahme	Hauptbegründung Widerspruch
05.04.2026	Lena Schulbegleitung	Kanzlei Holm	Widerspruchsentwurf fertig	Versand
05.04.2026	Margarete Pflegegrad	AOK Pflegekasse	Bescheid - Höherstufung abgelehnt	Widerspruchsfrist 08.05.2026
06.04.2026	Bodo EM-Rente	Dr. Lornsen-Joost	Psychiatrisches Attest	Hauptbegründung
15.04.2026	Bodo EM-Rente	DRV Nord Lübeck	Bescheid - volle EM abgelehnt	Widerspruchsfrist 18.05.2026
18.04.2026	Olaf Hilfsmittel	Nordsee-BKK	Ablehnungsbescheid Aktivrollstuhl	Widerspruchsfrist 21.05.2026
21.04.2026	Bodo EM-Rente	Kanzlei Holm	Erstgespräch, Mandat	Widerspruch vorbereiten
28.04.2026	Margarete Pflegegrad	Kanzlei Holm	Widerspruchsentwurf fertig	Versand
02.05.2026	Bodo EM-Rente	Kanzlei Holm	Widerspruchsentwurf fertig	Versand
20.05.2026	Olaf Hilfsmittel	Kanzlei Holm	Widerspruch eingelegt	Antwort BKK abwarten
18.08.2026	Olaf Hilfsmittel	Nordsee-BKK	Widerspruchsbescheid	Zustellung 21.08.2026 · Klagefrist bis 21.09.2026
25.08.2026	Olaf Hilfsmittel	SG Kiel	Klage und Eilantrag eingereicht	Aktenzeichen bei Versand noch offen

Fristenübersicht Familie Tannenberg - alle 4 Verfahren

Kanzlei Holm · Petersen · Sönnichsen, RA Lasse Holm, Holstenstraße 124, 24103 Kiel - Stand 25. August 2026

Mandant	Sache	Behörde / Gericht	Bescheid vom	Zugang	Fristende	Fristart	Status
Olaf Tannenberg	Aktivrollstuhlversorgung SGB V	Nordsee-BKK	18.04.2026	21.04.2026	21.05.2026	Widerspruch Paragraf 84 SGG	Widerspruch eingelegt 20.05.2026
Olaf Tannenberg	Klage auf Aktivrollstuhlversorgung	SG Kiel	18.08.2026	21.08.2026	21.09.2026	Klage Paragraf 87 Absatz 2 SGG	Klage eingereicht 25.08.2026
Olaf Tannenberg	Eilantrag wegen Versorgungslücke	SG Kiel	-	-	Keine feste Antragsfrist	einstweilige Anordnung Paragraf 86b SGG	Antrag eingereicht 25.08.2026
Lena Tannenberg (Eltern)	Schulbegleitung Eingliederungshilfe SGB VIII	Jugendamt Kiel	12.03.2026	14.03.2026	14.04.2026	Widerspruch Paragraf 70 VwGO	Widerspruchsentwurf 05.04.2026, eingereicht 06.04.2026
Lena Tannenberg (Eltern)	Verpflichtungsklage wegen Schulbegleitung	Verwaltungsgericht Schleswig	-	-	Ein Monat nach Zustellung des Widerspruchsbescheids	Klage Paragraf 74 Absatz 1 und 2 VwGO	Widerspruchsbescheid steht aus
Margarete Tannenberg	Pflegegrad-Höherstufung 3 auf 4 SGB XI	AOK Nord-West Pflegekasse	05.04.2026	08.04.2026	08.05.2026	Widerspruch Paragraf 84 SGG	Widerspruchsentwurf 28.04.2026
Bodo Petersen	Volle EM-Rente SGB VI	DRV Nord Lübeck	15.04.2026	18.04.2026	18.05.2026	Widerspruch Paragraf 84 SGG	Widerspruchsentwurf 02.05.2026
Bodo Petersen	PKH ggf SG-Klage	SG Kiel	-	-	mit Klageerhebung	PKH Paragraf 73a SGG	vorbereitet, Einkommensbeleg noch ausstehend

Verfahrensverlauf - chronologische Sicht über alle vier Verfahren

Datum	Verfahren	Akteur	Ereignis	Konsequenz / nächster Schritt
08.02.2026	Lena Schulbegleitung	Gelehrtenschule	Schulgutachten erstellt	Anlage zu späterem Widerspruch
22.02.2026	Lena Schulbegleitung	Dr. Maibaum KJP	Fachärztliche Stellungnahme	Hauptbegründung
27.02.2026	Bodo EM-Rente	Dr. Brunsbüttel DRV	Sozialmed. Gutachten Untersuchung	später Grundlage für Ablehnung
12.03.2026	Lena Schulbegleitung	Jugendamt Kiel	Bescheid - Antrag abgelehnt	Widerspruchsfrist 14.04.2026
18.03.2026	Margarete Pflegegrad	MD Nord (Wendelaar)	Pflegegutachten Hausbesuch	Grundlage Ablehnung
25.03.2026	Margarete Pflegegrad	Dr. Petersen Hausarzt	Hausärztl. Stellungnahme	Hauptbegründung Widerspruch
05.04.2026	Lena Schulbegleitung	Kanzlei Holm	Widerspruchsentwurf fertig	Versand
05.04.2026	Margarete Pflegegrad	AOK Pflegekasse	Bescheid - Höherstufung abgelehnt	Widerspruchsfrist 08.05.2026
06.04.2026	Bodo EM-Rente	Dr. Lornsen-Joost	Psychiatrisches Attest	Hauptbegründung
15.04.2026	Bodo EM-Rente	DRV Nord Lübeck	Bescheid - volle EM abgelehnt	Widerspruchsfrist 18.05.2026
18.04.2026	Olaf Hilfsmittel	Nordsee-BKK	Ablehnungsbescheid Aktivrollstuhl	Widerspruchsfrist 21.05.2026
21.04.2026	Bodo EM-Rente	Kanzlei Holm	Erstgespräch, Mandat	Widerspruch vorbereiten
28.04.2026	Margarete Pflegegrad	Kanzlei Holm	Widerspruchsentwurf fertig	Versand
02.05.2026	Bodo EM-Rente	Kanzlei Holm	Widerspruchsentwurf fertig	Versand
20.05.2026	Olaf Hilfsmittel	Kanzlei Holm	Widerspruch eingelegt	Antwort BKK abwarten
18.08.2026	Olaf Hilfsmittel	Nordsee-BKK	Widerspruchsbescheid	Zustellung 21.08.2026 · Klagefrist bis 21.09.2026
25.08.2026	Olaf Hilfsmittel	SG Kiel	Klage und Eilantrag eingereicht	Aktenzeichen bei Versand noch offen